MANUALE CLINICO

ATM nella Pratica Clinica

101 protocolli riabilitativi

Valutazione secondo i criteri DC/TMD, terapia manuale, trattamento miofasciale, esercizio terapeutico e integrazione cranio-cervicale.

PER FISIOTERAPISTI

Indice

Modulo 1 · Valutazione e ragionamento clinico

1 Anamnesi strutturata nel paziente con DTM
2 Screening delle red flags nel dolore orofacciale
3 Esame dei movimenti mandibolari secondo DC/TMD
4 Palpazione dei muscoli masticatori secondo DC/TMD
5 Palpazione dell'articolazione temporomandibolare
6 Valutazione dei rumori articolari
7 Test di provocazione funzionale dell'ATM
8 Valutazione del rachide cervicale nel paziente con DTM
9 Valutazione psicosociale (Asse II)
10 Classificazione clinica del quadro DC/TMD
11 Misure di esito e follow-up
12 Comunicazione con odontoiatra e gnatologo

Modulo 2 · Gestione del dolore e autogestione

13 Educazione al dolore nei DTM
14 Autogestione nella fase acuta
15 Termoterapia superficiale
16 Crioterapia nel dolore articolare acuto
17 TENS per il dolore orofacciale
18 Rilassamento della mandibola
19 Respirazione diaframmatica
20 Posizione di riposo della lingua
21 Terapia manuale delicata nella fase acuta
22 Massaggio superficiale del massetere e del temporale
23 Gestione delle parafunzioni diurne
24 Igiene del sonno nel paziente con DTM

Modulo 3 · Terapia manuale articolare

25 Mobilizzazione in distrazione caudale dell'ATM
26 Scivolamento anteriore del condilo
27 Scivolamento mediale e laterale dell'ATM
28 Distrazione con apertura progressiva
29 Mobilizzazione con movimento in apertura
30 Mobilizzazione con movimento in lateralità
31 Gestione dello spostamento discale con riduzione
32 Gestione dello spostamento discale senza riduzione
33 Automobilizzazione assistita dell'ATM
34 Mobilizzazione dopo chirurgia dell'ATM
35 Mobilizzazione bilaterale simultanea
36 Mobilizzazione in posizione seduta
37 Compressione e decompressione articolare controllata
38 Trazione cranio-mandibolare globale

Modulo 4 · Trattamento miofasciale e trigger point

39 Trigger point del massetere
40 Trigger point del temporale
41 Trigger point dello pterigoideo mediale
42 Trigger point dello pterigoideo laterale
43 Trigger point del digastrico
44 Trigger point dello sternocleidomastoideo
45 Trigger point del trapezio superiore
46 Rilascio dei muscoli suboccipitali
47 Allungamento passivo del massetere
48 Allungamento del temporale
49 Rilascio miofasciale della fascia temporale
50 Massaggio intraorale del massetere
51 Rilascio dei muscoli sopraioidei
52 Contrazione e rilassamento dei muscoli elevatori
53 Inibizione reciproca dei muscoli elevatori

Modulo 5 · Esercizio terapeutico e controllo motorio

54 Programma di esercizi 6 x 6
55 Apertura con lingua al palato
56 Apertura controllata allo specchio
57 Coordinazione in lateralità
58 Protrusione e retrusione controllate
59 Stabilizzazione isometrica in apertura
60 Stabilizzazione isometrica in chiusura
61 Stabilizzazione isometrica in lateralità
62 Esercizi contro resistenza progressiva
63 Allenamento propriocettivo mandibolare
64 Correzione della deviazione in apertura
65 Esercizio eccentrico in chiusura
66 Autoallungamento in apertura
67 Controllo della postura linguale in deglutizione
68 Apertura progressiva con abbassalingua
69 Programma domiciliare progressivo in 3 fasi

Modulo 6 · Integrazione cranio-cervicale e vestibolare

70 Test di flessione cranio-cervicale
71 Allenamento dei flessori profondi del collo
72 Mobilizzazione occipito-atlantoidea (C0–C1)
73 Mobilizzazione atlanto-assiale (C1–C2)
74 Retrazione cervicale e allungamento assiale
75 Rinforzo dei muscoli scapolari
76 Correzione posturale al lavoro
77 Rilascio e mobilità cervicale globale
78 Esercizi oculomotori
79 Stabilità dello sguardo e equilibrio
80 Trattamento della cefalea cervicogenica associata
81 Integrazione mandibola e collo nel movimento
82 Respirazione e postura cervicale
83 Valutazione e gestione dei DTM dopo colpo di frusta

Modulo 7 · Casi complessi e dolore persistente

84 Bruxismo da veglia
85 Bruxismo nel sonno
86 Acufene somatosensoriale associato ai DTM
87 Cefalea di tipo tensivo associata ai DTM
88 Desensibilizzazione nel dolore persistente
89 Esposizione graduale al movimento mandibolare
90 Gestione dello stress nel paziente con DTM
91 Ipermobilità e lussazione ricorrente dell'ATM
92 Artrosi dell'ATM (malattia degenerativa)
93 ATM nelle artriti infiammatorie
94 Trisma dopo trattamenti oncologici del distretto testa collo
95 DTM in età adolescenziale
96 DTM durante il trattamento ortodontico
97 Riconoscere il dolore orofacciale neuropatico
98 Gestione della riacutizzazione
99 Collaborazione per la placca occlusale
100 DTM nei musicisti e nei professionisti della voce
101 Dimissione e prevenzione delle recidive

Avvertenza. I protocolli sono strumenti di supporto al ragionamento clinico e non sostituiscono la valutazione individuale del paziente da parte del professionista.

Come usare il manuale

1. Valuta il paziente con il Modulo 1 e le checklist.
2. Individua il profilo prevalente con la Mappa di valutazione (Bonus 1).
3. Scegli i protocolli dei moduli corrispondenti.
4. Rivaluta ogni 4 sedute con i criteri indicati in ogni protocollo.

PROTOCOLLO 1

Anamnesi strutturata nel paziente con DTM

Raccogliere in modo ordinato i dati che orientano diagnosi e trattamento

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Prima seduta	Tutti i quadri	15 a 20 minuti	Prima visita

Indicazioni

- ✓ Primo accesso del paziente con dolore orofacciale
- ✓ Invio da odontoiatra, gnatologo o medico
- ✓ Ripresa del trattamento dopo una lunga pausa

Controindicazioni e precauzioni

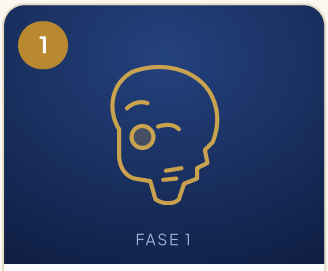
- ! Calo di peso, febbre o tumefazione non spiegati
- ! Deficit neurologici o parestesie del volto
- ! Trisma progressivo o storia oncologica del distretto testa collo
- ! Dolore che non varia con la funzione mandibolare

Posizionamento

Paziente: seduto, in un ambiente tranquillo, con tempo sufficiente per raccontare la propria storia.

Fisioterapista: di fronte al paziente, con la scheda anamnestica e il modulo del consenso informato.

Esecuzione passo dopo passo



Motivo della visita

Chiedi il problema principale con parole del paziente e da quanto tempo è presente.



Caratteristiche del dolore

Sede, intensità, andamento nella giornata, fattori che aggravano e alleviano.



Funzione

Indaga masticazione, apertura, rumori, blocchi e abitudini parafunzionali.



Contesto

Sonno, stress, cefalea, sintomi cervicali, terapie dentali e farmaci in corso.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Strumento	Scheda anamnestica DTM e diagramma del dolore
Tempo	15 a 20 minuti
Aggiornamento	a ogni rivalutazione

Criteri di rivalutazione

DIAGNOSI DC/TMD	LIVELLO DI DOLORE	IMPATTO PSICOSOCIALE
_____	____ / 10	Basso / Alto
asse I	attuale e medio	asse II

Punti chiave

- ✓ Lascia raccontare il paziente prima di fare domande chiuse
- ✓ Registra il dolore con una scala numerica da 0 a 10
- ✓ Annota sempre le terapie odontoiatriche in corso

Errori da evitare

- ! Partire subito dall'esame fisico
- ! Trascurare sonno, stress e cefalea
- ! Non chiedere i sintomi nelle ultime 30 giornate

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Diario dei sintomi	Annotare dolore, rumori e situazioni scatenanti ogni sera	per 7 giorni prima della seconda seduta

! **Nota clinica.** Un'anamnesi accurata permette di formulare già un'ipotesi del quadro DC/TMD prima dell'esame fisico.

Bibliografia essenziale

1. Schiffman E. et al. Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (DC/TMD) for clinical and research applications. J Oral Facial Pain Headache. 2014;28(1):6–27.
2. Ohrbach R., Dworkin S.F. The evolution of TMD diagnosis: past, present, future. J Dent Res. 2016;95(10):1093–1101.

PROTOCOLLO 2

Screening delle red flags nel dolore orofacciale

Escludere condizioni che richiedono un invio medico prima del trattamento

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Prima seduta	Diagnosi differenziale	5 minuti	Prima visita e se cambiano i sintomi

Indicazioni

- ✓ Ogni nuovo paziente con dolore orofacciale
- ✓ Peggioramento improvviso dei sintomi
- ✓ Mancata risposta al trattamento dopo 4 a 6 sedute

Controindicazioni e precauzioni

- ! Calo di peso, febbre o tumefazione non spiegati
- ! Deficit neurologici o parestesie del volto
- ! Trisma progressivo o storia oncologica del distretto testa collo
- ! Dolore che non varia con la funzione mandibolare

Posizionamento

Paziente: seduto, dopo l'anamnesi.

Fisioterapista: con la checklist delle red flags a portata di mano.

Esecuzione passo dopo passo

1



FASE 1

Sintomi sistemici

Febbre, calo di peso, sudorazione notturna, astenia marcata.

2



FASE 2

Segni neurologici

Parestesie, deficit dei nervi cranici, disturbi visivi o della deglutizione.

3



FASE 3

Segni locali

Tumefazioni, linfonodi aumentati, trisma progressivo, malocclusione improvvisa.

4



FASE 4

Decisione

In presenza di red flags sospendi e invia al medico o allo specialista.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Strumento	Checklist red flags del kit
Tempo	5 minuti
Ripetizione	se compaiono nuovi sintomi

Criteri di rivalutazione

DIAGNOSI DC/TMD	LIVELLO DI DOLORE	IMPATTO PSICOSOCIALE
_____	____ / 10	Basso / Alto
asse I	attuale e medio	asse II

Punti chiave

- ✓ Il dolore dei DTM varia con la funzione mandibolare
- ✓ Un dolore costante e non meccanico va approfondito
- ✓ Documenta sempre l'esito dello screening

Errori da evitare

- ! Trattare prima di aver escluso le red flags
- ! Attribuire ogni dolore del volto all'ATM
- ! Non comunicare al paziente il motivo dell'invio

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Monitoraggio dei segnali	Contattare il fisioterapista in caso di febbre, gonfiore o formicolii	per tutta la durata del percorso

! **Nota clinica.** Arterite a cellule giganti, neoplasie e nevralgie possono simulare un DTM: in caso di dubbio l'invio è sempre la scelta più sicura.

Bibliografia essenziale

1. Schiffman E. et al. Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (DC/TMD) for clinical and research applications. J Oral Facial Pain Headache. 2014;28(1):6–27.
2. Ohrbach R., Dworkin S.F. The evolution of TMD diagnosis: past, present, future. J Dent Res. 2016;95(10):1093–1101.

PROTOCOLLO 3

Esame dei movimenti mandibolari secondo DC/TMD

Misurare apertura, lateralità e protrusione con metodo standardizzato

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Prima seduta e rivalutazioni	Tutti i quadri	10 minuti	Valutazione iniziale e ogni 4 sedute

Indicazioni

- ✓ Valutazione iniziale
- ✓ Monitoraggio dei progressi
- ✓ Confronto prima e dopo una tecnica

Controindicazioni e precauzioni

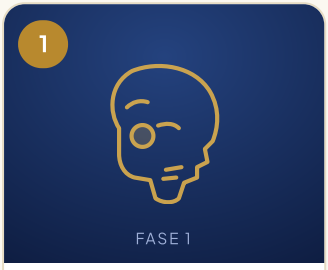
- ! Calo di peso, febbre o tumefazione non spiegati
- ! Deficit neurologici o parestesie del volto
- ! Trisma progressivo o storia oncologica del distretto testa collo
- ! Dolore che non varia con la funzione mandibolare

Posizionamento

Paziente: seduto, schiena appoggiata, capo in posizione neutra.

Fisioterapista: di fronte al paziente con calibro o righello millimetrato.

Esecuzione passo dopo passo



Apertura senza dolore

Il paziente apre fino al primo dolore: misura la distanza interincisale.



Apertura massima attiva

Apertura massima anche con dolore: misura e chiedi la sede del dolore.



Apertura passiva

Con delicatezza aumenta l'apertura: misura e valuta la sensazione di fine corsa.



Lateralità e protrusione

Misura le escursioni destra, sinistra e in avanti.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Valori di riferimento	apertura massima superiore a 40 mm
Strumento	calibro o righello
Registrazione	aggiungere l'overbite verticale

Criteri di rivalutazione

DIAGNOSI DC/TMD	LIVELLO DI DOLORE	IMPATTO PSICOSOCIALE
_____	____ / 10	Basso / Alto
asse I	attuale e medio	asse II

Punti chiave

- ✓ Usa sempre la stessa procedura per confronti affidabili
- ✓ Chiedi se il dolore è familiare
- ✓ Annota la deviazione o la deflessione

Errori da evitare

- ! Non sommare l'overbite alla misura
- ! Forzare l'apertura passiva
- ! Misurare con il paziente in tensione

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Automisurazione	Misurare l'apertura con tre dita sovrapposte davanti allo specchio	1 volta al giorno

! **Nota clinica.** La differenza tra apertura attiva e passiva aiuta a distinguere una limitazione muscolare da una articolare.

Bibliografia essenziale

1. Schiffman E. et al. Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (DC/TMD) for clinical and research applications. J Oral Facial Pain Headache. 2014;28(1):6–27.
2. Ohrbach R., Dworkin S.F. The evolution of TMD diagnosis: past, present, future. J Dent Res. 2016;95(10):1093–1101.

PROTOCOLLO 4

Palpazione dei muscoli masticatori secondo DC/TMD

Identificare la mialgia e il dolore riferito con pressione standardizzata

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Prima seduta	Mialgia, dolore miofasciale	10 minuti	Valutazione iniziale

Indicazioni

- ✓ Sospetto dolore di origine muscolare
- ✓ Dolore temporale o mandibolare diffuso
- ✓ Cefalea attribuita a DTM

Controindicazioni e precauzioni

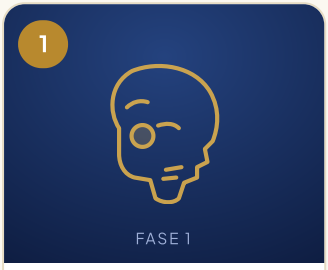
- ! Calo di peso, febbre o tumefazione non spiegati
- ! Deficit neurologici o parestesie del volto
- ! Trisma progressivo o storia oncologica del distretto testa collo
- ! Dolore che non varia con la funzione mandibolare

Posizionamento

Paziente: seduto, capo appoggiato, muscolatura rilassata.

Fisioterapista: dietro o di fronte al paziente, polpastrelli di indice e medio.

Esecuzione passo dopo passo



Temporale

Palpa tre zone (anteriore, media, posteriore) con pressione di circa 1 kg per 2 secondi.



Massetere

Palpa origine, corpo e inserzione con la stessa pressione.



Dolore riferito

Mantieni 5 secondi e chiedi se il dolore si estende ad altre zone.



Familiarità

Chiedi se il dolore provocato è simile a quello abituale.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Pressione	circa 1 kg (calibrare con una bilancia)
Durata	2 secondi, 5 secondi per il riferito
Ordine	temporale, massetere, poi zone accessorie

Criteri di rivalutazione

DIAGNOSI DC/TMD	LIVELLO DI DOLORE	IMPATTO PSICOSOCIALE
_____	____ / 10	Basso / Alto
asse I	attuale e medio	asse II

Punti chiave

- ✓ Allena la pressione con una bilancia da cucina
- ✓ Confronta sempre i due lati
- ✓ Il dolore familiare conferma la diagnosi

Errori da evitare

- ! Pressione variabile tra una seduta e l'altra
- ! Interpretare ogni dolorabilità come diagnosi
- ! Dimenticare di chiedere il dolore riferito

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Autopalpazione guidata	Riconoscere i punti dolenti del massetere e del temporale	2 volte al giorno, 30 secondi per lato

! **Nota clinica.** Secondo DC/TMD la diagnosi di mialgia richiede dolore familiare alla palpazione o ai movimenti, non la sola dolorabilità.

Bibliografia essenziale

1. Schiffman E. et al. Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (DC/TMD) for clinical and research applications. J Oral Facial Pain Headache. 2014;28(1):6–27.
2. Ohrbach R., Dworkin S.F. The evolution of TMD diagnosis: past, present, future. J Dent Res. 2016;95(10):1093–1101.

PROTOCOLLO 5

Palpazione dell'articolazione temporomandibolare

Valutare l'artralgia con palpazione del polo laterale e attorno al condilo

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Prima seduta	Artralgia	5 minuti	Valutazione iniziale e rivalutazioni

Indicazioni

- ✓ Dolore preauricolare
- ✓ Dolore in apertura ampia o masticazione
- ✓ Sospetto di infiammazione articolare

Controindicazioni e precauzioni

- ! Calo di peso, febbre o tumefazione non spiegati
- ! Deficit neurologici o parestesie del volto
- ! Trisma progressivo o storia oncologica del distretto testa collo
- ! Dolore che non varia con la funzione mandibolare

Posizionamento

Paziente: seduto, capo stabile, mandibola rilassata.

Fisioterapista: di fronte al paziente, indici davanti al trago.

Esecuzione passo dopo passo

1



FASE 1

Polo laterale

Palpa il polo laterale con circa 0,5 kg a bocca chiusa.

2



FASE 2

In protrusione

Ripeti chiedendo una leggera protrusione.

3



FASE 3

Attorno al polo

Palpa con circa 1 kg muovendo il dito attorno al condilo.

4



FASE 4

Familiarità

Chiedi se il dolore riproduce quello abituale.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Pressione	0,5 kg sul polo laterale, 1 kg attorno
Durata	2 secondi per punto
Confronto	sempre bilaterale

Criteri di rivalutazione

DIAGNOSI DC/TMD	LIVELLO DI DOLORE	IMPATTO PSICOSOCIALE
_____	____ / 10	Basso / Alto
asse I	attuale e medio	asse II

Punti chiave

- ✓ Il dolore familiare conferma l'artralgia
- ✓ Evita di palpare il condotto uditivo
- ✓ Annota il lato più sintomatico

Errori da evitare

- ! Pressione eccessiva sul polo laterale
- ! Confondere con dolore auricolare
- ! Trascurare l'ispezione di gonfiore

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Riposo funzionale	Evitare cibi duri e aperture ampie nei giorni di maggior dolore	secondo necessità

! **Nota clinica.** Un'artralgia isolata risponde spesso a gestione autonoma e terapia manuale delicata.

Bibliografia essenziale

1. Schiffman E. et al. Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (DC/TMD) for clinical and research applications. J Oral Facial Pain Headache. 2014;28(1):6–27.
2. Ohrbach R., Dworkin S.F. The evolution of TMD diagnosis: past, present, future. J Dent Res. 2016;95(10):1093–1101.

PROTOCOLLO 6

Valutazione dei rumori articolari

Classificare click e crepitii e collegarli allo stato del disco

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Prima seduta	Spostamento discale, artrosi	5 minuti	Valutazione iniziale

Indicazioni

- ✓ Click riferiti dal paziente
- ✓ Episodi di blocco in chiusura o apertura
- ✓ Crepitio durante la masticazione

Controindicazioni e precauzioni

- ! Calo di peso, febbre o tumefazione non spiegati
- ! Deficit neurologici o parestesie del volto
- ! Trisma progressivo o storia oncologica del distretto testa collo
- ! Dolore che non varia con la funzione mandibolare

Posizionamento

Paziente: seduto, capo neutro.

Fisioterapista: di fronte al paziente, polpastrelli sui poli laterali.

Esecuzione passo dopo passo



Anamnesi del rumore

Chiedi se il paziente sente rumori negli ultimi 30 giorni.



Apertura e chiusura

Ripeti 3 cicli palpando e ascoltando.



Lateralità e protrusione

Ripeti durante i movimenti eccentrici.



Classificazione

Click reciproco, crepitio fine o grossolano, blocchi.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Cicli	3 aperture e chiusure
Movimenti	apertura, lateralità, protrusione
Registrazione	lato, fase e tipo di rumore

Criteri di rivalutazione

DIAGNOSI DC/TMD	LIVELLO DI DOLORE	IMPATTO PSICOSOCIALE
_____	____ / 10	Basso / Alto
asse I	attuale e medio	asse II

Punti chiave

- ✓ Un click senza dolore spesso non richiede trattamento
- ✓ Il crepitio grossolano orienta verso l'artrosi
- ✓ Annota se il click scompare in protrusione

Errori da evitare

- ! Allarmare il paziente per un click indolore
- ! Non distinguere click da crepitio
- ! Trascurare la storia di blocchi

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Osservazione del rumore	Annotare quando compare il click e se è doloroso	per 7 giorni

! **Nota clinica.** Il click reciproco che scompare in protrusione è tipico dello spostamento discale con riduzione.

Bibliografia essenziale

1. Schiffman E. et al. Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (DC/TMD) for clinical and research applications. J Oral Facial Pain Headache. 2014;28(1):6–27.
2. Ohrbach R., Dworkin S.F. The evolution of TMD diagnosis: past, present, future. J Dent Res. 2016;95(10):1093–1101.

PROTOCOLLO 7

Test di provocazione funzionale dell'ATM

Differenziare il dolore articolare da quello muscolare con test di carico

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Prima seduta	Diagnosi differenziale	5 minuti	Valutazione iniziale

Indicazioni

- ✓ Dubbio tra componente articolare e muscolare
- ✓ Dolore in masticazione
- ✓ Prima di impostare la terapia manuale

Controindicazioni e precauzioni

- ! Calo di peso, febbre o tumefazione non spiegati
- ! Deficit neurologici o parestesie del volto
- ! Trisma progressivo o storia oncologica del distretto testa collo
- ! Dolore che non varia con la funzione mandibolare

Posizionamento

Paziente: seduto, capo stabile.

Fisioterapista: di fronte al paziente con un abbassalingua o un rullo di cotone.

Esecuzione passo dopo passo

1



FASE 1

Morso unilaterale

Il paziente morde un abbassalingua da un lato: dolore controlaterale suggerisce componente articolare.

2



FASE 2

Morso bilaterale

Morso su due rulli: valuta la risposta muscolare.

3



FASE 3

Movimenti contro resistenza

Apertura e chiusura contro leggera resistenza.

4



FASE 4

Interpretazione

Confronta le risposte con l'esame palpatorio.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Ripetizioni	3 per test
Durata	5 secondi per contrazione
Intensità	moderata, mai massimale

Criteri di rivalutazione

DIAGNOSI DC/TMD	LIVELLO DI DOLORE	IMPATTO PSICOSOCIALE
_____	____ / 10	Basso / Alto
asse I	attuale e medio	asse II

Punti chiave

- ✓ Usa i test come supporto, non da soli
- ✓ Confronta sempre i due lati
- ✓ Registra quale test riproduce il dolore familiare

Errori da evitare

- ! Contrazioni massimali dolorose
- ! Interpretare un singolo test come diagnosi
- ! Eseguire i test in fase acuta intensa

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Masticazione controllata	Alternare il lato di masticazione con cibi morbidi	a ogni pasto

! **Nota clinica.** I test di carico aumentano la precisione del ragionamento clinico quando integrati con anamnesi e palpazione.

Bibliografia essenziale

1. Schiffman E. et al. Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (DC/TMD) for clinical and research applications. J Oral Facial Pain Headache. 2014;28(1):6–27.
2. Ohrbach R., Dworkin S.F. The evolution of TMD diagnosis: past, present, future. J Dent Res. 2016;95(10):1093–1101.

PROTOCOLLO 8

Valutazione del rachide cervicale nel paziente con DTM

Identificare il contributo cervicale ai sintomi orofacciali

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Prima seduta	DTM con dolore cervicale	10 minuti	Valutazione iniziale

Indicazioni

- ✓ Dolore cervicale associato
- ✓ Cefalea
- ✓ Postura con capo in avanti

Controindicazioni e precauzioni

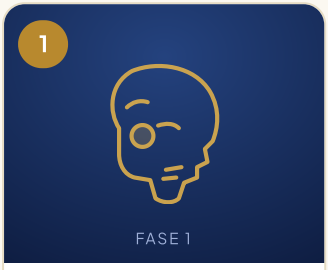
- ! Segni di insufficienza vascolare (vertigini, diplopia, disartria, disfagia)
- ! Instabilità cervicale sospetta (traumi, artrite reumatoide)
- ! Sintomi neurologici agli arti superiori
- ! Trauma cervicale recente non valutato dal medico

Posizionamento

Paziente: seduto e poi supino.

Fisioterapista: accanto al paziente, con goniometro o inclinometro.

Esecuzione passo dopo passo



Osservazione

Valuta postura del capo e delle spalle in piedi e seduto.



Mobilità attiva

Flessione, estensione, rotazioni e inclinazioni.



Test di flessione-rotazione

Valuta la rotazione C1-C2 in flessione completa.



Palpazione

Suboccipitali, trapezio superiore e sternocleidomastoideo.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Test flessione-rotazione	positivo sotto i 32° o differenza superiore a 10°
Strumento	goniometro
Tempo	10 minuti

Criteri di rivalutazione

DOLORE CERVICALE (NRS)

____ / 10

a riposo e in movimento

MOBILITÀ

____ °

rotazione o flessione

SINTOMI MANDIBOLARI

Migliorati / Invariati

dopo il trattamento

Punti chiave

- ✓ Il rachide cervicale influenza la posizione mandibolare
- ✓ Ricerca il dolore riferito al volto
- ✓ Annota i test positivi

Errori da evitare

- ! Trascurare il collo nel paziente con cefalea
- ! Testare la rotazione senza screening vascolare
- ! Valutare solo in posizione seduta

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Pause posturali	Interrompere ogni 45 minuti il lavoro al computer	durante la giornata lavorativa

! **Nota clinica.** Quando il collo contribuisce ai sintomi, integrare il trattamento cervicale migliora i risultati sui DTM.

Bibliografia essenziale

1. Schiffman E. et al. Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (DC/TMD) for clinical and research applications. J Oral Facial Pain Headache. 2014;28(1):6–27.
2. Ohrbach R., Dworkin S.F. The evolution of TMD diagnosis: past, present, future. J Dent Res. 2016;95(10):1093–1101.

PROTOCOLLO 9

Valutazione psicosociale (Asse II)

Misurare l'impatto del dolore e i fattori psicologici associati

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Prima seduta	Dolore persistente	10 minuti	Valutazione iniziale e finale

Indicazioni

- ✓ Dolore da oltre 3 mesi
- ✓ Elevato impatto sulla vita quotidiana
- ✓ Ansia o umore basso riferiti

Controindicazioni e precauzioni

- ! Calo di peso, febbre o tumefazione non spiegati
- ! Deficit neurologici o parestesie del volto
- ! Trisma progressivo o storia oncologica del distretto testa collo
- ! Dolore che non varia con la funzione mandibolare

Posizionamento

Paziente: seduto, con calma, dopo l'esame fisico.

Fisioterapista: accanto al paziente con i questionari.

Esecuzione passo dopo passo



Intensità e disabilità

Valuta intensità e interferenza del dolore nelle attività.



Ansia e umore

Usa strumenti di screening come il PHQ-4.



Parafunzioni

Indaga serramento, digrignamento e abitudini orali.



Restituzione

Condividi i risultati e, se necessario, proponi un invio.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Strumenti	scala del dolore, PHQ-4, checklist delle parafunzioni
Tempo	10 minuti
Ripetizione	a fine percorso

Criteri di rivalutazione

DIAGNOSI DC/TMD	LIVELLO DI DOLORE	IMPATTO PSICOSOCIALE
_____	____ / 10	Basso / Alto
asse I	attuale e medio	asse II

Punti chiave

- ✓ I fattori psicosociali influenzano la cronicità
- ✓ Usa un linguaggio non giudicante
- ✓ Collabora con lo psicologo quando indicato

Errori da evitare

- ! Saltare l'Asse II nei casi cronici
- ! Interpretare i punteggi come diagnosi psichiatriche
- ! Trascurare il sonno

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Diario dello stress	Annotare livello di stress e serramento durante la giornata	3 volte al giorno

! **Nota clinica.** Il modello DC/TMD integra Asse I (fisico) e Asse II (psicosociale): entrambi guidano il piano di trattamento.

Bibliografia essenziale

1. Schiffman E. et al. Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (DC/TMD) for clinical and research applications. J Oral Facial Pain Headache. 2014;28(1):6–27.
2. Ohrbach R., Dworkin S.F. The evolution of TMD diagnosis: past, present, future. J Dent Res. 2016;95(10):1093–1101.

PROTOCOLLO 10

Classificazione clinica del quadro DC/TMD

Sintetizzare i dati per definire il quadro e il percorso

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Fine della prima valutazione	Tutti i quadri	10 minuti	Prima visita

Indicazioni

- ✓ Al termine della valutazione
- ✓ Prima di comunicare con il medico o l'odontoiatra
- ✓ Alla rivalutazione

Controindicazioni e precauzioni

- ! Calo di peso, febbre o tumefazione non spiegati
- ! Deficit neurologici o parestesie del volto
- ! Trisma progressivo o storia oncologica del distretto testa collo
- ! Dolore che non varia con la funzione mandibolare

Posizionamento

Paziente: seduto, per la restituzione.

Fisioterapista: con i dati raccolti e lo schema decisionale.

Esecuzione passo dopo passo

1



FASE 1

Dolore

Mialgia, dolore miofasciale con riferito, artralgia, cefalea attribuita a DTM.

2



FASE 2

Disturbi articolari

Spostamento discale con o senza riduzione, malattia degenerativa, sublussazione.

3



FASE 3

Fattori associati

Cervicale, parafunzioni, Asse II.

4



FASE 4

Piano

Obiettivi, protocolli del kit e frequenza delle sedute.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Output	quadro principale e secondario
Obiettivi	SMART, condivisi
Rivalutazione	dopo 4 sedute

Criteri di rivalutazione

DIAGNOSI DC/TMD	LIVELLO DI DOLORE	IMPATTO PSICOSOCIALE
_____	____ / 10	Basso / Alto
asse I	attuale e medio	asse II

Punti chiave

- ✓ Spesso coesistono quadri muscolari e articolari
- ✓ Spiega la diagnosi con parole semplici
- ✓ Collega ogni obiettivo a un protocollo

Errori da evitare

- ! Etichettare il paziente senza spiegazioni
- ! Pianificare senza obiettivi misurabili
- ! Ignorare il quadro secondario

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Obiettivo personale	Scegliere un'attività significativa da recuperare	da verificare a ogni rivalutazione

! **Nota clinica.** Una classificazione chiara facilita il dialogo con odontoiatri e gnatologi e la scelta dei protocolli.

Bibliografia essenziale

1. Schiffman E. et al. Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (DC/TMD) for clinical and research applications. J Oral Facial Pain Headache. 2014;28(1):6–27.
2. Ohrbach R., Dworkin S.F. The evolution of TMD diagnosis: past, present, future. J Dent Res. 2016;95(10):1093–1101.

PROTOCOLLO 11

Misure di esito e follow-up

Monitorare i progressi con indicatori ripetibili

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Durante tutto il percorso	Tutti i quadri	5 minuti	Ogni 4 sedute

Indicazioni

- ✓ Verifica dell'efficacia del trattamento
- ✓ Decisione di dimissione
- ✓ Comunicazione dei risultati al paziente

Controindicazioni e precauzioni

- ! Calo di peso, febbre o tumefazione non spiegati
- ! Deficit neurologici o parestesie del volto
- ! Trisma progressivo o storia oncologica del distretto testa collo
- ! Dolore che non varia con la funzione mandibolare

Posizionamento

Paziente: seduto.

Fisioterapista: con la scheda di monitoraggio.

Esecuzione passo dopo passo



Dolore

Scala numerica attuale e peggiore della settimana.



Movimento

Apertura massima e senza dolore.



Funzione

Limitazione nella masticazione e nella vita quotidiana.



Confronto

Valuta il cambiamento rispetto alla valutazione iniziale.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Frequenza	ogni 4 sedute
Cambiamento rilevante	almeno 2 punti sulla scala del dolore
Apertura	aumento di almeno 5 mm

Criteri di rivalutazione

DIAGNOSI DC/TMD	LIVELLO DI DOLORE	IMPATTO PSICOSOCIALE
_____	____ / 10	Basso / Alto
asse I	attuale e medio	asse II

Punti chiave

- ✓ Mostra i progressi al paziente
- ✓ Modifica il piano se non ci sono miglioramenti
- ✓ Programma un controllo dopo la dimissione

Errori da evitare

- ! Valutare solo il dolore
- ! Non registrare i dati iniziali
- ! Proseguire senza miglioramenti

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Autovalutazione	Compilare la scala del dolore e della funzione	1 volta a settimana

! **Nota clinica.** Misure ripetibili rendono il percorso trasparente e aumentano l'aderenza del paziente.

Bibliografia essenziale

1. Schiffman E. et al. Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (DC/TMD) for clinical and research applications. J Oral Facial Pain Headache. 2014;28(1):6–27.
2. Ohrbach R., Dworkin S.F. The evolution of TMD diagnosis: past, present, future. J Dent Res. 2016;95(10):1093–1101.

PROTOCOLLO 12

Comunicazione con odontoiatra e gnatologo

Costruire un invio e una collaborazione efficaci

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Quando indicato	Gestione multidisciplinare	15 minuti	Secondo necessità

Indicazioni

- ✓ Sospetto problema occlusale o dentale
- ✓ Necessità di un bite
- ✓ Mancata risposta al trattamento

Controindicazioni e precauzioni

- ! Red flags non escluse dal medico
- ! Peggioramento rapido e non spiegato dei sintomi
- ! Condizioni sistemiche non controllate
- ! Assenza di consenso informato del paziente

Posizionamento

Paziente: informato e consenziente alla condivisione dei dati.

Fisioterapista: con relazione sintetica e dati di valutazione.

Esecuzione passo dopo passo



Consenso

Ottieni il consenso del paziente alla condivisione delle informazioni.



Relazione

Riporta quadro DC/TMD, misure e trattamento svolto.



Domanda chiara

Specifica cosa chiedi al collega.



Follow-up

Concorda come e quando aggiornarvi.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Formato	relazione di una pagina
Contenuto	diagnosi, misure, terapia, domanda
Tempi	risposta entro 2 settimane

Criteri di rivalutazione

LIMITAZIONE FUNZIONALE
____ / 10
masticare, parlare, sbadigliare

DOLORE (NRS)
____ / 10
peggiore della settimana

ADERENZA
____ %
esercizi svolti a casa

Punti chiave

- ✓ Usa la terminologia DC/TMD condivisa
- ✓ Sii sintetico e preciso
- ✓ Aggiorna il collega sui risultati

Errori da evitare

- ! Inviare senza una domanda precisa
- ! Condividere dati senza consenso
- ! Interrompere il trattamento in attesa

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Preparazione alla visita	Portare il diario dei sintomi alla visita specialistica	alla prima visita

! **Nota clinica.** La collaborazione strutturata con odontoiatri e gnatologi rafforza la tua posizione professionale e i risultati del paziente.

Bibliografia essenziale

1. Schiffman E. et al. Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (DC/TMD) for clinical and research applications. J Oral Facial Pain Headache. 2014;28(1):6–27.
2. Ohrbach R., Dworkin S.F. The evolution of TMD diagnosis: past, present, future. J Dent Res. 2016;95(10):1093–1101.

PROTOCOLLO 13

Educazione al dolore nei DTM

Spiegare il dolore per ridurre paura e ipervigilanza

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Acuta e subacuta	Mialgia, artralgia	10 a 15 minuti	Prime 3 sedute

Indicazioni

- ✓ Prima fase del trattamento
- ✓ Paura del movimento mandibolare
- ✓ Convinzioni errate sulla gravità del problema

Controindicazioni e precauzioni

- ! Red flags non escluse dal medico
- ! Peggioramento rapido e non spiegato dei sintomi
- ! Condizioni sistemiche non controllate
- ! Assenza di consenso informato del paziente

Posizionamento

Paziente: seduto, in un ambiente tranquillo.

Fisioterapista: di fronte al paziente, con materiale illustrato.

Esecuzione passo dopo passo



Esplora le convinzioni

Chiedi cosa pensa il paziente del suo dolore.



Spiega il meccanismo

Il dolore è un segnale di protezione, non sempre di danno.



Prognosi

La maggior parte dei DTM migliora con trattamento conservativo.



Piano condiviso

Definisci insieme obiettivi e strategie.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Durata	10 a 15 minuti
Supporto	schemi e metafore
Ripresa	a ogni seduta, 2 minuti

Criteri di rivalutazione

LIMITAZIONE FUNZIONALE
____ / 10
masticare, parlare, sbadigliare

DOLORE (NRS)
____ / 10
peggiore della settimana

ADERENZA
____ %
esercizi svolti a casa

Punti chiave

- ✓ Usa metafore semplici e positive
- ✓ Verifica la comprensione
- ✓ Collega l'educazione agli esercizi

Errori da evitare

- ! Usare termini allarmanti come usura o disco rotto
- ! Monologhi troppo tecnici
- ! Promettere guarigioni rapide

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Rilettura	Rileggere la scheda informativa consegnata	2 volte nella prima settimana

! **Nota clinica.** Spiegare il dolore riduce la catastrofizzazione ed è uno dei fattori che migliorano l'esito nel dolore persistente.

Bibliografia essenziale

1. List T., Jensen R.H. Temporomandibular disorders: old ideas and new concepts. Cephalalgia. 2017;37(7):692–704.
2. Moseley G.L., Butler D.S. Fifteen years of explaining pain: the past, present, and future. J Pain. 2015;16(9):807–813.

PROTOCOLLO 14

Autogestione nella fase acuta

Insegnare le strategie quotidiane per ridurre il carico sull'ATM

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Acuta e subacuta	Mialgia, artralgia	10 a 15 minuti	Prime 3 sedute

Indicazioni

- ✓ Dolore acuto o riacutizzazione
- ✓ Prime settimane di trattamento
- ✓ Pazienti con parafunzioni diurne

Controindicazioni e precauzioni

- ! Red flags non escluse dal medico
- ! Peggioramento rapido e non spiegato dei sintomi
- ! Condizioni sistemiche non controllate
- ! Assenza di consenso informato del paziente

Posizionamento

Paziente: seduto.

Fisioterapista: di fronte al paziente con la scheda di autogestione.

Esecuzione passo dopo passo



Dieta morbida
Cibi morbidi, piccoli bocconi, evitare gomme da masticare.



Riposo funzionale
Evitare aperture ampie e sbadigli forzati.



Posizione di riposo
Labbra chiuse, denti separati, lingua al palato.



Calore o freddo
Applicare secondo la preferenza e la fase.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Durata	2 a 3 settimane
Verifica	a ogni seduta
Supporto	scheda consegnata al paziente

Criteri di rivalutazione

LIMITAZIONE FUNZIONALE
____ / 10
masticare, parlare, sbadigliare

DOLORE (NRS)
____ / 10
peggiore della settimana

ADERENZA
____ %
esercizi svolti a casa

Punti chiave

- ✓ Le strategie semplici sono la base del trattamento
- ✓ Personalizza in base alle abitudini
- ✓ Rinforza i comportamenti corretti

Errori da evitare

- ! Prescrivere una dieta liquida prolungata
- ! Immobilizzare completamente la mandibola
- ! Consegnare indicazioni senza spiegazioni

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Promemoria della posizione di riposo	Controllare denti separati e lingua al palato	ogni ora con un promemoria

! **Nota clinica.** L'autogestione è raccomandata come primo intervento in quasi tutti i quadri di DTM.

Bibliografia essenziale

1. List T., Jensen R.H. Temporomandibular disorders: old ideas and new concepts. Cephalalgia. 2017;37(7):692–704.
2. Moseley G.L., Butler D.S. Fifteen years of explaining pain: the past, present, and future. J Pain. 2015;16(9):807–813.

PROTOCOLLO 15

Termoterapia superficiale

Ridurre la tensione muscolare e il dolore con il calore umido

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Acuta e subacuta	Mialgia, artralgia	15 minuti	Quotidiana

Indicazioni

- ✓ Mialgia dei masticatori
- ✓ Rigidità mattutina
- ✓ Prima degli esercizi

Controindicazioni e precauzioni

- ! Red flags non escluse dal medico
- ! Peggioramento rapido e non spiegato dei sintomi
- ! Condizioni sistemiche non controllate
- ! Assenza di consenso informato del paziente

Posizionamento

Paziente: supino o seduto, capo appoggiato.

Fisioterapista: accanto al paziente.

Esecuzione passo dopo passo



Preparazione
Asciugamano caldo umido o impacco a temperatura confortevole.



Applicazione
Sul massetere e sul temporale del lato dolente.



Durata
Mantieni per 10 a 15 minuti controllando la pelle.



Seguito
Esegui poi esercizi di apertura dolce.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Temperatura	calda, mai scottante
Tempo	10 a 15 minuti
Frequenza	2 o 3 volte al giorno

Criteri di rivalutazione

LIMITAZIONE FUNZIONALE
____ / 10
masticare, parlare, sbadigliare

DOLORE (NRS)
____ / 10
peggiore della settimana

ADERENZA
____ %
esercizi svolti a casa

Punti chiave

- ✓ Ideale prima della mobilizzazione
- ✓ Controlla la sensibilità cutanea
- ✓ Il calore umido penetra meglio

Errori da evitare

- ! Applicare su zone con sensibilità ridotta
- ! Usare calore in caso di gonfiore acuto
- ! Superare i 20 minuti

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Calore a domicilio	Impacco caldo umido seguito da 5 aperture lente	2 volte al giorno

! **Nota clinica.** Il calore è una strategia semplice che il paziente può gestire da solo e prepara al movimento.

Bibliografia essenziale

1. List T., Jensen R.H. Temporomandibular disorders: old ideas and new concepts. Cephalalgia. 2017;37(7):692–704.
2. Moseley G.L., Butler D.S. Fifteen years of explaining pain: the past, present, and future. J Pain. 2015;16(9):807–813.

PROTOCOLLO 16

Crioterapia nel dolore articolare acuto

Ridurre dolore e infiammazione articolare dopo sovraccarico

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Acuta	Artralgia	10 minuti	Fase acuta

Indicazioni

- ✓ Artralgia acuta
- ✓ Dolore dopo cure odontoiatriche prolungate
- ✓ Riacutizzazione dopo trauma minore

Controindicazioni e precauzioni

- ! Red flags non escluse dal medico
- ! Peggioramento rapido e non spiegato dei sintomi
- ! Condizioni sistemiche non controllate
- ! Assenza di consenso informato del paziente

Posizionamento

Paziente: seduto o supino.

Fisioterapista: accanto al paziente.

Esecuzione passo dopo passo



Protezione
Avvolgi il ghiaccio in un panno sottile.



Applicazione
Sulla regione preauricolare del lato dolente.



Durata
10 minuti, poi pausa di almeno 1 ora.



Controllo
Verifica la pelle e la sensibilità.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Tempo	10 minuti
Pausa	almeno 1 ora
Periodo	prime 48 a 72 ore

Criteri di rivalutazione

LIMITAZIONE FUNZIONALE
____ / 10
masticare, parlare, sbadigliare

DOLORE (NRS)
____ / 10
peggiore della settimana

ADERENZA
____ %
esercizi svolti a casa

Punti chiave

- ✓ Utile nelle prime 72 ore
- ✓ Non applicare direttamente sulla pelle
- ✓ Associa riposo funzionale

Errori da evitare

- ! Applicazioni troppo lunghe
- ! Uso in caso di fenomeno di Raynaud
- ! Freddo prima di esercizi di allungamento

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Ghiaccio a domicilio	Applicare 10 minuti protetto da un panno	fino a 3 volte al giorno

! **Nota clinica.** Il freddo modula il dolore acuto; nella fase subacuta il calore è spesso più indicato.

Bibliografia essenziale

1. List T., Jensen R.H. Temporomandibular disorders: old ideas and new concepts. Cephalalgia. 2017;37(7):692–704.
2. Moseley G.L., Butler D.S. Fifteen years of explaining pain: the past, present, and future. J Pain. 2015;16(9):807–813.

PROTOCOLLO 17

TENS per il dolore orofacciale

Modulare il dolore con stimolazione elettrica transcutanea

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	Mialgia	20 a 30 minuti	2 a 3 sedute a settimana

Indicazioni

- ✓ Dolore muscolare persistente
- ✓ Necessità di ridurre il dolore prima della terapia manuale
- ✓ Paziente che tollera bene l'elettroterapia

Controindicazioni e precauzioni

- ! Pacemaker o dispositivi elettronici impiantati
- ! Epilessia non controllata
- ! Lesioni cutanee nella zona
- ! Gravidanza: evitare l'applicazione

Posizionamento

Paziente: supino o seduto, capo appoggiato.

Fisioterapista: accanto al paziente con l'apparecchio TENS.

Esecuzione passo dopo passo



Screening
Escludi pacemaker, epilessia, lesioni cutanee e gravidanza.



Elettrodi
Posiziona sul massetere e sulla regione temporale.



Parametri
Frequenza alta, intensità confortevole senza contrazione.



Rivaluta
Misura dolore e apertura al termine.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Frequenza	80 a 100 Hz
Durata	20 a 30 minuti
Intensità	parestesia confortevole

Criteri di rivalutazione

LIMITAZIONE FUNZIONALE	DOLORE (NRS)	ADERENZA
____ / 10	____ / 10	____ %
masticare, parlare, sbadigliare	peggiore della settimana	esercizi svolti a casa

Punti chiave

- ✓ Usala come supporto, non come terapia unica
- ✓ Associa sempre il movimento attivo
- ✓ Registra i parametri usati

Errori da evitare

- ! Elettrodi vicino agli occhi o sul seno carotideo
- ! Intensità che provoca contrazioni
- ! Uso in presenza di pacemaker

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Movimento dopo la TENS	Eseguire aperture lente nell'ora successiva	dopo ogni applicazione

! **Nota clinica.** Le evidenze sulla TENS nei DTM sono limitate: usala per facilitare la partecipazione attiva.

Bibliografia essenziale

1. List T., Jensen R.H. Temporomandibular disorders: old ideas and new concepts. Cephalalgia. 2017;37(7):692–704.
2. Moseley G.L., Butler D.S. Fifteen years of explaining pain: the past, present, and future. J Pain. 2015;16(9):807–813.

PROTOCOLLO 18

Rilassamento della mandibola

Ridurre l'iperattività dei muscoli masticatori con il controllo consapevole

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Acuta e subacuta	Mialgia, artralgia	5 a 10 minuti	Ogni seduta

Indicazioni

- ✓ Serramento diurno
- ✓ Tensione muscolare del volto
- ✓ Mialgia da sovraccarico

Controindicazioni e precauzioni

- ! Red flags non escluse dal medico
- ! Peggioramento rapido e non spiegato dei sintomi
- ! Condizioni sistemiche non controllate
- ! Assenza di consenso informato del paziente

Posizionamento

Paziente: seduto, in un ambiente tranquillo.

Fisioterapista: di fronte al paziente, con materiale illustrato.

Esecuzione passo dopo passo



Percezione

Il paziente stringe leggermente i denti e poi rilascia, percependo la differenza.



Posizione

Labbra chiuse, denti separati, lingua morbida al palato.



Respirazione

Respira lentamente con il naso mantenendo la posizione.



Generalizzazione

Ripeti nelle situazioni quotidiane di tensione.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Ripetizioni	5 cicli
Durata	5 minuti
Frequenza	più volte al giorno

Criteri di rivalutazione

LIMITAZIONE FUNZIONALE

____ / 10

masticare, parlare, sbadigliare

DOLORE (NRS)

____ / 10

peggiore della settimana

ADERENZA

____ %

esercizi svolti a casa

Punti chiave

- ✓ Il contrasto tensione e rilascio aumenta la consapevolezza
- ✓ Collega l'esercizio a momenti della giornata
- ✓ Rinforza con promemoria

Errori da evitare

- ! Rilassamento passivo senza consapevolezza
- ! Spingere la lingua contro i denti
- ! Eseguire solo in seduta

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Pausa di rilassamento	Ciclo di percezione e rilascio di 1 minuto	5 volte al giorno

! **Nota clinica.** La consapevolezza delle parafunzioni diurne è il primo passo per ridurle.

Bibliografia essenziale

1. List T., Jensen R.H. Temporomandibular disorders: old ideas and new concepts. Cephalalgia. 2017;37(7):692–704.
2. Moseley G.L., Butler D.S. Fifteen years of explaining pain: the past, present, and future. J Pain. 2015;16(9):807–813.

PROTOCOLLO 19

Respirazione diaframmatica

Ridurre l'attivazione e la tensione cervicale e mandibolare

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Acuta e subacuta	Mialgia, stress associato	5 a 10 minuti	Ogni seduta

Indicazioni

- ✓ Respirazione toracica alta
- ✓ Stress e tensione muscolare
- ✓ Dolore cervicale associato

Controindicazioni e precauzioni

- ! Red flags non escluse dal medico
- ! Peggioramento rapido e non spiegato dei sintomi
- ! Condizioni sistemiche non controllate
- ! Assenza di consenso informato del paziente

Posizionamento

Paziente: supino con ginocchia flesse o seduto.

Fisioterapista: accanto al paziente.

Esecuzione passo dopo passo



Posizione
Una mano sul torace e una sull'addome.



Inspirazione
Inspira dal naso espandendo l'addome.



Espirazione
Espira lentamente, più a lungo dell'inspirazione.



Integrazione
Mantieni la mandibola rilassata durante l'esercizio.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Ritmo	inspirazione 4 secondi, espirazione 6
Durata	5 minuti
Frequenza	2 o 3 volte al giorno

Criteri di rivalutazione

LIMITAZIONE FUNZIONALE	DOLORE (NRS)	ADERENZA
____ / 10	____ / 10	____ %
masticare, parlare, sbadigliare	peggiore della settimana	esercizi svolti a casa

Punti chiave

- ✓ Ottimo prima degli esercizi mandibolari
- ✓ Controlla che le spalle non si sollevino
- ✓ Associa la posizione di riposo

Errori da evitare

- ! Respirazione forzata
- ! Iperventilazione
- ! Tensione delle labbra

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Respirazione serale	5 minuti prima di dormire	ogni sera

! **Nota clinica.** La respirazione lenta riduce l'attivazione simpatica, utile nei pazienti con stress e serramento.

Bibliografia essenziale

1. List T., Jensen R.H. Temporomandibular disorders: old ideas and new concepts. Cephalalgia. 2017;37(7):692–704.
2. Moseley G.L., Butler D.S. Fifteen years of explaining pain: the past, present, and future. J Pain. 2015;16(9):807–813.

PROTOCOLLO 20

Posizione di riposo della lingua

Insegnare la postura linguale che riduce il carico sui masticatori

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Acuta e subacuta	Mialgia, parafunzioni	5 minuti	Ogni seduta

Indicazioni

- ✓ Serramento
- ✓ Respirazione orale
- ✓ Interposizione linguale

Controindicazioni e precauzioni

- ! Red flags non escluse dal medico
- ! Peggioramento rapido e non spiegato dei sintomi
- ! Condizioni sistemiche non controllate
- ! Assenza di consenso informato del paziente

Posizionamento

Paziente: seduto, in un ambiente tranquillo.

Fisioterapista: di fronte al paziente con uno specchio.

Esecuzione passo dopo passo



Individuazione
La punta della lingua appena dietro gli incisivi superiori, senza toccarli.



Contatto
Il dorso della lingua si appoggia al palato morbidamente.



Denti separati
Mantieni 2 o 3 mm tra le arcate.



Mantenimento
Respira con il naso nella posizione corretta.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Ripetizioni	10
Mantenimento	10 secondi
Frequenza	più volte al giorno

Criteri di rivalutazione

LIMITAZIONE FUNZIONALE
____ / 10
masticare, parlare, sbadigliare

DOLORE (NRS)
____ / 10
peggiore della settimana

ADERENZA
____ %
esercizi svolti a casa

Punti chiave

- ✓ È la base per molti esercizi mandibolari
- ✓ Usa lo specchio all'inizio
- ✓ Correggi la pressione eccessiva

Errori da evitare

- ! Spingere forte la lingua sul palato
- ! Bloccare la respirazione
- ! Contrarre le labbra

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Posizione N	Lingua al palato e denti separati	ogni ora per 1 minuto

! **Nota clinica.** La corretta posizione linguale favorisce il rilassamento dei muscoli elevatori.

Bibliografia essenziale

1. List T., Jensen R.H. Temporomandibular disorders: old ideas and new concepts. Cephalalgia. 2017;37(7):692–704.
2. Moseley G.L., Butler D.S. Fifteen years of explaining pain: the past, present, and future. J Pain. 2015;16(9):807–813.

PROTOCOLLO 21

Terapia manuale delicata nella fase acuta

Ridurre il dolore con tecniche di grado I senza sovraccarico

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Acuta	Artralgia	5 a 8 minuti	2 sedute a settimana

Indicazioni

- ✓ Dolore articolare acuto
- ✓ Paziente molto sensibile
- ✓ Prima seduta di terapia manuale

Controindicazioni e precauzioni

- ! Trauma recente, sospetta frattura o lussazione
- ! Infezione o infiammazione articolare acuta
- ! Chirurgia dell'ATM recente senza nulla osta
- ! Ipermobilità o lussazioni ricorrenti: procedere con cautela

Posizionamento

Paziente: supino, capo appoggiato.

Fisioterapista: alla testa del lettino.

Esecuzione passo dopo passo



Contatto
Contatto esterno sul corpo della mandibola, senza presa intraorale.



Oscillazioni
Movimenti di piccola ampiezza all'inizio del range.



Ritmo
Lento e regolare, guidato dal comfort.



Rivaluta
Controlla dolore e apertura dopo ogni serie.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Grado	I (Maitland)
Tempo	3 serie da 30 secondi
Pausa	30 secondi

Criteri di rivalutazione

APERTURA MASSIMA	DOLORE (NRS 0 A 10)	TRAIETTORIA
____ mm	**____ / 10**	**Retta / Deviata**
senza dolore e massima, con calibro	a riposo e in funzione	osservata allo specchio

Punti chiave

- ✓ L'obiettivo è il sollievo, non l'aumento del range
- ✓ Mantieni un dialogo costante
- ✓ Interrompi se il dolore aumenta

Errori da evitare

- ! Usare gradi elevati in fase acuta
- ! Prese intraorali nel paziente spaventato
- ! Sedute troppo lunghe

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Movimento dolce	Aperture lente nel range senza dolore	10 ripetizioni, 2 volte al giorno

! **Nota clinica.** Le tecniche di grado I sfruttano la modulazione del dolore e preparano al lavoro attivo.

Bibliografia essenziale

1. List T., Jensen R.H. Temporomandibular disorders: old ideas and new concepts. Cephalalgia. 2017;37(7):692–704.
2. Moseley G.L., Butler D.S. Fifteen years of explaining pain: the past, present, and future. J Pain. 2015;16(9):807–813.

PROTOCOLLO 22

Massaggio superficiale del massetere e del temporale

Ridurre il dolore muscolare e preparare al trattamento

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Tutte	Mialgia	8 a 10 minuti	Ogni seduta

Indicazioni

- ✓ Mialgia diffusa
- ✓ Tensione dei masticatori
- ✓ Paziente non pronto per le tecniche profonde

Controindicazioni e precauzioni

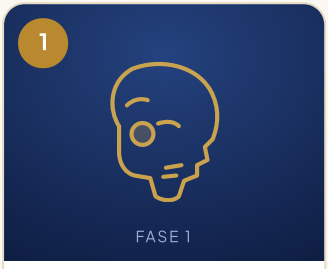
- ! Lesioni cutanee, infezioni o tumefazioni locali
- ! Terapia anticoagulante o fragilità vascolare: ridurre la pressione
- ! Sintomi neuropatici o red flags non indagate
- ! Sensibilizzazione marcata: iniziare con intensità minima

Posizionamento

Paziente: supino, capo appoggiato.

Fisioterapista: alla testa del lettino.

Esecuzione passo dopo passo



Preparazione
Applica una piccola quantità di crema.



Massetere
Sfioramenti lenti dall'arcata zigomatica all'angolo mandibolare.



Temporale
Movimenti circolari leggeri sulla fossa temporale.



Finale
Termina con aperture attive lente.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Pressione	leggera, non dolorosa
Durata	3 a 5 minuti per lato
Frequenza	ogni seduta

Criteri di rivalutazione

DOLORE ALLA PALPAZIONE
____ / 10
sul punto trattato

APERTURA MASSIMA
____ mm
con calibro

DOLORE RIFERITO
Sì / No
riproduzione del dolore familiare

Punti chiave

- ✓ Ottimo per costruire fiducia
- ✓ Osserva il rilassamento del volto
- ✓ Insegna l'automassaggio

Errori da evitare

- ! Pressione profonda in fase acuta
- ! Trascurare il lato controlaterale
- ! Durata eccessiva

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Automassaggio	Sfioramenti lenti con due dita sul massetere	2 minuti per lato, 2 volte al giorno

! **Nota clinica.** Il massaggio superficiale è una tecnica a basso rischio che facilita l'autogestione.

Bibliografia essenziale

1. List T., Jensen R.H. Temporomandibular disorders: old ideas and new concepts. Cephalalgia. 2017;37(7):692–704.
2. Moseley G.L., Butler D.S. Fifteen years of explaining pain: the past, present, and future. J Pain. 2015;16(9):807–813.

PROTOCOLLO 23

Gestione delle parafunzioni diurne

Ridurre serramento e abitudini orali con la consapevolezza

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Acuta e subacuta	Mialgia, bruxismo da veglia	10 minuti	Prime 4 sedute

Indicazioni

- ✓ Serramento diurno
- ✓ Mordicchiamento di labbra, guance o oggetti
- ✓ Gomme da masticare frequenti

Controindicazioni e precauzioni

- ! Red flags non escluse dal medico
- ! Peggioramento rapido e non spiegato dei sintomi
- ! Condizioni sistemiche non controllate
- ! Assenza di consenso informato del paziente

Posizionamento

Paziente: seduto, in un ambiente tranquillo.

Fisioterapista: con la checklist delle parafunzioni.

Esecuzione passo dopo passo



Identifica
Elenca le abitudini con l'aiuto di una checklist.



Monitora
Promemoria sul telefono o adesivi colorati.



Sostituisci
A ogni promemoria verifica la posizione di riposo.



Rivedi
Analizza il diario in seduta.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Promemoria	ogni 30 a 60 minuti
Durata	4 settimane
Verifica	ogni seduta

Criteri di rivalutazione

LIMITAZIONE FUNZIONALE
____ / 10
masticare, parlare, sbadigliare

DOLORE (NRS)
____ / 10
peggiore della settimana

ADERENZA
____ %
esercizi svolti a casa

Punti chiave

- ✓ La consapevolezza riduce il carico muscolare
- ✓ Coinvolgi il paziente nella scelta dei promemoria
- ✓ Rinforza i progressi

Errori da evitare

- ! Colpevolizzare il paziente
- ! Indicazioni generiche senza monitoraggio
- ! Trascurare le abitudini legate al lavoro

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Controllo con adesivi	A ogni adesivo visto: denti separati e lingua al palato	per tutta la giornata

! **Nota clinica.** Le parafunzioni diurne sono un fattore modificabile importante nel mantenimento del dolore muscolare.

Bibliografia essenziale

1. List T., Jensen R.H. Temporomandibular disorders: old ideas and new concepts. Cephalalgia. 2017;37(7):692–704.
2. Moseley G.L., Butler D.S. Fifteen years of explaining pain: the past, present, and future. J Pain. 2015;16(9):807–813.

PROTOCOLLO 24

Igiene del sonno nel paziente con DTM

Migliorare la qualità del sonno per ridurre la sensibilità al dolore

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	Dolore persistente, bruxismo	10 minuti	Prime 3 sedute

Indicazioni

- ✓ Sonno non ristoratore
- ✓ Dolore al risveglio
- ✓ Bruxismo notturno sospetto

Controindicazioni e precauzioni

- ! Red flags non escluse dal medico
- ! Peggioramento rapido e non spiegato dei sintomi
- ! Condizioni sistemiche non controllate
- ! Assenza di consenso informato del paziente

Posizionamento

Paziente: seduto, in un ambiente tranquillo.

Fisioterapista: di fronte al paziente, con materiale illustrato.

Esecuzione passo dopo passo



Valuta

Orari, risvegli, dispositivi e qualità percepita.



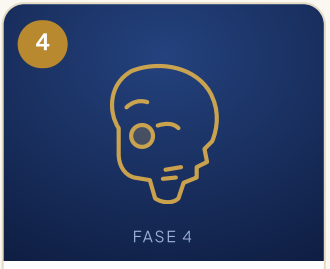
Routine

Orari regolari e attività rilassanti la sera.



Ambiente

Camera buia, silenziosa e senza schermi.



Posizione

Evita di dormire a pancia in giù con il volto compresso.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Periodo	4 settimane
Diario	qualità del sonno da 0 a 10
Verifica	ogni 2 sedute

Criteri di rivalutazione

LIMITAZIONE FUNZIONALE
____ / 10
masticare, parlare, sbadigliare

DOLORE (NRS)
____ / 10
peggiore della settimana

ADERENZA
____ %
esercizi svolti a casa

Punti chiave

- ✓ Il sonno scarso aumenta la sensibilità al dolore
- ✓ Cambiamenti piccoli e graduali
- ✓ Invia al medico se sospetti apnee

Errori da evitare

- ! Trascurare il russamento e le apnee
- ! Consigli generici senza piano
- ! Caffè e alcol serali non considerati

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Routine serale	Respirazione lenta e niente schermi 30 minuti prima di dormire	ogni sera

! **Nota clinica.** Disturbi del sonno e DTM si influenzano a vicenda; i sospetti di apnea vanno inviati allo specialista.

Bibliografia essenziale

1. List T., Jensen R.H. Temporomandibular disorders: old ideas and new concepts. Cephalalgia. 2017;37(7):692–704.
2. Moseley G.L., Butler D.S. Fifteen years of explaining pain: the past, present, and future. J Pain. 2015;16(9):807–813.

PROTOCOLLO 25

Mobilizzazione in distrazione caudale dell'ATM

Tecnica intraorale per ridurre il dolore articolare e migliorare l'apertura

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	Artralgia, ipomobilità	6 a 8 minuti	2 sedute a settimana

Indicazioni

- ✓ Dolore articolare con ridotta apertura
- ✓ Ipomobilità dopo immobilizzazione
- ✓ Spostamento discale senza riduzione in fase non acuta

Controindicazioni e precauzioni

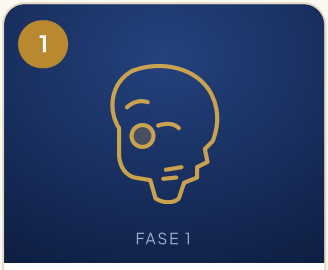
- ! Trauma recente, sospetta frattura o lussazione
- ! Infezione o infiammazione articolare acuta
- ! Chirurgia dell'ATM recente senza nulla osta
- ! Ipermobilità o lussazioni ricorrenti: procedere con cautela

Posizionamento

Paziente: supino, capo in posizione neutra su un cuscino basso, muscolatura rilassata, bocca leggermente aperta.

Fisioterapista: dal lato opposto all'articolazione da trattare, guanto monouso, pollice sui molari inferiori omolaterali, dita esterne sul corpo della mandibola; l'altra mano stabilizza il cranio sulla regione temporale.

Esecuzione passo dopo passo



Presa

Pollice sui molari inferiori, stabilizza il cranio con l'altra mano.



Distrazione

Trazione caudale lenta e progressiva, perpendicolare al piano occlusale.



Oscillazioni

Mantieni la distrazione con oscillazioni di grado I o II per il dolore.



Progressione

Se tollerato passa al grado III e aggiungi lo scivolamento anteriore.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Grado	I e II (Maitland) se prevale il dolore
Grado	III mantenuto se prevale la rigidità
Tempo	3 serie da 30 a 60 secondi, pausa 30 secondi

Criteri di rivalutazione

APERTURA MASSIMA
____ mm
senza dolore e massima, con calibro

DOLORE (NRS 0 A 10)
____ / 10
a riposo e in funzione

TRAIETTORIA
Retta / Deviata
osservata allo specchio

Punti chiave

- ✓ La forza si dosa sulla risposta, mai sul dolore
- ✓ Il pollice resta sui molari, non sugli incisivi
- ✓ Associa esercizio attivo a fine seduta

Errori da evitare

- ! Trazione brusca o anteriore all'inizio
- ! Lavorare con i masticatori in tensione
- ! Proseguire con dolore acuto o click doloroso

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Autodistrazione	Pollice sui molari, leggera trazione verso il basso mantenuta	3 x 30 secondi, 2 volte al giorno

! **Nota clinica.** Se dopo 3 o 4 sedute l'apertura non migliora di almeno 5 mm, rivaluta il quadro secondo DC/TMD.

Bibliografia essenziale

1. Calixtre L.B. et al. Manual therapy for the management of pain and limited range of motion in subjects with signs and symptoms of temporomandibular disorder: a systematic review of randomised controlled trials. J Oral Rehabil. 2015;42(11):847–861.
2. Armijo-Olivo S. et al. Effectiveness of manual therapy and therapeutic exercise for temporomandibular disorders: systematic review and meta-analysis. Phys Ther. 2016;96(1):9–25.

PROTOCOLLO 26

Scivolamento anteriore del condilo

Migliorare la traslazione condilare necessaria all'apertura completa

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	Artralgia, ipomobilità	6 a 8 minuti	2 sedute a settimana

Indicazioni

- ✓ Apertura limitata con ridotta traslazione
- ✓ Deflessione verso il lato rigido
- ✓ Fase successiva alla distrazione

Controindicazioni e precauzioni

- ! Trauma recente, sospetta frattura o lussazione
- ! Infezione o infiammazione articolare acuta
- ! Chirurgia dell'ATM recente senza nulla osta
- ! Ipermobilità o lussazioni ricorrenti: procedere con cautela

Posizionamento

Paziente: supino, capo in posizione neutra su un cuscino basso, muscolatura rilassata, bocca leggermente aperta.

Fisioterapista: dal lato opposto all'articolazione da trattare, guanto monouso, pollice sui molari inferiori omolaterali, dita esterne sul corpo della mandibola; l'altra mano stabilizza il cranio sulla regione temporale.

Esecuzione passo dopo passo

1



FASE 1

Presa

Stessa presa intraorale della distrazione caudale.

2



FASE 2

Distrazione iniziale

Applica una leggera distrazione caudale.

3



FASE 3

Scivolamento

Aggiungi una spinta in direzione anteriore e leggermente mediale.

4



FASE 4

Ritorno

Rilascia lentamente seguendo il percorso inverso.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Grado	II e III
Tempo	3 serie da 30 secondi
Integrazione	seguita da apertura attiva

Criteri di rivalutazione

APERTURA MASSIMA
____ mm
senza dolore e massima, con calibro

DOLORE (NRS 0 A 10)
____ / 10
a riposo e in funzione

TRAIETTORIA
Retta / Deviata
osservata allo specchio

Punti chiave

- ✓ Sempre preceduta da una lieve distrazione
- ✓ Osserva la traiettoria di apertura dopo la tecnica
- ✓ Confronta la traslazione tra i lati

Errori da evitare

- ! Spinta senza distrazione
- ! Direzione eccessivamente laterale
- ! Range forzato oltre la tolleranza

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Apertura con protrusione	Aprire guidando il mento leggermente in avanti	10 ripetizioni, 2 volte al giorno

! **Nota clinica.** La traslazione condilare è essenziale oltre i primi 20 a 25 mm di apertura.

Bibliografia essenziale

1. Calixtre L.B. et al. Manual therapy for the management of pain and limited range of motion in subjects with signs and symptoms of temporomandibular disorder: a systematic review of randomised controlled trials. J Oral Rehabil. 2015;42(11):847–861.
2. Armijo-Olivo S. et al. Effectiveness of manual therapy and therapeutic exercise for temporomandibular disorders: systematic review and meta-analysis. Phys Ther. 2016;96(1):9–25.

PROTOCOLLO 27

Scivolamento mediale e laterale dell'ATM

Recuperare la mobilità in lateralità

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	Artralgia, ipomobilità	6 a 8 minuti	2 sedute a settimana

Indicazioni

- ✓ Lateralità ridotta da un lato
- ✓ Deviazione persistente in apertura
- ✓ Rigidità capsulare

Controindicazioni e precauzioni

- ! Trauma recente, sospetta frattura o lussazione
- ! Infezione o infiammazione articolare acuta
- ! Chirurgia dell'ATM recente senza nulla osta
- ! Ipermobilità o lussazioni ricorrenti: procedere con cautela

Posizionamento

Paziente: supino, capo in posizione neutra su un cuscino basso, muscolatura rilassata, bocca leggermente aperta.

Fisioterapista: dal lato opposto all'articolazione da trattare, guanto monouso, pollice sui molari inferiori omolaterali, dita esterne sul corpo della mandibola; l'altra mano stabilizza il cranio sulla regione temporale.

Esecuzione passo dopo passo



Presa
Pollice sui molari, palmo esterno sul ramo mandibolare.



Distrazione
Leggera distrazione caudale di partenza.



Scivolamento
Spinta mediale o laterale controllata secondo la limitazione.



Verifica
Misura la lateralità dopo ogni serie.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Grado	II e III
Tempo	3 serie da 30 secondi
Direzione	verso il movimento limitato

Criteri di rivalutazione

APERTURA MASSIMA
____ mm
senza dolore e massima, con calibro

DOLORE (NRS 0 A 10)
____ / 10
a riposo e in funzione

TRAIETTORIA
Retta / Deviata
osservata allo specchio

Punti chiave

- ✓ Lavora nella direzione della restrizione
- ✓ Mantieni la stabilizzazione cranica
- ✓ Associa esercizi di lateralità attiva

Errori da evitare

- ! Forza eccessiva in lateralità
- ! Trascurare il lato controlaterale
- ! Assenza di rivalutazione

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Lateralità attiva	Scivolare la mandibola di lato con un abbassalingua tra i denti	10 per lato, 2 volte al giorno

! **Nota clinica.** La lateralità di riferimento supera i 7 mm per lato; misurala sempre prima e dopo.

Bibliografia essenziale

1. Calixtre L.B. et al. Manual therapy for the management of pain and limited range of motion in subjects with signs and symptoms of temporomandibular disorder: a systematic review of randomised controlled trials. J Oral Rehabil. 2015;42(11):847–861.
2. Armijo-Olivo S. et al. Effectiveness of manual therapy and therapeutic exercise for temporomandibular disorders: systematic review and meta-analysis. Phys Ther. 2016;96(1):9–25.

PROTOCOLLO 28

Distrazione con apertura progressiva

Aumentare il range articolare combinando distrazione e apertura

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	Ipomobilità capsulare	6 a 8 minuti	2 sedute a settimana

Indicazioni

- ✓ Ipomobilità capsulare cronica
- ✓ Apertura inferiore a 35 mm
- ✓ Rigidità dopo immobilizzazione

Controindicazioni e precauzioni

- ! Trauma recente, sospetta frattura o lussazione
- ! Infezione o infiammazione articolare acuta
- ! Chirurgia dell'ATM recente senza nulla osta
- ! Ipermobilità o lussazioni ricorrenti: procedere con cautela

Posizionamento

Paziente: supino, capo in posizione neutra su un cuscino basso, muscolatura rilassata, bocca leggermente aperta.

Fisioterapista: dal lato opposto all'articolazione da trattare, guanto monouso, pollice sui molari inferiori omolaterali, dita esterne sul corpo della mandibola; l'altra mano stabilizza il cranio sulla regione temporale.

Esecuzione passo dopo passo

1



FASE 1

Posizione

Bocca aperta fino al limite confortevole.

2



FASE 2

Distrazione

Applica distrazione caudale in questa posizione.

3



FASE 3

Apertura

Chiedi una leggera apertura attiva mantenendo la distrazione.

4



FASE 4

Nuovo limite

Ripeti partendo dal nuovo range ottenuto.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Ripetizioni	5 a 8
Tenuta	5 secondi
Serie	2 a 3

Criteri di rivalutazione

APERTURA MASSIMA
____ mm
senza dolore e massima, con calibro

DOLORE (NRS 0 A 10)
____ / 10
a riposo e in funzione

TRAIETTORIA
Retta / Deviata
osservata allo specchio

Punti chiave

- ✓ Usa il nuovo range con esercizi attivi
- ✓ Procedi in modo graduale
- ✓ Registra l'apertura a ogni serie

Errori da evitare

- ! Forzare il limite in un'unica seduta
- ! Ignorare il dolore riferito all'orecchio
- ! Saltare la stabilizzazione

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Apertura con abbassalingua	Aumentare gradualmente il numero di abbassalingua tra gli incisivi	5 minuti, 2 volte al giorno

! **Nota clinica.** Le restrizioni capsulari richiedono stimoli ripetuti e costanti nel tempo.

Bibliografia essenziale

1. Calixtre L.B. et al. Manual therapy for the management of pain and limited range of motion in subjects with signs and symptoms of temporomandibular disorder: a systematic review of randomised controlled trials. J Oral Rehabil. 2015;42(11):847–861.
2. Armijo-Olivo S. et al. Effectiveness of manual therapy and therapeutic exercise for temporomandibular disorders: systematic review and meta-analysis. Phys Ther. 2016;96(1):9–25.

PROTOCOLLO 29

Mobilizzazione con movimento in apertura

Combinare uno scivolamento passivo con l'apertura attiva del paziente

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	Artralgia, ipomobilità	6 a 8 minuti	2 sedute a settimana

Indicazioni

- ✓ Dolore durante l'apertura
- ✓ Deviazione in apertura
- ✓ Risposta positiva ai test di scivolamento

Controindicazioni e precauzioni

- ! Trauma recente, sospetta frattura o lussazione
- ! Infezione o infiammazione articolare acuta
- ! Chirurgia dell'ATM recente senza nulla osta
- ! Ipermobilità o lussazioni ricorrenti: procedere con cautela

Posizionamento

Paziente: seduto, schiena appoggiata.

Fisioterapista: dietro al paziente, mani esterne sui rami mandibolari.

Esecuzione passo dopo passo



Posizione
Paziente seduto, terapista dietro, mani sui rami mandibolari.



Scivolamento
Applica uno scivolamento laterale correttivo del lato deviato.



Movimento attivo
Il paziente apre lentamente mantenendo la correzione.



Criterio
Il movimento deve essere senza dolore.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Ripetizioni	6 a 10
Serie	3
Criterio	assenza di dolore

Criteri di rivalutazione

APERTURA MASSIMA
____ mm
senza dolore e massima, con calibro

DOLORE (NRS 0 A 10)
____ / 10
a riposo e in funzione

TRAIETTORIA
Retta / Deviata
osservata allo specchio

Punti chiave

- ✓ La regola è nessun dolore durante il movimento
- ✓ Osserva la traiettoria allo specchio
- ✓ Trasforma la tecnica in autotrattamento

Errori da evitare

- ! Continuare se compare dolore
- ! Correzione eccessiva
- ! Movimento troppo rapido

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Apertura con autocorrezione	Mano sul lato deviato guida l'apertura retta	10 ripetizioni, 2 volte al giorno

! **Nota clinica.** La mobilizzazione con movimento consente un controllo immediato dell'effetto sintomatico.

Bibliografia essenziale

1. Calixtre L.B. et al. Manual therapy for the management of pain and limited range of motion in subjects with signs and symptoms of temporomandibular disorder: a systematic review of randomised controlled trials. J Oral Rehabil. 2015;42(11):847–861.
2. Armijo-Olivo S. et al. Effectiveness of manual therapy and therapeutic exercise for temporomandibular disorders: systematic review and meta-analysis. Phys Ther. 2016;96(1):9–25.

PROTOCOLLO 30

Mobilizzazione con movimento in lateralità

Ridurre il dolore e la limitazione nei movimenti laterali

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	Artralgia, ipomobilità	6 a 8 minuti	2 sedute a settimana

Indicazioni

- ✓ Lateralità dolorosa
- ✓ Dolore in masticazione unilaterale
- ✓ Limitazione asimmetrica

Controindicazioni e precauzioni

- ! Trauma recente, sospetta frattura o lussazione
- ! Infezione o infiammazione articolare acuta
- ! Chirurgia dell'ATM recente senza nulla osta
- ! Ipermobilità o lussazioni ricorrenti: procedere con cautela

Posizionamento

Paziente: seduto, schiena appoggiata.

Fisioterapista: di lato al paziente, una mano sul cranio e una sulla mandibola.

Esecuzione passo dopo passo



Posizione
Paziente seduto, terapista di lato.



Stabilizzazione
Una mano stabilizza il cranio.



Scivolamento
L'altra mano applica una lieve distrazione mandibolare.



Movimento attivo
Il paziente esegue la lateralità mantenendo la correzione.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Ripetizioni	6 a 10
Serie	3
Criterio	assenza di dolore

Criteri di rivalutazione

APERTURA MASSIMA
____ mm
senza dolore e massima, con calibro

DOLORE (NRS 0 A 10)
____ / 10
a riposo e in funzione

TRAIETTORIA
Retta / Deviata
osservata allo specchio

Punti chiave

- ✓ Cerca la correzione che elimina il dolore
- ✓ Lavora lentamente
- ✓ Rivaluta subito dopo

Errori da evitare

- ! Forzare la lateralità
- ! Pressione sul condotto uditivo
- ! Serie troppo lunghe

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Lateralità guidata	Movimento laterale lento con un dito come guida	10 per lato, 2 volte al giorno

! **Nota clinica.** Un effetto immediato sul dolore indica che la tecnica è appropriata per il paziente.

Bibliografia essenziale

1. Calixtre L.B. et al. Manual therapy for the management of pain and limited range of motion in subjects with signs and symptoms of temporomandibular disorder: a systematic review of randomised controlled trials. J Oral Rehabil. 2015;42(11):847–861.
2. Armijo-Olivo S. et al. Effectiveness of manual therapy and therapeutic exercise for temporomandibular disorders: systematic review and meta-analysis. Phys Ther. 2016;96(1):9–25.

PROTOCOLLO 31

Gestione dello spostamento discale con riduzione

Ridurre i sintomi e migliorare il controllo del movimento in presenza di click

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	Spostamento discale con riduzione	6 a 8 minuti	2 sedute a settimana

Indicazioni

- ✓ Click reciproco doloroso
- ✓ Deviazione a S in apertura
- ✓ Fastidio in masticazione

Controindicazioni e precauzioni

- ! Trauma recente, sospetta frattura o lussazione
- ! Infezione o infiammazione articolare acuta
- ! Chirurgia dell'ATM recente senza nulla osta
- ! Ipermobilità o lussazioni ricorrenti: procedere con cautela

Posizionamento

Paziente: supino, capo in posizione neutra su un cuscino basso, muscolatura rilassata, bocca leggermente aperta.

Fisioterapista: dal lato opposto all'articolazione da trattare, guanto monouso, pollice sui molari inferiori omolaterali, dita esterne sul corpo della mandibola; l'altra mano stabilizza il cranio sulla regione temporale.

Esecuzione passo dopo passo

1



FASE 1

Educazione

Spiega che il click è frequente e spesso benigno.

2



FASE 2

Controllo

Insegna l'apertura retta con lingua al palato.

3



FASE 3

Terapia manuale

Distrazione e scivolamento delicati se c'è dolore.

4



FASE 4

Esercizio

Allenamento del controllo motorio senza click.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Grado	I e II
Esercizio	10 ripetizioni senza click
Frequenza	2 sedute a settimana

Criteri di rivalutazione

APERTURA MASSIMA
____ mm
senza dolore e massima, con calibro

DOLORE (NRS 0 A 10)
____ / 10
a riposo e in funzione

TRAIETTORIA
Retta / Deviata
osservata allo specchio

Punti chiave

- ✓ L'obiettivo è un movimento senza dolore, non eliminare il click
- ✓ Rassicura il paziente
- ✓ Lavora sul controllo motorio

Errori da evitare

- ! Tentare di riposizionare il disco con manovre forzate
- ! Allarmare il paziente
- ! Ignorare episodi di blocco

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Apertura controllata	Aprire con lingua al palato fino al limite senza click	10 ripetizioni, 3 volte al giorno

! **Nota clinica.** Episodi di blocco in chiusura vanno monitorati e comunicati all'odontoiatra.

Bibliografia essenziale

1. Calixtre L.B. et al. Manual therapy for the management of pain and limited range of motion in subjects with signs and symptoms of temporomandibular disorder: a systematic review of randomised controlled trials. J Oral Rehabil. 2015;42(11):847–861.
2. Armijo-Olivo S. et al. Effectiveness of manual therapy and therapeutic exercise for temporomandibular disorders: systematic review and meta-analysis. Phys Ther. 2016;96(1):9–25.

PROTOCOLLO 32

Gestione dello spostamento discale senza riduzione

Recuperare apertura e funzione nella limitazione da disco

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	Spostamento discale senza riduzione	6 a 8 minuti	2 sedute a settimana

Indicazioni

- ✓ Apertura limitata improvvisa dopo un periodo di click
- ✓ Deflessione verso il lato colpito
- ✓ Fase non acuta

Controindicazioni e precauzioni

- ! Trauma recente, sospetta frattura o lussazione
- ! Infezione o infiammazione articolare acuta
- ! Chirurgia dell'ATM recente senza nulla osta
- ! Ipermobilità o lussazioni ricorrenti: procedere con cautela

Posizionamento

Paziente: supino, capo in posizione neutra su un cuscino basso, muscolatura rilassata, bocca leggermente aperta.

Fisioterapista: dal lato opposto all'articolazione da trattare, guanto monouso, pollice sui molari inferiori omolaterali, dita esterne sul corpo della mandibola; l'altra mano stabilizza il cranio sulla regione temporale.

Esecuzione passo dopo passo

1



FASE 1

Valutazione

Conferma la limitazione e la deflessione secondo DC/TMD.

2



FASE 2

Distrazione

Distrazione caudale graduale.

3



FASE 3

Scivolamento

Scivolamento anteriore progressivo.

4



FASE 4

Esercizio

Apertura attiva assistita nel range ottenuto.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Grado	II e III secondo tolleranza
Tempo	3 serie da 60 secondi
Obiettivo	apertura funzionale superiore a 35 mm

Criteri di rivalutazione

APERTURA MASSIMA
____ mm
senza dolore e massima, con calibro

DOLORE (NRS 0 A 10)
____ / 10
a riposo e in funzione

TRAIETTORIA
Retta / Deviata
osservata allo specchio

Punti chiave

- ✓ Molti pazienti migliorano con trattamento conservativo
- ✓ Procedi con gradualità
- ✓ Collabora con l'odontoiatra

Errori da evitare

- ! Manovre di riduzione forzata
- ! Sedute troppo aggressive
- ! Promettere la scomparsa del problema

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Apertura assistita	Aprire aiutandosi con le dita sugli incisivi inferiori	5 x 10 secondi, 3 volte al giorno

! **Nota clinica.** L'obiettivo realistico è il recupero funzionale, anche senza riposizionamento del disco.

Bibliografia essenziale

1. Calixtre L.B. et al. Manual therapy for the management of pain and limited range of motion in subjects with signs and symptoms of temporomandibular disorder: a systematic review of randomised controlled trials. J Oral Rehabil. 2015;42(11):847–861.
2. Armijo-Olivo S. et al. Effectiveness of manual therapy and therapeutic exercise for temporomandibular disorders: systematic review and meta-analysis. Phys Ther. 2016;96(1):9–25.

PROTOCOLLO 33

Automobilizzazione assistita dell'ATM

Insegnare al paziente una mobilizzazione sicura da eseguire a casa

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	Artralgia, ipomobilità	6 a 8 minuti	2 sedute a settimana

Indicazioni

- ✓ Ipomobilità che richiede stimoli quotidiani
- ✓ Mantenimento dei risultati tra le sedute
- ✓ Pazienti collaboranti

Controindicazioni e precauzioni

- ! Trauma recente, sospetta frattura o lussazione
- ! Infezione o infiammazione articolare acuta
- ! Chirurgia dell'ATM recente senza nulla osta
- ! Ipermobilità o lussazioni ricorrenti: procedere con cautela

Posizionamento

Paziente: seduto, gomito appoggiato.

Fisioterapista: di fronte al paziente per insegnare e correggere.

Esecuzione passo dopo passo



Posizione
Seduto, gomito appoggiato al tavolo.



Presa
Pollice pulito sui molari inferiori del lato da trattare.



Trazione
Leggera trazione verso il basso e in avanti.



Controllo
Movimento lento davanti allo specchio.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Tempo	3 x 30 secondi
Frequenza	2 volte al giorno
Intensità	stiramento lieve, mai dolore

Criteri di rivalutazione

APERTURA MASSIMA
____ mm
senza dolore e massima, con calibro

DOLORE (NRS 0 A 10)
____ / 10
a riposo e in funzione

TRAIETTORIA
Retta / Deviata
osservata allo specchio

Punti chiave

- ✓ Verifica l'esecuzione in seduta
- ✓ Fornisci istruzioni scritte
- ✓ Controlla l'igiene delle mani

Errori da evitare

- ! Forza eccessiva
- ! Eseguire con dolore acuto
- ! Postura scorretta del capo

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Automobilizzazione	Trazione lieve e mantenuta con il pollice sui molari	3 x 30 secondi, 2 volte al giorno

! **Nota clinica.** L'automobilizzazione mantiene i guadagni ottenuti in seduta e aumenta l'autonomia del paziente.

Bibliografia essenziale

1. Calixtre L.B. et al. Manual therapy for the management of pain and limited range of motion in subjects with signs and symptoms of temporomandibular disorder: a systematic review of randomised controlled trials. J Oral Rehabil. 2015;42(11):847–861.
2. Armijo-Olivo S. et al. Effectiveness of manual therapy and therapeutic exercise for temporomandibular disorders: systematic review and meta-analysis. Phys Ther. 2016;96(1):9–25.

PROTOCOLLO 34

Mobilizzazione dopo chirurgia dell'ATM

Recuperare progressivamente la mobilità secondo le indicazioni del chirurgo

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Post chirurgica	Post chirurgico	6 a 8 minuti	2 o 3 sedute a settimana

Indicazioni

- ✓ Post artrocentesi o artroscopia
- ✓ Ipomobilità post chirurgica
- ✓ Paziente inviato dal chirurgo maxillofacciale

Controindicazioni e precauzioni

- ! Assenza del nulla osta del chirurgo
- ! Segni di infezione della ferita
- ! Dolore in rapido aumento
- ! Parestesie nuove del volto

Posizionamento

Paziente: supino, capo in posizione neutra su un cuscino basso, muscolatura rilassata, bocca leggermente aperta.

Fisioterapista: dal lato opposto all'articolazione da trattare, guanto monouso, pollice sui molari inferiori omolaterali, dita esterne sul corpo della mandibola; l'altra mano stabilizza il cranio sulla regione temporale.

Esecuzione passo dopo passo



Accordo

Verifica tempi e limiti indicati dal chirurgo.



Fase iniziale

Movimenti attivi assistiti nel range consentito.



Mobilizzazione

Distrazione delicata di grado I e II.



Progressione

Aumenta il range secondo la guarigione.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Grado	I e II nelle prime settimane
Esercizio	ogni 2 o 3 ore da sveglio
Verifica	contatto con il chirurgo

Criteri di rivalutazione

APERTURA MASSIMA
____ mm
senza dolore e massima, con calibro

DOLORE (NRS 0 A 10)
____ / 10
a riposo e in funzione

TRAIETTORIA
Retta / Deviata
osservata allo specchio

Punti chiave

- ✓ Il protocollo del chirurgo ha la priorità
- ✓ Monitora gonfiore e dolore
- ✓ Documenta i progressi

Errori da evitare

- ! Anticipare i tempi chirurgici
- ! Ignorare segni di infezione
- ! Mobilizzazioni intense precoci

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Movimento frequente	Aperture attive lente nel range consentito	10 ripetizioni ogni 2 o 3 ore

! **Nota clinica.** Nel post chirurgico la comunicazione con il chirurgo è parte integrante del protocollo.

Bibliografia essenziale

1. Calixtre L.B. et al. Manual therapy for the management of pain and limited range of motion in subjects with signs and symptoms of temporomandibular disorder: a systematic review of randomised controlled trials. J Oral Rehabil. 2015;42(11):847–861.
2. Armijo-Olivo S. et al. Effectiveness of manual therapy and therapeutic exercise for temporomandibular disorders: systematic review and meta-analysis. Phys Ther. 2016;96(1):9–25.

PROTOCOLLO 35

Mobilizzazione bilaterale simultanea

Trattare entrambe le articolazioni nei quadri bilaterali

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	Artralgia, ipomobilità	6 a 8 minuti	2 sedute a settimana

Indicazioni

- ✓ Ipomobilità bilaterale
- ✓ Rigidità simmetrica
- ✓ Artralgia bilaterale

Controindicazioni e precauzioni

- ! Trauma recente, sospetta frattura o lussazione
- ! Infezione o infiammazione articolare acuta
- ! Chirurgia dell'ATM recente senza nulla osta
- ! Ipermobilità o lussazioni ricorrenti: procedere con cautela

Posizionamento

Paziente: supino, capo in posizione neutra su un cuscino basso, muscolatura rilassata, bocca leggermente aperta.

Fisioterapista: alla testa del lettino, pollici sui molari inferiori bilateralmente, guanti monouso.

Esecuzione passo dopo passo



Presa

Pollici sui molari inferiori di entrambi i lati.



Distrazione

Trazione caudale simmetrica.



Scivolamento

Scivolamento anteriore bilaterale controllato.



Rivalutazione

Misura apertura e traiettoria.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Grado	II e III
Tempo	3 serie da 30 secondi
Pausa	30 secondi

Criteri di rivalutazione

APERTURA MASSIMA
____ mm
senza dolore e massima, con calibro

DOLORE (NRS 0 A 10)
____ / 10
a riposo e in funzione

TRAIETTORIA
Retta / Deviata
osservata allo specchio

Punti chiave

- ✓ Mantieni la simmetria della forza
- ✓ Paziente molto rilassato
- ✓ Usa guanti su entrambe le mani

Errori da evitare

- ! Asimmetria involontaria della presa
- ! Forza eccessiva
- ! Dimenticare la stabilizzazione cervicale

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Apertura simmetrica	Aprire davanti allo specchio con traiettoria retta	10 ripetizioni, 2 volte al giorno

! **Nota clinica.** Nei quadri bilaterali il trattamento simultaneo riduce i tempi e mantiene la simmetria.

Bibliografia essenziale

1. Calixtre L.B. et al. Manual therapy for the management of pain and limited range of motion in subjects with signs and symptoms of temporomandibular disorder: a systematic review of randomised controlled trials. J Oral Rehabil. 2015;42(11):847–861.
2. Armijo-Olivo S. et al. Effectiveness of manual therapy and therapeutic exercise for temporomandibular disorders: systematic review and meta-analysis. Phys Ther. 2016;96(1):9–25.

PROTOCOLLO 36

Mobilizzazione in posizione seduta

Alternativa alla posizione supina per pazienti con fastidio cervicale

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	Artralgia, ipomobilità	6 a 8 minuti	2 sedute a settimana

Indicazioni

- ✓ Paziente che non tollera la posizione supina
- ✓ Dolore cervicale associato
- ✓ Verifica funzionale in posizione eretta

Controindicazioni e precauzioni

- ! Trauma recente, sospetta frattura o lussazione
- ! Infezione o infiammazione articolare acuta
- ! Chirurgia dell'ATM recente senza nulla osta
- ! Ipermobilità o lussazioni ricorrenti: procedere con cautela

Posizionamento

Paziente: seduto, capo appoggiato al torace del terapista.

Fisioterapista: dietro al paziente, guanto monouso.

Esecuzione passo dopo passo



Posizione
Paziente seduto con il capo appoggiato al torace del terapista.



Stabilizzazione
Il terapista stabilizza il cranio con il proprio corpo.



Presa
Pollice intraorale sui molari inferiori.



Tecnica
Distrazione e scivolamento come in posizione supina.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Grado	I a III
Tempo	3 serie da 30 secondi
Pausa	30 secondi

Criteri di rivalutazione

APERTURA MASSIMA
____ mm
senza dolore e massima, con calibro

DOLORE (NRS 0 A 10)
____ / 10
a riposo e in funzione

TRAIETTORIA
Retta / Deviata
osservata allo specchio

Punti chiave

- ✓ Garantisci un buon appoggio del capo
- ✓ Controlla la postura cervicale
- ✓ Comunica costantemente

Errori da evitare

- ! Capo non stabilizzato
- ! Postura scorretta del terapista
- ! Forza in direzione errata

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Apertura seduta	Aperture lente con postura corretta	10 ripetizioni, 2 volte al giorno

! **Nota clinica.** La posizione seduta rende la tecnica più funzionale e confortevole per alcuni pazienti.

Bibliografia essenziale

1. Calixtre L.B. et al. Manual therapy for the management of pain and limited range of motion in subjects with signs and symptoms of temporomandibular disorder: a systematic review of randomised controlled trials. J Oral Rehabil. 2015;42(11):847–861.
2. Armijo-Olivo S. et al. Effectiveness of manual therapy and therapeutic exercise for temporomandibular disorders: systematic review and meta-analysis. Phys Ther. 2016;96(1):9–25.

PROTOCOLLO 37

Compressione e decompressione articolare controllata

Stimolare la tolleranza al carico articolare in modo graduale

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta tardiva	Artralgia in recupero	6 a 8 minuti	2 sedute a settimana

Indicazioni

- ✓ Artralgia in fase di recupero
- ✓ Dolore in masticazione residuo
- ✓ Preparazione al ritorno alla dieta normale

Controindicazioni e precauzioni

- ! Trauma recente, sospetta frattura o lussazione
- ! Infezione o infiammazione articolare acuta
- ! Chirurgia dell'ATM recente senza nulla osta
- ! Ipermobilità o lussazioni ricorrenti: procedere con cautela

Posizionamento

Paziente: seduto.

Fisioterapista: di fronte al paziente con rulli di cotone.

Esecuzione passo dopo passo



Posizione
Rullo di cotone tra i molari del lato da trattare.



Carico leggero
Morso lieve e progressivo per 5 secondi.



Rilascio
Rilascio lento e completo.



Progressione
Aumenta gradualmente l'intensità senza dolore.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Ripetizioni	10
Intensità	da lieve a moderata
Criterio	assenza di dolore

Criteri di rivalutazione

APERTURA MASSIMA
____ mm
senza dolore e massima, con calibro

DOLORE (NRS 0 A 10)
____ / 10
a riposo e in funzione

TRAIETTORIA
Retta / Deviata
osservata allo specchio

Punti chiave

- ✓ Il carico graduale migliora la tolleranza
- ✓ Monitora la risposta nelle 24 ore
- ✓ Collega alla ripresa della dieta

Errori da evitare

- ! Carichi massimali
- ! Progressione troppo rapida
- ! Uso in fase acuta

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Morso graduato	Morso lieve su rullo di cotone, alternando i lati	10 per lato, 1 volta al giorno

! **Nota clinica.** La progressione del carico va adattata alla risposta del giorno successivo.

Bibliografia essenziale

1. Calixtre L.B. et al. Manual therapy for the management of pain and limited range of motion in subjects with signs and symptoms of temporomandibular disorder: a systematic review of randomised controlled trials. J Oral Rehabil. 2015;42(11):847–861.
2. Armijo-Olivo S. et al. Effectiveness of manual therapy and therapeutic exercise for temporomandibular disorders: systematic review and meta-analysis. Phys Ther. 2016;96(1):9–25.

PROTOCOLLO 38

Trazione cranio-mandibolare globale

Ridurre la tensione del distretto cranio-mandibolare con una tecnica globale

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Tutte	Dolore misto	5 minuti	2 sedute a settimana

Indicazioni

- ✓ Tensione diffusa del distretto
- ✓ Dolore misto muscolare e articolare
- ✓ Pazienti molto sensibili alle tecniche locali

Controindicazioni e precauzioni

- ! Trauma recente, sospetta frattura o lussazione
- ! Infezione o infiammazione articolare acuta
- ! Chirurgia dell'ATM recente senza nulla osta
- ! Ipermobilità o lussazioni ricorrenti: procedere con cautela

Posizionamento

Paziente: supino, capo in posizione neutra su un cuscino basso, muscolatura rilassata, bocca leggermente aperta.

Fisioterapista: alla testa del lettino, una mano sotto l'occipite e una sul mento.

Esecuzione passo dopo passo



Posizione

Mani a coppa sotto l'occipite e sulla mandibola.



Trazione

Lieve trazione in direzione cranio-caudale.



Respirazione

Il paziente respira lentamente durante la tenuta.



Rilascio

Riduci gradualmente la trazione.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Tenuta	60 a 90 secondi
Ripetizioni	3
Intensità	molto lieve

Criteri di rivalutazione

APERTURA MASSIMA
____ mm
senza dolore e massima, con calibro

DOLORE (NRS 0 A 10)
____ / 10
a riposo e in funzione

TRAIETTORIA
Retta / Deviata
osservata allo specchio

Punti chiave

- ✓ Tecnica ben tollerata e rilassante
- ✓ Sincronizza con la respirazione
- ✓ Ideale a inizio o fine seduta

Errori da evitare

- ! Trazione eccessiva
- ! Presa sul collo anteriore
- ! Movimenti bruschi

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Rilassamento guidato	Respirazione lenta con mandibola rilassata	5 minuti al giorno

! **Nota clinica.** Le tecniche globali preparano il paziente a quelle locali e riducono l'ipervigilanza.

Bibliografia essenziale

1. Calixtre L.B. et al. Manual therapy for the management of pain and limited range of motion in subjects with signs and symptoms of temporomandibular disorder: a systematic review of randomised controlled trials. J Oral Rehabil. 2015;42(11):847–861.
2. Armijo-Olivo S. et al. Effectiveness of manual therapy and therapeutic exercise for temporomandibular disorders: systematic review and meta-analysis. Phys Ther. 2016;96(1):9–25.

PROTOCOLLO 39

Trigger point del massetere

Ridurre il dolore miofasciale e il dolore riferito originato dal massetere

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	Dolore miofasciale con riferito	6 a 8 minuti	2 sedute a settimana

Indicazioni

- ✓ Dolore riferito a molari, mandibola e orecchio
- ✓ Punto dolente che riproduce il dolore familiare
- ✓ Serramento o bruxismo

Controindicazioni e precauzioni

- ! Lesioni cutanee, infezioni o tumefazioni locali
- ! Terapia anticoagulante o fragilità vascolare: ridurre la pressione
- ! Sintomi neuropatici o red flags non indagate
- ! Sensibilizzazione marcata: iniziare con intensità minima

Posizionamento

Paziente: supino, capo appoggiato, mandibola rilassata.

Fisioterapista: alla testa del lettino.

Esecuzione passo dopo passo



Localizzazione

Palpa il massetere tra arcata zigomatica e angolo mandibolare e individua la banda tesa.



Compressione ischemica

Comprimi la banda tra pollice intraorale e indice esterno, oppure con presa esterna con pressione progressiva fino a dolore tollerabile (5 su 10).



Rilascio

Mantieni finché il dolore si riduce, poi rilascia lentamente.



Allungamento

Termina con un allungamento attivo dolce del muscolo.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Pressione	fino a dolore 5 su 10
Tenuta	60 a 90 secondi
Ripetizioni	2 o 3 per punto

Criteri di rivalutazione

DOLORE ALLA PALPAZIONE
____ / 10
sul punto trattato

APERTURA MASSIMA
____ mm
con calibro

DOLORE RIFERITO
Sì / No
riproduzione del dolore familiare

Punti chiave

- ✓ Il dolore deve ridursi durante la tenuta
- ✓ Chiedi sempre se il dolore è familiare
- ✓ Associa esercizio attivo

Errori da evitare

- ! Pressione eccessiva o improvvisa
- ! Pressione sul decorso di vasi o nervi
- ! Trattare troppi punti nella stessa seduta

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Automassaggio del massetere	Pressione circolare lenta con due dita sul punto dolente	60 secondi per lato, 2 volte al giorno

! **Nota clinica.** Il massetere è il muscolo più frequentemente coinvolto nella mialgia masticatoria.

Bibliografia essenziale

1. Schiffman E. et al. Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (DC/TMD) for clinical and research applications. J Oral Facial Pain Headache. 2014;28(1):6–27.
2. Armijo-Olivo S. et al. Effectiveness of manual therapy and therapeutic exercise for temporomandibular disorders: systematic review and meta-analysis. Phys Ther. 2016;96(1):9–25.

PROTOCOLLO 40

Trigger point del temporale

Ridurre il dolore miofasciale e il dolore riferito originato dal temporale

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	Dolore miofasciale con riferito	6 a 8 minuti	2 sedute a settimana

Indicazioni

- ✓ Dolore riferito a tempia, sopracciglio e denti superiori
- ✓ Punto dolente che riproduce il dolore familiare
- ✓ Cefalea temporale associata

Controindicazioni e precauzioni

- ! Lesioni cutanee, infezioni o tumefazioni locali
- ! Terapia anticoagulante o fragilità vascolare: ridurre la pressione
- ! Sintomi neuropatici o red flags non indagate
- ! Sensibilizzazione marcata: iniziare con intensità minima

Posizionamento

Paziente: supino, capo appoggiato, mandibola rilassata.

Fisioterapista: alla testa del lettino.

Esecuzione passo dopo passo

1



FASE 1

Localizzazione

Palpa la fossa temporale nelle porzioni anteriore, media e posteriore e individua la banda tesa.

2



FASE 2

Compressione ischemica

Comprimi con i polpastrelli di indice e medio con pressione progressiva fino a dolore tollerabile (5 su 10).

3



FASE 3

Rilascio

Mantieni finché il dolore si riduce, poi rilascia lentamente.

4



FASE 4

Allungamento

Termina con un allungamento attivo dolce del muscolo.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Pressione	fino a dolore 5 su 10
Tenuta	60 a 90 secondi
Ripetizioni	2 o 3 per punto

Criteri di rivalutazione

DOLORE ALLA PALPAZIONE
____ / 10
sul punto trattato

APERTURA MASSIMA
____ mm
con calibro

DOLORE RIFERITO
Sì / No
riproduzione del dolore familiare

Punti chiave

- ✓ Il dolore deve ridursi durante la tenuta
- ✓ Chiedi sempre se il dolore è familiare
- ✓ Associa esercizio attivo

Errori da evitare

- ! Pressione eccessiva o improvvisa
- ! Pressione sul decorso di vasi o nervi
- ! Trattare troppi punti nella stessa seduta

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Automassaggio del temporale	Movimenti circolari lenti sulla tempia	60 secondi per lato, 2 volte al giorno

! **Nota clinica.** Il temporale è spesso coinvolto nella cefalea attribuita a DTM.

Bibliografia essenziale

1. Schiffman E. et al. Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (DC/TMD) for clinical and research applications. J Oral Facial Pain Headache. 2014;28(1):6–27.
2. Armijo-Olivo S. et al. Effectiveness of manual therapy and therapeutic exercise for temporomandibular disorders: systematic review and meta-analysis. Phys Ther. 2016;96(1):9–25.

PROTOCOLLO 41

Trigger point dello pterigoideo mediale

Ridurre il dolore miofasciale e il dolore riferito originato dallo pterigoideo mediale

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	Dolore miofasciale con riferito	6 a 8 minuti	2 sedute a settimana

Indicazioni

- ✓ Dolore riferito a gola, lingua e regione retromandibolare
- ✓ Punto dolente che riproduce il dolore familiare
- ✓ Dolore in deglutizione o alla gola

Controindicazioni e precauzioni

- ! Lesioni cutanee, infezioni o tumefazioni locali
- ! Terapia anticoagulante o fragilità vascolare: ridurre la pressione
- ! Sintomi neuropatici o red flags non indagate
- ! Sensibilizzazione marcata: iniziare con intensità minima

Posizionamento

Paziente: supino, capo appoggiato, mandibola rilassata.

Fisioterapista: alla testa del lettino.

Esecuzione passo dopo passo

1



FASE 1

Localizzazione

Palpa la faccia interna dell'angolo mandibolare (esterno) o la parete mediale del ramo (interno, con guanto) e individua la banda tesa.

2



FASE 2

Compressione ischemica

Comprimi con il dito indice guantato o dall'esterno sotto l'angolo mandibolare con pressione progressiva fino a dolore tollerabile (5 su 10).

3



FASE 3

Rilascio

Mantieni finché il dolore si riduce, poi rilascia lentamente.

4



FASE 4

Allungamento

Termina con un allungamento attivo dolce del muscolo.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Pressione	fino a dolore 5 su 10
Tenuta	60 a 90 secondi
Ripetizioni	2 o 3 per punto

Criteri di rivalutazione

DOLORE ALLA PALPAZIONE
____ / 10
sul punto trattato

APERTURA MASSIMA
____ mm
con calibro

DOLORE RIFERITO
Sì / No
riproduzione del dolore familiare

Punti chiave

- ✓ Il dolore deve ridursi durante la tenuta
- ✓ Chiedi sempre se il dolore è familiare
- ✓ Associa esercizio attivo

Errori da evitare

- ! Pressione eccessiva o improvvisa
- ! Stimolare il riflesso faringeo
- ! Trattare troppi punti nella stessa seduta

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Rilassamento in apertura	Aprire lentamente con lingua al palato mantenendo 5 secondi	10 ripetizioni, 2 volte al giorno

! **Nota clinica.** La palpazione intraorale richiede delicatezza: attiva facilmente il riflesso faringeo.

Bibliografia essenziale

1. Schiffman E. et al. Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (DC/TMD) for clinical and research applications. J Oral Facial Pain Headache. 2014;28(1):6–27.
2. Armijo-Olivo S. et al. Effectiveness of manual therapy and therapeutic exercise for temporomandibular disorders: systematic review and meta-analysis. Phys Ther. 2016;96(1):9–25.

PROTOCOLLO 42

Trigger point dello pterigoideo laterale

Ridurre il dolore miofasciale e il dolore riferito originato dallo pterigoideo laterale

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	Dolore miofasciale con riferito	6 a 8 minuti	2 sedute a settimana

Indicazioni

- ✓ Dolore riferito a ATM e regione preauricolare
- ✓ Punto dolente che riproduce il dolore familiare
- ✓ Dolore preauricolare con protrusione dolorosa

Controindicazioni e precauzioni

- ! Lesioni cutanee, infezioni o tumefazioni locali
- ! Terapia anticoagulante o fragilità vascolare: ridurre la pressione
- ! Sintomi neuropatici o red flags non indagate
- ! Sensibilizzazione marcata: iniziare con intensità minima

Posizionamento

Paziente: supino, capo appoggiato, mandibola rilassata.

Fisioterapista: alla testa del lettino.

Esecuzione passo dopo passo



Localizzazione

Palpa l'area dietro la tuberosità mascellare (con guanto) o la regione sotto l'arcata zigomatica e individua la banda tesa.



Compressione ischemica

Applica una pressione delicata con il mignolo guantato o dall'esterno con pressione progressiva fino a dolore tollerabile (5 su 10).



Rilascio

Mantieni finché il dolore si riduce, poi rilascia lentamente.



Allungamento

Termina con un allungamento attivo dolce del muscolo.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Pressione	fino a dolore 5 su 10
Tenuta	60 a 90 secondi
Ripetizioni	2 o 3 per punto

Criteri di rivalutazione

DOLORE ALLA PALPAZIONE
____ / 10
sul punto trattato

APERTURA MASSIMA
____ mm
con calibro

DOLORE RIFERITO
Sì / No
riproduzione del dolore familiare

Punti chiave

- ✓ Il dolore deve ridursi durante la tenuta
- ✓ Chiedi sempre se il dolore è familiare
- ✓ Associa esercizio attivo

Errori da evitare

- ! Pressione eccessiva o improvvisa
- ! Pressione forzata nell'area intraorale
- ! Trattare troppi punti nella stessa seduta

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Protrusione controllata	Protrusione lenta e ritorno controllato	10 ripetizioni, 2 volte al giorno

! **Nota clinica.** L'accessibilità del pterigoideo laterale alla palpazione è discussa in letteratura: privilegia il trattamento indiretto ed eserciziale.

Bibliografia essenziale

1. Schiffman E. et al. Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (DC/TMD) for clinical and research applications. J Oral Facial Pain Headache. 2014;28(1):6–27.
2. Armijo-Olivo S. et al. Effectiveness of manual therapy and therapeutic exercise for temporomandibular disorders: systematic review and meta-analysis. Phys Ther. 2016;96(1):9–25.

PROTOCOLLO 43

Trigger point del digastrico

Ridurre il dolore miofasciale e il dolore riferito originato dal digastrico

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	Dolore miofasciale con riferito	6 a 8 minuti	2 sedute a settimana

Indicazioni

- ✓ Dolore riferito a denti incisivi inferiori e regione sotto l'orecchio
- ✓ Punto dolente che riproduce il dolore familiare
- ✓ Dolore sotto la mandibola

Controindicazioni e precauzioni

- ! Lesioni cutanee, infezioni o tumefazioni locali
- ! Terapia anticoagulante o fragilità vascolare: ridurre la pressione
- ! Sintomi neuropatici o red flags non indagate
- ! Sensibilizzazione marcata: iniziare con intensità minima

Posizionamento

Paziente: supino, capo appoggiato, mandibola rilassata.

Fisioterapista: di lato al paziente.

Esecuzione passo dopo passo



Localizzazione

Palpa il ventre posteriore sotto la mastoide e il ventre anteriore sotto il mento e individua la banda tesa.



Compressione ischemica

Comprimi con delicatezza con il polpastrello con pressione progressiva fino a dolore tollerabile (5 su 10).



Rilascio

Mantieni finché il dolore si riduce, poi rilascia lentamente.



Allungamento

Termina con un allungamento attivo dolce del muscolo.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Pressione	fino a dolore 5 su 10
Tenuta	60 a 90 secondi
Ripetizioni	2 o 3 per punto

Criteri di rivalutazione

DOLORE ALLA PALPAZIONE
____ / 10
sul punto trattato

APERTURA MASSIMA
____ mm
con calibro

DOLORE RIFERITO
Sì / No
riproduzione del dolore familiare

Punti chiave

- ✓ Il dolore deve ridursi durante la tenuta
- ✓ Chiedi sempre se il dolore è familiare
- ✓ Associa esercizio attivo

Errori da evitare

- ! Pressione eccessiva o improvvisa
- ! Pressione sulla carotide o sulle strutture del collo anteriore
- ! Trattare troppi punti nella stessa seduta

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Rilassamento sopraioideo	Deglutire lentamente con lingua al palato	10 ripetizioni, 2 volte al giorno

! **Nota clinica.** Il digastrico partecipa all'apertura e alla deglutizione: tratta con delicatezza.

Bibliografia essenziale

1. Schiffman E. et al. Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (DC/TMD) for clinical and research applications. J Oral Facial Pain Headache. 2014;28(1):6–27.
2. Armijo-Olivo S. et al. Effectiveness of manual therapy and therapeutic exercise for temporomandibular disorders: systematic review and meta-analysis. Phys Ther. 2016;96(1):9–25.

PROTOCOLLO 44

Trigger point dello sternocleidomastoideo

Ridurre il dolore miofasciale e il dolore riferito originato dallo sternocleidomastoideo

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	Dolore miofasciale con riferito	6 a 8 minuti	2 sedute a settimana

Indicazioni

- ✓ Dolore riferito a fronte, orbita, orecchio e mandibola
- ✓ Punto dolente che riproduce il dolore familiare
- ✓ Dolore al volto e all'orecchio

Controindicazioni e precauzioni

- ! Lesioni cutanee, infezioni o tumefazioni locali
- ! Terapia anticoagulante o fragilità vascolare: ridurre la pressione
- ! Sintomi neuropatici o red flags non indagate
- ! Sensibilizzazione marcata: iniziare con intensità minima

Posizionamento

Paziente: supino, capo appoggiato, mandibola rilassata.

Fisioterapista: di lato al paziente.

Esecuzione passo dopo passo

1



FASE 1

Localizzazione

Palpa il ventre sternale e clavicolare con presa a pinza e individua la banda tesa.

2



FASE 2

Compressione ischemica

Afferra il muscolo tra pollice e indice con pressione progressiva fino a dolore tollerabile (5 su 10).

3



FASE 3

Rilascio

Mantieni finché il dolore si riduce, poi rilascia lentamente.

4



FASE 4

Allungamento

Termina con un allungamento attivo dolce del muscolo.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Pressione	fino a dolore 5 su 10
Tenuta	60 a 90 secondi
Ripetizioni	2 o 3 per punto

Criteri di rivalutazione

DOLORE ALLA PALPAZIONE
____ / 10
sul punto trattato

APERTURA MASSIMA
____ mm
con calibro

DOLORE RIFERITO
Sì / No
riproduzione del dolore familiare

Punti chiave

- ✓ Il dolore deve ridursi durante la tenuta
- ✓ Chiedi sempre se il dolore è familiare
- ✓ Associa esercizio attivo

Errori da evitare

- ! Pressione eccessiva o improvvisa
- ! Pressione sull'arteria carotide
- ! Trattare troppi punti nella stessa seduta

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Allungamento dello SCM	Inclinazione controlaterale e rotazione omolaterale mantenuta	3 x 30 secondi per lato

! **Nota clinica.** Il dolore riferito dello SCM al volto e all'orecchio è spesso confuso con un DTM.

Bibliografia essenziale

1. Schiffman E. et al. Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (DC/TMD) for clinical and research applications. J Oral Facial Pain Headache. 2014;28(1):6–27.
2. Armijo-Olivo S. et al. Effectiveness of manual therapy and therapeutic exercise for temporomandibular disorders: systematic review and meta-analysis. Phys Ther. 2016;96(1):9–25.

PROTOCOLLO 45

Trigger point del trapezio superiore

Ridurre il dolore miofasciale e il dolore riferito originato dal trapezio superiore

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	Dolore miofasciale con riferito	6 a 8 minuti	2 sedute a settimana

Indicazioni

- ✓ Dolore riferito a regione temporale, angolo mandibolare e collo
- ✓ Punto dolente che riproduce il dolore familiare
- ✓ Dolore cervicale e cefalea associati

Controindicazioni e precauzioni

- ! Lesioni cutanee, infezioni o tumefazioni locali
- ! Terapia anticoagulante o fragilità vascolare: ridurre la pressione
- ! Sintomi neuropatici o red flags non indagate
- ! Sensibilizzazione marcata: iniziare con intensità minima

Posizionamento

Paziente: supino o seduto.

Fisioterapista: di lato al paziente.

Esecuzione passo dopo passo



Localizzazione

Palpa il bordo superiore del trapezio tra collo e spalla e individua la banda tesa.



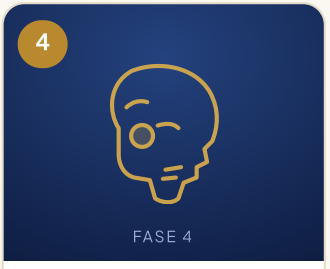
Compressione ischemica

Afferra con presa a pinza o comprimi con il pollice con pressione progressiva fino a dolore tollerabile (5 su 10).



Rilascio

Mantieni finché il dolore si riduce, poi rilascia lentamente.



Allungamento

Termina con un allungamento attivo dolce del muscolo.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Pressione	fino a dolore 5 su 10
Tenuta	60 a 90 secondi
Ripetizioni	2 o 3 per punto

Criteri di rivalutazione

DOLORE ALLA PALPAZIONE
____ / 10
sul punto trattato

APERTURA MASSIMA
____ mm
con calibro

DOLORE RIFERITO
Sì / No
riproduzione del dolore familiare

Punti chiave

- ✓ Il dolore deve ridursi durante la tenuta
- ✓ Chiedi sempre se il dolore è familiare
- ✓ Associa esercizio attivo

Errori da evitare

- ! Pressione eccessiva o improvvisa
- ! Pressione sul plesso brachiale
- ! Trattare troppi punti nella stessa seduta

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Allungamento del trapezio	Inclinazione controlaterale del capo con spalla abbassata	3 x 30 secondi per lato

! **Nota clinica.** Il trapezio superiore contribuisce spesso alla cefalea e al dolore mandibolare.

Bibliografia essenziale

1. Schiffman E. et al. Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (DC/TMD) for clinical and research applications. J Oral Facial Pain Headache. 2014;28(1):6–27.
2. Armijo-Olivo S. et al. Effectiveness of manual therapy and therapeutic exercise for temporomandibular disorders: systematic review and meta-analysis. Phys Ther. 2016;96(1):9–25.

PROTOCOLLO 46

Rilascio dei muscoli suboccipitali

Ridurre la tensione suboccipitale che influenza capo, collo e mandibola

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	DTM con cefalea o dolore cervicale	5 minuti	2 sedute a settimana

Indicazioni

- ✓ Cefalea occipitale
- ✓ Postura con capo in avanti
- ✓ Tensione cervicale alta

Controindicazioni e precauzioni

- ! Segni di insufficienza vascolare (vertigini, diplopia, disartria, disfagia)
- ! Instabilità cervicale sospetta (traumi, artrite reumatoide)
- ! Sintomi neurologici agli arti superiori
- ! Trauma cervicale recente non valutato dal medico

Posizionamento

Paziente: supino, capo appoggiato.

Fisioterapista: seduto alla testa del lettino, polpastrelli sotto l'occipite.

Esecuzione passo dopo passo



Posizione delle dita
Polpastrelli sotto la linea nucale, palmi verso l'alto.



Appoggio
Lascia che il peso del capo crei la pressione.



Trazione
Aggiungi una lieve trazione craniale.



Rilascio
Mantieni fino al rilassamento percepito.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Tenuta	2 a 3 minuti
Pressione	peso del capo
Ripetizioni	1 o 2

Criteri di rivalutazione

DOLORE CERVICALE (NRS)
____ / 10
a riposo e in movimento

MOBILITÀ
____ °
rotazione o flessione

SINTOMI MANDIBOLARI
Migliorati / Invariati
dopo il trattamento

Punti chiave

- ✓ Tecnica molto rilassante
- ✓ Lascia lavorare la gravità
- ✓ Ideale prima del lavoro cervicale

Errori da evitare

- ! Pressione attiva eccessiva
- ! Dita sulle vertebre
- ! Movimenti bruschi del capo

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Autorilascio	Due palline da tennis in una calza sotto l'occipite, da supino	3 minuti al giorno

! **Nota clinica.** Il rilascio suboccipitale favorisce il rilassamento globale e la riduzione della cefalea.

Bibliografia essenziale

1. Schiffman E. et al. Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (DC/TMD) for clinical and research applications. J Oral Facial Pain Headache. 2014;28(1):6–27.
2. Armijo-Olivo S. et al. Effectiveness of manual therapy and therapeutic exercise for temporomandibular disorders: systematic review and meta-analysis. Phys Ther. 2016;96(1):9–25.

PROTOCOLLO 47

Allungamento passivo del massetere

Aumentare l'estensibilità dei muscoli elevatori

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	Mialgia con limitazione	5 minuti	Ogni seduta

Indicazioni

- ✓ Apertura limitata di origine muscolare
- ✓ Rigidità mattutina
- ✓ Dopo il trattamento dei trigger point

Controindicazioni e precauzioni

- ! Lesioni cutanee, infezioni o tumefazioni locali
- ! Terapia anticoagulante o fragilità vascolare: ridurre la pressione
- ! Sintomi neuropatici o red flags non indagate
- ! Sensibilizzazione marcata: iniziare con intensità minima

Posizionamento

Paziente: supino, capo appoggiato.

Fisioterapista: di lato al paziente, pollice guantato sugli incisivi inferiori.

Esecuzione passo dopo passo



Presa

Pollice sugli incisivi inferiori, l'altra mano stabilizza la fronte.



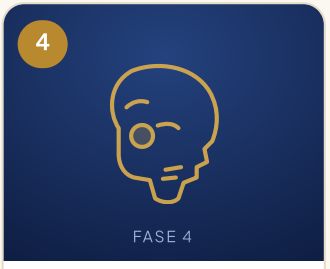
Apertura

Porta la mandibola in apertura fino alla prima resistenza.



Tenuta

Mantieni senza dolore mentre il paziente respira.



Progressione

Avanza leggermente al rilassamento.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Tenuta	30 secondi
Ripetizioni	3
Intensità	tensione, mai dolore

Criteri di rivalutazione

DOLORE ALLA PALPAZIONE
____ / 10
sul punto trattato

APERTURA MASSIMA
____ mm
con calibro

DOLORE RIFERITO
Sì / No
riproduzione del dolore familiare

Punti chiave

- ✓ L'allungamento segue sempre il riscaldamento
- ✓ Respira con il paziente
- ✓ Misura l'apertura prima e dopo

Errori da evitare

- ! Allungare con dolore articolare
- ! Forza sugli incisivi superiori
- ! Rimbalzi

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Autoallungamento	Apertura con le dita sugli incisivi inferiori mantenuta	3 x 30 secondi, 2 volte al giorno

! **Nota clinica.** Se compare dolore preauricolare, riduci l'apertura: la limitazione potrebbe essere articolare.

Bibliografia essenziale

1. Schiffman E. et al. Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (DC/TMD) for clinical and research applications. J Oral Facial Pain Headache. 2014;28(1):6–27.
2. Armijo-Olivo S. et al. Effectiveness of manual therapy and therapeutic exercise for temporomandibular disorders: systematic review and meta-analysis. Phys Ther. 2016;96(1):9–25.

PROTOCOLLO 48

Allungamento del temporale

Ridurre la tensione del temporale e la cefalea associata

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	Mialgia, cefalea attribuita a DTM	5 minuti	Ogni seduta

Indicazioni

- ✓ Cefalea temporale
- ✓ Tensione del temporale alla palpazione
- ✓ Apertura limitata

Controindicazioni e precauzioni

- ! Lesioni cutanee, infezioni o tumefazioni locali
- ! Terapia anticoagulante o fragilità vascolare: ridurre la pressione
- ! Sintomi neuropatici o red flags non indagate
- ! Sensibilizzazione marcata: iniziare con intensità minima

Posizionamento

Paziente: supino.

Fisioterapista: alla testa del lettino.

Esecuzione passo dopo passo



Apertura

Il paziente apre fino al limite confortevole.



Fissazione

Le dita fissano la fascia temporale verso l'alto.



Scivolamento

Il paziente chiude lentamente mentre mantieni la fissazione.



Ripeti

Cambia zona: anteriore, media, posteriore.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Ripetizioni	3 per zona
Velocità	lenta
Intensità	confortevole

Criteri di rivalutazione

DOLORE ALLA PALPAZIONE
____ / 10
sul punto trattato

APERTURA MASSIMA
____ mm
con calibro

DOLORE RIFERITO
Sì / No
riproduzione del dolore familiare

Punti chiave

- ✓ Combina rilascio e movimento attivo
- ✓ Lavora tutte le porzioni
- ✓ Osserva la riduzione della cefalea

Errori da evitare

- ! Pressione eccessiva sull'osso
- ! Movimenti rapidi
- ! Ignorare il dolore riferito ai denti

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Rilascio attivo	Dita sulla tempia mentre si chiude lentamente la bocca	5 per lato, 2 volte al giorno

! **Nota clinica.** Il rilascio con movimento attivo è utile nei pazienti con cefalea di tipo tensivo associata.

Bibliografia essenziale

1. Schiffman E. et al. Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (DC/TMD) for clinical and research applications. J Oral Facial Pain Headache. 2014;28(1):6–27.
2. Armijo-Olivo S. et al. Effectiveness of manual therapy and therapeutic exercise for temporomandibular disorders: systematic review and meta-analysis. Phys Ther. 2016;96(1):9–25.

PROTOCOLLO 49

Rilascio miofasciale della fascia temporale

Migliorare la mobilità dei tessuti del distretto temporale

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	Mialgia, cefalea	5 minuti	Ogni seduta

Indicazioni

- ✓ Tessuti tesi e poco mobili
- ✓ Cefalea tensiva
- ✓ Sensibilità diffusa

Controindicazioni e precauzioni

- ! Lesioni cutanee, infezioni o tumefazioni locali
- ! Terapia anticoagulante o fragilità vascolare: ridurre la pressione
- ! Sintomi neuropatici o red flags non indagate
- ! Sensibilizzazione marcata: iniziare con intensità minima

Posizionamento

Paziente: supino.

Fisioterapista: alla testa del lettino, mani a piatto sulle tempie.

Esecuzione passo dopo passo



Contatto

Mani a piatto sulle tempie, pressione minima.



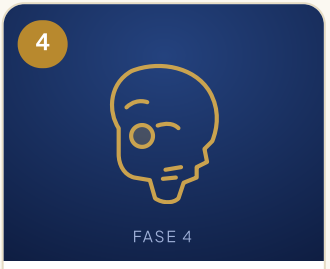
Ascolto

Percepisci la direzione di restrizione.



Mantenimento

Segui il tessuto fino al rilascio.



Conclusione

Rilascia gradualmente.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Tenuta	90 a 120 secondi
Pressione	minima
Ripetizioni	1 o 2

Criteri di rivalutazione

DOLORE ALLA PALPAZIONE
____ / 10
sul punto trattato

APERTURA MASSIMA
____ mm
con calibro

DOLORE RIFERITO
Sì / No
riproduzione del dolore familiare

Punti chiave

- ✓ Pressione leggera e costante
- ✓ Ritmo lento
- ✓ Ambiente tranquillo

Errori da evitare

- ! Forzare il tessuto
- ! Fretta
- ! Mani tese

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Automassaggio dolce	Scivolamento lento con i palmi sulle tempie	2 minuti al giorno

! **Nota clinica.** Le tecniche miofasciali dolci sono utili nei pazienti con sensibilizzazione e scarsa tolleranza alla pressione.

Bibliografia essenziale

1. Schiffman E. et al. Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (DC/TMD) for clinical and research applications. J Oral Facial Pain Headache. 2014;28(1):6–27.
2. Armijo-Olivo S. et al. Effectiveness of manual therapy and therapeutic exercise for temporomandibular disorders: systematic review and meta-analysis. Phys Ther. 2016;96(1):9–25.

PROTOCOLLO 50

Massaggio intraorale del massetere

Trattare in modo mirato la porzione profonda del massetere

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	Mialgia del massetere	5 minuti	1 o 2 sedute a settimana

Indicazioni

- ✓ Dolore profondo della guancia
- ✓ Trigger point non raggiungibili dall'esterno
- ✓ Serramento importante

Controindicazioni e precauzioni

- ! Lesioni cutanee, infezioni o tumefazioni locali
- ! Terapia anticoagulante o fragilità vascolare: ridurre la pressione
- ! Sintomi neuropatici o red flags non indagate
- ! Sensibilizzazione marcata: iniziare con intensità minima
- ! Lesioni o afte della mucosa orale

Posizionamento

Paziente: supino, bocca leggermente aperta.

Fisioterapista: di lato, indice guantato all'interno della guancia, pollice esterno.

Esecuzione passo dopo passo



Presa

Indice guantato all'interno, pollice all'esterno sul massetere.



Esplorazione

Individua le zone dolenti tra le due dita.



Scivolamento

Movimenti lenti dall'alto verso il basso.



Compressione

Mantieni sui punti dolenti fino al rilascio.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Durata	2 a 3 minuti per lato
Pressione	fino a 5 su 10
Ripetizioni	1 per lato

Criteri di rivalutazione

DOLORE ALLA PALPAZIONE
____ / 10
sul punto trattato

APERTURA MASSIMA
____ mm
con calibro

DOLORE RIFERITO
Sì / No
riproduzione del dolore familiare

Punti chiave

- ✓ Spiega la tecnica prima di iniziare
- ✓ Guanti e igiene rigorosi
- ✓ Pause frequenti per deglutire

Errori da evitare

- ! Pressione sui denti o sulle gengive
- ! Durata eccessiva
- ! Ignorare il disagio del paziente

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Automassaggio esterno	Pressione circolare esterna sul massetere	60 secondi per lato, 2 volte al giorno

! **Nota clinica.** Il consenso informato specifico per le tecniche intraorali è essenziale.

Bibliografia essenziale

1. Schiffman E. et al. Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (DC/TMD) for clinical and research applications. J Oral Facial Pain Headache. 2014;28(1):6–27.
2. Armijo-Olivo S. et al. Effectiveness of manual therapy and therapeutic exercise for temporomandibular disorders: systematic review and meta-analysis. Phys Ther. 2016;96(1):9–25.

PROTOCOLLO 51

Rilascio dei muscoli sopraioidei

Ridurre la tensione nella regione sottomandibolare

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	DTM con tensione sopraioidea	5 minuti	1 o 2 sedute a settimana

Indicazioni

- ✓ Sensazione di tensione sotto il mento
- ✓ Disagio in deglutizione
- ✓ Postura con capo in avanti

Controindicazioni e precauzioni

- ! Lesioni cutanee, infezioni o tumefazioni locali
- ! Terapia anticoagulante o fragilità vascolare: ridurre la pressione
- ! Sintomi neuropatici o red flags non indagate
- ! Sensibilizzazione marcata: iniziare con intensità minima
- ! Linfonodi aumentati o tumefazioni del collo

Posizionamento

Paziente: supino, capo neutro.

Fisioterapista: di lato al paziente, polpastrelli sotto la mandibola.

Esecuzione passo dopo passo



Contatto

Polpastrelli sotto il corpo mandibolare, lontano dalla trachea.



Pressione

Pressione verso l'alto molto delicata.



Deglutizione

Chiedi di deglutire lentamente mantenendo il contatto.



Rilascio

Mantieni fino a percepire il rilassamento.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Tenuta	60 secondi
Ripetizioni	2 o 3
Pressione	minima

Criteri di rivalutazione

DOLORE ALLA PALPAZIONE
____ / 10
sul punto trattato

APERTURA MASSIMA
____ mm
con calibro

DOLORE RIFERITO
Sì / No
riproduzione del dolore familiare

Punti chiave

- ✓ Lavora con estrema delicatezza
- ✓ Rimani lateralmente rispetto alla linea mediana
- ✓ Usa la deglutizione come attivazione

Errori da evitare

- ! Pressione sulla trachea o sulla carotide
- ! Forza eccessiva
- ! Trattare in presenza di linfonodi aumentati

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Deglutizione con lingua al palato	Deglutire lentamente con lingua al palato	10 ripetizioni, 2 volte al giorno

! **Nota clinica.** I sopraioidei collegano mandibola e osso ioide: la loro tensione influenza postura linguale e cervicale.

Bibliografia essenziale

1. Schiffman E. et al. Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (DC/TMD) for clinical and research applications. J Oral Facial Pain Headache. 2014;28(1):6–27.
2. Armijo-Olivo S. et al. Effectiveness of manual therapy and therapeutic exercise for temporomandibular disorders: systematic review and meta-analysis. Phys Ther. 2016;96(1):9–25.

PROTOCOLLO 52

Contrazione e rilassamento dei muscoli elevatori

Aumentare l'apertura sfruttando il rilassamento post isometrico

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	Mialgia con limitazione	5 minuti	Ogni seduta

Indicazioni

- ✓ Apertura limitata da tensione muscolare
- ✓ Resistenza all'allungamento passivo
- ✓ Paziente collaborante

Controindicazioni e precauzioni

- ! Lesioni cutanee, infezioni o tumefazioni locali
- ! Terapia anticoagulante o fragilità vascolare: ridurre la pressione
- ! Sintomi neuropatici o red flags non indagate
- ! Sensibilizzazione marcata: iniziare con intensità minima

Posizionamento

Paziente: seduto o supino.

Fisioterapista: di fronte al paziente, due dita sotto il mento o sugli incisivi inferiori.

Esecuzione passo dopo passo



Posizione
Apertura fino alla prima resistenza.



Contrazione
Il paziente spinge lievemente in chiusura contro la tua resistenza.



Rilassamento
Dopo 5 secondi rilascia e respira.



Nuovo limite
Accompagna l'apertura fino alla nuova barriera.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Contrazione	20 % della forza, 5 secondi
Ripetizioni	3 a 5
Pausa	rilassamento completo

Criteri di rivalutazione

DOLORE ALLA PALPAZIONE
____ / 10
sul punto trattato

APERTURA MASSIMA
____ mm
con calibro

DOLORE RIFERITO
Sì / No
riproduzione del dolore familiare

Punti chiave

- ✓ Forza di contrazione molto bassa
- ✓ Sincronizza con l'espirazione
- ✓ Misura l'apertura dopo la tecnica

Errori da evitare

- ! Contrazioni intense
- ! Forzare l'apertura
- ! Saltare la fase di rilassamento

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Autotrattamento	Chiusura isometrica lieve contro le dita e poi apertura	5 ripetizioni, 2 volte al giorno

! **Nota clinica.** Il rilassamento post isometrico è efficace e ben tollerato quando la limitazione è muscolare.

Bibliografia essenziale

1. Schiffman E. et al. Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (DC/TMD) for clinical and research applications. J Oral Facial Pain Headache. 2014;28(1):6–27.
2. Armijo-Olivo S. et al. Effectiveness of manual therapy and therapeutic exercise for temporomandibular disorders: systematic review and meta-analysis. Phys Ther. 2016;96(1):9–25.

PROTOCOLLO 53

Inibizione reciproca dei muscoli elevatori

Rilassare gli elevatori attivando gli abbassatori della mandibola

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Acuta e subacuta	Mialgia, contrattura protettiva	5 minuti	Ogni seduta

Indicazioni

- ✓ Spasmo protettivo
- ✓ Dolore acuto dei masticatori
- ✓ Paziente che non tollera l'allungamento

Controindicazioni e precauzioni

- ! Lesioni cutanee, infezioni o tumefazioni locali
- ! Terapia anticoagulante o fragilità vascolare: ridurre la pressione
- ! Sintomi neuropatici o red flags non indagate
- ! Sensibilizzazione marcata: iniziare con intensità minima

Posizionamento

Paziente: seduto.

Fisioterapista: di fronte al paziente, mano sotto il mento.

Esecuzione passo dopo passo



Posizione

Apertura fino alla prima resistenza.



Attivazione

Il paziente spinge lievemente in apertura contro la tua mano.



Rilascio

Dopo 5 secondi rilassa.



Progressione

Apri lentamente nel nuovo range.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Contrazione	lieve, 5 secondi
Ripetizioni	5
Pausa	5 secondi

Criteri di rivalutazione

DOLORE ALLA PALPAZIONE
____ / 10
sul punto trattato

APERTURA MASSIMA
____ mm
con calibro

DOLORE RIFERITO
Sì / No
riproduzione del dolore familiare

Punti chiave

- ✓ Indicata quando l'allungamento diretto è doloroso
- ✓ Contrazioni sempre lievi
- ✓ Ottimo in fase acuta

Errori da evitare

- ! Contrazioni massimali
- ! Movimento rapido
- ! Dolore durante la tecnica

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Apertura contro resistenza lieve	Mano sotto il mento, spinta lieve in apertura	5 x 5 secondi, 2 volte al giorno

! **Nota clinica.** L'inibizione reciproca sfrutta il rilassamento degli antagonisti senza sollecitare il muscolo dolente.

Bibliografia essenziale

1. Schiffman E. et al. Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (DC/TMD) for clinical and research applications. J Oral Facial Pain Headache. 2014;28(1):6–27.
2. Armijo-Olivo S. et al. Effectiveness of manual therapy and therapeutic exercise for temporomandibular disorders: systematic review and meta-analysis. Phys Ther. 2016;96(1):9–25.

PROTOCOLLO 54

Programma di esercizi 6 x 6

Sequenza di base per controllo mandibolare, postura linguale e cervicale

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	Mialgia, artralgia, disturbi del controllo	5 a 10 minuti	Ogni giorno a domicilio

Indicazioni

- ✓ Avvio del programma domiciliare
- ✓ Disturbi misti muscolari e posturali
- ✓ Pazienti con scarsa consapevolezza motoria

Controindicazioni e precauzioni

- ! Dolore acuto in rapido aumento
- ! Lussazione recente o blocco in apertura non risolto
- ! Chirurgia recente senza indicazioni del chirurgo
- ! Esercizio che riproduce un click doloroso: modificarlo

Posizionamento

Paziente: seduto davanti a uno specchio, schiena appoggiata.

Fisioterapista: di fronte al paziente per insegnare e correggere.

Esecuzione passo dopo passo



Lingua e apertura

Lingua al palato, apertura e chiusura controllate.



Stabilizzazione

Isometrie lievi in apertura e lateralità.



Rachide cervicale

Retrazione del mento e allungamento assiale.



Spalle

Retrazione scapolare e postura eretta.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Ripetizioni	6 per esercizio
Serie	6 volte al giorno
Durata	circa 5 minuti

Criteri di rivalutazione

APERTURA MASSIMA
____ mm
senza dolore e massima, con calibro

DOLORE (NRS 0 A 10)
____ / 10
a riposo e in funzione

TRAIETTORIA
Retta / Deviata
osservata allo specchio

Punti chiave

- ✓ Esecuzione lenta e precisa
- ✓ Collega il programma alla routine quotidiana
- ✓ Controlla l'esecuzione a ogni seduta

Errori da evitare

- ! Eseguire troppo velocemente
- ! Saltare la componente cervicale
- ! Forzare oltre il dolore

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Programma 6 x 6	Sequenza completa dei 6 esercizi	6 ripetizioni, 6 volte al giorno

! **Nota clinica.** Un programma breve e ripetuto aumenta l'aderenza rispetto a sessioni lunghe e rare.

Bibliografia essenziale

1. Armijo-Olivo S. et al. Effectiveness of manual therapy and therapeutic exercise for temporomandibular disorders: systematic review and meta-analysis. Phys Ther. 2016;96(1):9–25.
2. List T., Jensen R.H. Temporomandibular disorders: old ideas and new concepts. Cephalalgia. 2017;37(7):692–704.

PROTOCOLLO 55

Apertura con lingua al palato

Limitare la traslazione eccessiva e favorire la rotazione condilare

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	Mialgia, artralgia, disturbi del controllo	5 a 10 minuti	Ogni giorno a domicilio

Indicazioni

- ✓ Ipermobilità o click
- ✓ Deviazione in apertura
- ✓ Fase iniziale del controllo motorio

Controindicazioni e precauzioni

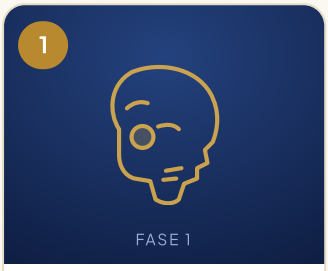
- ! Dolore acuto in rapido aumento
- ! Lussazione recente o blocco in apertura non risolto
- ! Chirurgia recente senza indicazioni del chirurgo
- ! Esercizio che riproduce un click doloroso: modificarlo

Posizionamento

Paziente: seduto davanti a uno specchio, schiena appoggiata.

Fisioterapista: di fronte al paziente per insegnare e correggere.

Esecuzione passo dopo passo



Posizione

Punta della lingua sul palato dietro gli incisivi.



Apertura

Apri lentamente mantenendo il contatto della lingua.



Limite

Fermati quando la lingua tende a staccarsi.



Chiusura

Chiudi lentamente senza contatto forte dei denti.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Ripetizioni	10
Serie	3 al giorno
Velocità	lenta

Criteri di rivalutazione

APERTURA MASSIMA
____ mm
senza dolore e massima, con calibro

DOLORE (NRS 0 A 10)
____ / 10
a riposo e in funzione

TRAIETTORIA
Retta / Deviata
osservata allo specchio

Punti chiave

- ✓ Il movimento deve essere retto allo specchio
- ✓ Nessun click durante l'esercizio
- ✓ Rilassa le labbra

Errori da evitare

- ! Staccare la lingua
- ! Aprire con scatti
- ! Serrare i denti alla chiusura

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Apertura controllata	Apertura con lingua al palato davanti allo specchio	10 ripetizioni, 3 volte al giorno

! **Nota clinica.** L'esercizio riduce la traslazione eccessiva ed è la base per il controllo del click.

Bibliografia essenziale

1. Armijo-Olivo S. et al. Effectiveness of manual therapy and therapeutic exercise for temporomandibular disorders: systematic review and meta-analysis. Phys Ther. 2016;96(1):9–25.
2. List T., Jensen R.H. Temporomandibular disorders: old ideas and new concepts. Cephalalgia. 2017;37(7):692–704.

PROTOCOLLO 56

Apertura controllata allo specchio

Correggere la deviazione con il feedback visivo

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	Mialgia, artralgia, disturbi del controllo	5 a 10 minuti	Ogni giorno a domicilio

Indicazioni

- ✓ Deviazione a S
- ✓ Deflessione funzionale
- ✓ Scarso controllo neuromuscolare

Controindicazioni e precauzioni

- ! Dolore acuto in rapido aumento
- ! Lussazione recente o blocco in apertura non risolto
- ! Chirurgia recente senza indicazioni del chirurgo
- ! Esercizio che riproduce un click doloroso: modificarlo

Posizionamento

Paziente: seduto davanti a uno specchio, schiena appoggiata.

Fisioterapista: di fronte al paziente per insegnare e correggere.

Esecuzione passo dopo passo



Riferimento

Disegna una linea verticale sullo specchio o usa il naso come riferimento.



Apertura

Apri lentamente mantenendo la linea mediana.



Correzione

Se devii, fermati e ritorna.



Progressione

Aumenta gradualmente l'ampiezza.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Ripetizioni	10
Serie	3 al giorno
Criterio	traiettoria retta

Criteri di rivalutazione

APERTURA MASSIMA	DOLORE (NRS 0 A 10)	TRAIETTORIA
____ mm	**____ / 10**	**Retta / Deviata**
senza dolore e massima, con calibro	a riposo e in funzione	osservata allo specchio

Punti chiave

- ✓ Il feedback visivo accelera l'apprendimento
- ✓ Progressione nell'ampiezza, non nella velocità
- ✓ Riduci gradualmente l'uso dello specchio

Errori da evitare

- ! Movimento rapido
- ! Correggere con la testa invece che con la mandibola
- ! Aperture massimali

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Apertura retta	Aprire seguendo la linea mediana allo specchio	10 ripetizioni, 3 volte al giorno

! **Nota clinica.** Quando la deflessione è articolare, la correzione attiva va combinata con la terapia manuale.

Bibliografia essenziale

1. Armijo-Olivo S. et al. Effectiveness of manual therapy and therapeutic exercise for temporomandibular disorders: systematic review and meta-analysis. Phys Ther. 2016;96(1):9–25.
2. List T., Jensen R.H. Temporomandibular disorders: old ideas and new concepts. Cephalalgia. 2017;37(7):692–704.

PROTOCOLLO 57

Coordinazione in lateralità

Migliorare il controllo dei movimenti laterali

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	Mialgia, artralgia, disturbi del controllo	5 a 10 minuti	Ogni giorno a domicilio

Indicazioni

- ✓ Lateralità asimmetrica
- ✓ Dolore in masticazione
- ✓ Scarso controllo motorio

Controindicazioni e precauzioni

- ! Dolore acuto in rapido aumento
- ! Lussazione recente o blocco in apertura non risolto
- ! Chirurgia recente senza indicazioni del chirurgo
- ! Esercizio che riproduce un click doloroso: modificarlo

Posizionamento

Paziente: seduto davanti a uno specchio, schiena appoggiata.

Fisioterapista: di fronte al paziente per insegnare e correggere.

Esecuzione passo dopo passo



Posizione

Denti leggermente separati, lingua rilassata.



Movimento

Scivola la mandibola lentamente verso un lato.



Ritorno

Ritorna al centro controllando il movimento.



Alternanza

Ripeti verso l'altro lato.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Ripetizioni	10 per lato
Serie	2 al giorno
Velocità	lenta

Criteri di rivalutazione

APERTURA MASSIMA
____ mm
senza dolore e massima, con calibro

DOLORE (NRS 0 A 10)
____ / 10
a riposo e in funzione

TRAIETTORIA
Retta / Deviata
osservata allo specchio

Punti chiave

- ✓ Usa un abbassalingua per guidare il movimento
- ✓ Simmetria dei due lati
- ✓ Senza dolore

Errori da evitare

- ! Aprire troppo la bocca
- ! Movimento a scatti
- ! Contrarre il collo

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Lateralità guidata	Movimenti laterali lenti con abbassalingua tra gli incisivi	10 per lato, 2 volte al giorno

! **Nota clinica.** La coordinazione laterale prepara alla masticazione bilaterale.

Bibliografia essenziale

1. Armijo-Olivo S. et al. Effectiveness of manual therapy and therapeutic exercise for temporomandibular disorders: systematic review and meta-analysis. Phys Ther. 2016;96(1):9–25.
2. List T., Jensen R.H. Temporomandibular disorders: old ideas and new concepts. Cephalalgia. 2017;37(7):692–704.

PROTOCOLLO 58

Protrusione e retrusione controllate

Allenare il controllo antero posteriore della mandibola

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	Mialgia, artralgia, disturbi del controllo	5 a 10 minuti	Ogni giorno a domicilio

Indicazioni

- ✓ Click in apertura
- ✓ Dolore in protrusione
- ✓ Controllo motorio ridotto

Controindicazioni e precauzioni

- ! Dolore acuto in rapido aumento
- ! Lussazione recente o blocco in apertura non risolto
- ! Chirurgia recente senza indicazioni del chirurgo
- ! Esercizio che riproduce un click doloroso: modificarlo

Posizionamento

Paziente: seduto davanti a uno specchio, schiena appoggiata.

Fisioterapista: di fronte al paziente per insegnare e correggere.

Esecuzione passo dopo passo



Posizione

Denti separati, labbra rilassate.



Protrusione

Porta la mandibola in avanti lentamente.



Mantenimento

Mantieni 3 secondi.



Ritorno

Ritorna lentamente in posizione di riposo.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Ripetizioni	10
Mantenimento	3 secondi
Serie	2 al giorno

Criteri di rivalutazione

APERTURA MASSIMA
____ mm
senza dolore e massima, con calibro

DOLORE (NRS 0 A 10)
____ / 10
a riposo e in funzione

TRAIETTORIA
Retta / Deviata
osservata allo specchio

Punti chiave

- ✓ Movimento piccolo e controllato
- ✓ Verifica l'assenza di dolore
- ✓ Utile nei click che scompaiono in protrusione

Errori da evitare

- ! Protrusione eccessiva
- ! Velocità elevata
- ! Contrazione del collo

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Protrusione lenta	Avanti e indietro con controllo	10 ripetizioni, 2 volte al giorno

! **Nota clinica.** La protrusione controllata migliora la coordinazione tra condilo e disco.

Bibliografia essenziale

1. Armijo-Olivo S. et al. Effectiveness of manual therapy and therapeutic exercise for temporomandibular disorders: systematic review and meta-analysis. Phys Ther. 2016;96(1):9–25.
2. List T., Jensen R.H. Temporomandibular disorders: old ideas and new concepts. Cephalalgia. 2017;37(7):692–704.

PROTOCOLLO 59

Stabilizzazione isometrica in apertura

Rinforzare gli abbassatori e ridurre la tensione degli elevatori

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	Mialgia, artralgia, disturbi del controllo	5 a 10 minuti	Ogni giorno a domicilio

Indicazioni

- ✓ Ipermobilità
- ✓ Controllo motorio ridotto
- ✓ Fase di consolidamento

Controindicazioni e precauzioni

- ! Dolore acuto in rapido aumento
- ! Lussazione recente o blocco in apertura non risolto
- ! Chirurgia recente senza indicazioni del chirurgo
- ! Esercizio che riproduce un click doloroso: modificarlo

Posizionamento

Paziente: seduto davanti a uno specchio, schiena appoggiata.

Fisioterapista: di fronte al paziente per insegnare e correggere.

Esecuzione passo dopo passo



Posizione

Bocca leggermente aperta, lingua al palato.



Resistenza

Mano sotto il mento.



Contrazione

Spingi lievemente in apertura contro la mano.



Rilascio

Rilascia lentamente.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Contrazione	5 secondi, 20 % della forza
Ripetizioni	6
Serie	2 al giorno

Criteri di rivalutazione

APERTURA MASSIMA
____ mm
senza dolore e massima, con calibro

DOLORE (NRS 0 A 10)
____ / 10
a riposo e in funzione

TRAIETTORIA
Retta / Deviata
osservata allo specchio

Punti chiave

- ✓ Contrazioni lievi e senza movimento
- ✓ Respirazione regolare
- ✓ Nessun dolore

Errori da evitare

- ! Forza eccessiva
- ! Trattenere il respiro
- ! Movimento della mandibola

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Isometria in apertura	Spinta lieve contro la mano sotto il mento	6 x 5 secondi, 2 volte al giorno

! **Nota clinica.** Le isometrie lievi migliorano la stabilità senza sovraccaricare l'articolazione.

Bibliografia essenziale

1. Armijo-Olivo S. et al. Effectiveness of manual therapy and therapeutic exercise for temporomandibular disorders: systematic review and meta-analysis. Phys Ther. 2016;96(1):9–25.
2. List T., Jensen R.H. Temporomandibular disorders: old ideas and new concepts. Cephalalgia. 2017;37(7):692–704.

PROTOCOLLO 60

Stabilizzazione isometrica in chiusura

Allenare gli elevatori con carico controllato

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	Mialgia, artralgia, disturbi del controllo	5 a 10 minuti	Ogni giorno a domicilio

Indicazioni

- ✓ Debolezza dopo lunga inattività
- ✓ Fase di recupero funzionale
- ✓ Preparazione alla masticazione

Controindicazioni e precauzioni

- ! Dolore acuto in rapido aumento
- ! Lussazione recente o blocco in apertura non risolto
- ! Chirurgia recente senza indicazioni del chirurgo
- ! Esercizio che riproduce un click doloroso: modificarlo

Posizionamento

Paziente: seduto davanti a uno specchio, schiena appoggiata.

Fisioterapista: di fronte al paziente per insegnare e correggere.

Esecuzione passo dopo passo



Posizione
Bocca leggermente aperta.



Resistenza
Due dita sugli incisivi inferiori.



Contrazione
Spingi lievemente in chiusura contro le dita.



Rilascio
Rilascia e respira.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Contrazione	5 secondi, 20 % della forza
Ripetizioni	6
Serie	1 o 2 al giorno

Criteri di rivalutazione

APERTURA MASSIMA
____ mm
senza dolore e massima, con calibro

DOLORE (NRS 0 A 10)
____ / 10
a riposo e in funzione

TRAIETTORIA
Retta / Deviata
osservata allo specchio

Punti chiave

- ✓ Evitare in fase di mialgia acuta
- ✓ Intensità sempre bassa
- ✓ Monitora la risposta

Errori da evitare

- ! Contrazioni intense
- ! Uso in presenza di serramento importante
- ! Contatto forte tra i denti

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Isometria in chiusura	Spinta lieve contro le dita sugli incisivi	6 x 5 secondi, 1 volta al giorno

! **Nota clinica.** Inserisci le isometrie in chiusura solo quando il dolore muscolare è sotto controllo.

Bibliografia essenziale

1. Armijo-Olivo S. et al. Effectiveness of manual therapy and therapeutic exercise for temporomandibular disorders: systematic review and meta-analysis. Phys Ther. 2016;96(1):9–25.
2. List T., Jensen R.H. Temporomandibular disorders: old ideas and new concepts. Cephalalgia. 2017;37(7):692–704.

PROTOCOLLO 61

Stabilizzazione isometrica in lateralità

Migliorare la stabilità nei movimenti laterali

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	Mialgia, artralgia, disturbi del controllo	5 a 10 minuti	Ogni giorno a domicilio

Indicazioni

- ✓ Deviazione laterale
- ✓ Asimmetria muscolare
- ✓ Fase di consolidamento

Controindicazioni e precauzioni

- ! Dolore acuto in rapido aumento
- ! Lussazione recente o blocco in apertura non risolto
- ! Chirurgia recente senza indicazioni del chirurgo
- ! Esercizio che riproduce un click doloroso: modificarlo

Posizionamento

Paziente: seduto davanti a uno specchio, schiena appoggiata.

Fisioterapista: di fronte al paziente per insegnare e correggere.

Esecuzione passo dopo passo



Posizione
Bocca leggermente aperta.



Resistenza
Mano sul lato della mandibola.



Contrazione
Spingi lievemente contro la mano senza muovere.



Alternanza
Ripeti dall'altro lato.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Contrazione	5 secondi
Ripetizioni	6 per lato
Serie	2 al giorno

Criteri di rivalutazione

APERTURA MASSIMA
____ mm
senza dolore e massima, con calibro

DOLORE (NRS 0 A 10)
____ / 10
a riposo e in funzione

TRAIETTORIA
Retta / Deviata
osservata allo specchio

Punti chiave

- ✓ Simmetria tra i lati
- ✓ Contrazioni lievi
- ✓ Postura corretta del capo

Errori da evitare

- ! Movimento della testa
- ! Forza eccessiva
- ! Trattenere il respiro

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Isometria laterale	Spinta lieve contro la mano su entrambi i lati	6 x 5 secondi per lato

! **Nota clinica.** Le isometrie laterali completano la stabilizzazione dopo il recupero del range.

Bibliografia essenziale

1. Armijo-Olivo S. et al. Effectiveness of manual therapy and therapeutic exercise for temporomandibular disorders: systematic review and meta-analysis. Phys Ther. 2016;96(1):9–25.
2. List T., Jensen R.H. Temporomandibular disorders: old ideas and new concepts. Cephalalgia. 2017;37(7):692–704.

PROTOCOLLO 62

Esercizi contro resistenza progressiva

Recuperare forza e resistenza dei muscoli masticatori

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta tardiva e cronica	Mialgia, artralgia, disturbi del controllo	5 a 10 minuti	Ogni giorno a domicilio

Indicazioni

- ✓ Fase finale del recupero
- ✓ Ritorno alla dieta normale
- ✓ Debolezza muscolare

Controindicazioni e precauzioni

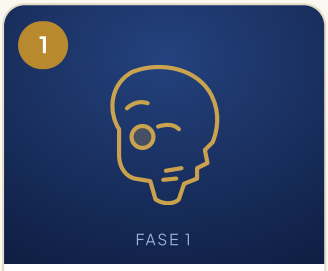
- ! Dolore acuto in rapido aumento
- ! Lussazione recente o blocco in apertura non risolto
- ! Chirurgia recente senza indicazioni del chirurgo
- ! Esercizio che riproduce un click doloroso: modificarlo

Posizionamento

Paziente: seduto davanti a uno specchio, schiena appoggiata.

Fisioterapista: di fronte al paziente per insegnare e correggere.

Esecuzione passo dopo passo



Riscaldamento

Aperture attive lente.



Resistenza

Elastico morbido o mano come resistenza.



Movimenti

Apertura, lateralità e protrusione contro resistenza lieve.



Progressione

Aumenta le ripetizioni prima della resistenza.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Ripetizioni	10 a 15
Serie	2
Frequenza	1 volta al giorno

Criteri di rivalutazione

APERTURA MASSIMA
____ mm
senza dolore e massima, con calibro

DOLORE (NRS 0 A 10)
____ / 10
a riposo e in funzione

TRAIETTORIA
Retta / Deviata
osservata allo specchio

Punti chiave

- ✓ Progressione graduale
- ✓ Monitora la risposta nelle 24 ore
- ✓ Senza dolore

Errori da evitare

- ! Carichi elevati
- ! Progressione rapida
- ! Uso in fase acuta

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Resistenza leggera	Apertura contro la mano con resistenza lieve	10 ripetizioni, 1 volta al giorno

! **Nota clinica.** Il carico progressivo prepara i tessuti alle richieste della vita quotidiana.

Bibliografia essenziale

1. Armijo-Olivo S. et al. Effectiveness of manual therapy and therapeutic exercise for temporomandibular disorders: systematic review and meta-analysis. Phys Ther. 2016;96(1):9–25.
2. List T., Jensen R.H. Temporomandibular disorders: old ideas and new concepts. Cephalalgia. 2017;37(7):692–704.

PROTOCOLLO 63

Allenamento propriocettivo mandibolare

Migliorare la percezione della posizione mandibolare

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	Mialgia, artralgia, disturbi del controllo	5 a 10 minuti	Ogni giorno a domicilio

Indicazioni

- ✓ Scarsa consapevolezza della posizione
- ✓ Parafunzioni
- ✓ Dopo lunga immobilità

Controindicazioni e precauzioni

- ! Dolore acuto in rapido aumento
- ! Lussazione recente o blocco in apertura non risolto
- ! Chirurgia recente senza indicazioni del chirurgo
- ! Esercizio che riproduce un click doloroso: modificarlo

Posizionamento

Paziente: seduto davanti a uno specchio, schiena appoggiata.

Fisioterapista: di fronte al paziente per insegnare e correggere.

Esecuzione passo dopo passo



Riferimento

Apri fino a una posizione di riferimento con gli occhi aperti.



Ripetizione cieca

Ripeti a occhi chiusi cercando la stessa posizione.



Verifica

Controlla allo specchio.



Variazione

Cambia posizione di riferimento.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Ripetizioni	10
Serie	2 al giorno
Criterio	precisione

Criteri di rivalutazione

APERTURA MASSIMA
____ mm
senza dolore e massima, con calibro

DOLORE (NRS 0 A 10)
____ / 10
a riposo e in funzione

TRAIETTORIA
Retta / Deviata
osservata allo specchio

Punti chiave

- ✓ La precisione conta più dell'ampiezza
- ✓ Feedback immediato
- ✓ Esercizio breve e frequente

Errori da evitare

- ! Movimenti ampi
- ! Velocità elevata
- ! Saltare la verifica

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Riposizionamento	Ritrovare a occhi chiusi una posizione di apertura	10 ripetizioni, 2 volte al giorno

! **Nota clinica.** La propriocezione mandibolare migliorata favorisce movimenti più economici e meno dolorosi.

Bibliografia essenziale

1. Armijo-Olivo S. et al. Effectiveness of manual therapy and therapeutic exercise for temporomandibular disorders: systematic review and meta-analysis. Phys Ther. 2016;96(1):9–25.
2. List T., Jensen R.H. Temporomandibular disorders: old ideas and new concepts. Cephalalgia. 2017;37(7):692–704.

PROTOCOLLO 64

Correzione della deviazione in apertura

Ridurre la deviazione con esercizi guidati

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	Mialgia, artralgia, disturbi del controllo	5 a 10 minuti	Ogni giorno a domicilio

Indicazioni

- ✓ Deviazione persistente
- ✓ Click in apertura
- ✓ Asimmetria muscolare

Controindicazioni e precauzioni

- ! Dolore acuto in rapido aumento
- ! Lussazione recente o blocco in apertura non risolto
- ! Chirurgia recente senza indicazioni del chirurgo
- ! Esercizio che riproduce un click doloroso: modificarlo

Posizionamento

Paziente: seduto davanti a uno specchio, schiena appoggiata.

Fisioterapista: di fronte al paziente per insegnare e correggere.

Esecuzione passo dopo passo



Guida

Dito sul lato verso cui avviene la deviazione.



Apertura

Apri lentamente opponendoti alla deviazione.



Controllo

Usa lo specchio come feedback.



Riduzione della guida

Diminuisci gradualmente l'aiuto manuale.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Ripetizioni	10
Serie	3 al giorno
Criterio	traiettoria retta

Criteri di rivalutazione

APERTURA MASSIMA
____ mm
senza dolore e massima, con calibro

DOLORE (NRS 0 A 10)
____ / 10
a riposo e in funzione

TRAIETTORIA
Retta / Deviata
osservata allo specchio

Punti chiave

- ✓ Guida leggera
- ✓ Velocità lenta
- ✓ Progressione nel controllo

Errori da evitare

- ! Spinta forte con il dito
- ! Ignorare il dolore
- ! Aperture massimali

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Apertura guidata	Apertura con un dito che corregge la deviazione	10 ripetizioni, 3 volte al giorno

! **Nota clinica.** La deviazione funzionale risponde bene al controllo motorio con feedback.

Bibliografia essenziale

1. Armijo-Olivo S. et al. Effectiveness of manual therapy and therapeutic exercise for temporomandibular disorders: systematic review and meta-analysis. Phys Ther. 2016;96(1):9–25.
2. List T., Jensen R.H. Temporomandibular disorders: old ideas and new concepts. Cephalalgia. 2017;37(7):692–704.

PROTOCOLLO 65

Esercizio eccentrico in chiusura

Migliorare il controllo eccentrico degli abbassatori

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	Mialgia, artralgia, disturbi del controllo	5 a 10 minuti	Ogni giorno a domicilio

Indicazioni

- ✓ Chiusura rapida o a scatti
- ✓ Scarso controllo
- ✓ Fase avanzata

Controindicazioni e precauzioni

- ! Dolore acuto in rapido aumento
- ! Lussazione recente o blocco in apertura non risolto
- ! Chirurgia recente senza indicazioni del chirurgo
- ! Esercizio che riproduce un click doloroso: modificarlo

Posizionamento

Paziente: seduto davanti a uno specchio, schiena appoggiata.

Fisioterapista: di fronte al paziente per insegnare e correggere.

Esecuzione passo dopo passo



Apertura

Apri fino al limite confortevole.



Resistenza

Mano sotto il mento offre una lieve resistenza.



Chiusura lenta

Chiudi lentamente contro la resistenza in 4 secondi.



Rilascio

Rilassa a fine movimento.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Ripetizioni	8 a 10
Durata	4 secondi per ripetizione
Serie	2

Criteri di rivalutazione

APERTURA MASSIMA
____ mm
senza dolore e massima, con calibro

DOLORE (NRS 0 A 10)
____ / 10
a riposo e in funzione

TRAIETTORIA
Retta / Deviata
osservata allo specchio

Punti chiave

- ✓ Controllo della velocità
- ✓ Resistenza lieve
- ✓ Nessun click

Errori da evitare

- ! Velocità elevata
- ! Resistenza eccessiva
- ! Esecuzione con dolore

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Chiusura lenta	Chiusura in 4 secondi contro lieve resistenza	8 ripetizioni, 2 volte al giorno

! **Nota clinica.** Il controllo eccentrico migliora la qualità del movimento e riduce i rumori.

Bibliografia essenziale

1. Armijo-Olivo S. et al. Effectiveness of manual therapy and therapeutic exercise for temporomandibular disorders: systematic review and meta-analysis. Phys Ther. 2016;96(1):9–25.
2. List T., Jensen R.H. Temporomandibular disorders: old ideas and new concepts. Cephalalgia. 2017;37(7):692–704.

PROTOCOLLO 66

Autoallungamento in apertura

Mantenere e aumentare il range di apertura a domicilio

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	Mialgia, artralgia, disturbi del controllo	5 a 10 minuti	Ogni giorno a domicilio

Indicazioni

- ✓ Ipomobilità muscolare
- ✓ Mantenimento dei risultati
- ✓ Rigidità mattutina

Controindicazioni e precauzioni

- ! Dolore acuto in rapido aumento
- ! Lussazione recente o blocco in apertura non risolto
- ! Chirurgia recente senza indicazioni del chirurgo
- ! Esercizio che riproduce un click doloroso: modificarlo

Posizionamento

Paziente: seduto davanti a uno specchio, schiena appoggiata.

Fisioterapista: di fronte al paziente per insegnare e correggere.

Esecuzione passo dopo passo



Riscaldamento
Calore umido o aperture lente.



Presa
Dita sugli incisivi inferiori.



Allungamento
Apri fino a una tensione confortevole e mantieni.



Respirazione
Respira lentamente durante la tenuta.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Tenuta	30 secondi
Ripetizioni	3
Frequenza	2 volte al giorno

Criteri di rivalutazione

APERTURA MASSIMA
____ mm
senza dolore e massima, con calibro

DOLORE (NRS 0 A 10)
____ / 10
a riposo e in funzione

TRAIETTORIA
Retta / Deviata
osservata allo specchio

Punti chiave

- ✓ Tensione, mai dolore
- ✓ Associa la respirazione
- ✓ Misura l'apertura ogni settimana

Errori da evitare

- ! Rimbalzi
- ! Allungare con dolore preauricolare
- ! Spingere sugli incisivi superiori

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Autoallungamento	Apertura assistita con le dita mantenuta	3 x 30 secondi, 2 volte al giorno

! **Nota clinica.** Se compare dolore articolare durante l'allungamento, riduci l'ampiezza e rivaluta.

Bibliografia essenziale

1. Armijo-Olivo S. et al. Effectiveness of manual therapy and therapeutic exercise for temporomandibular disorders: systematic review and meta-analysis. Phys Ther. 2016;96(1):9–25.
2. List T., Jensen R.H. Temporomandibular disorders: old ideas and new concepts. Cephalalgia. 2017;37(7):692–704.

PROTOCOLLO 67

Controllo della postura linguale in deglutizione

Correggere la deglutizione con spinta linguale

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	Disturbi del controllo orale	5 a 10 minuti	Ogni giorno a domicilio

Indicazioni

- ✓ Deglutizione atipica
- ✓ Interposizione linguale
- ✓ Tensione sopraioidea

Controindicazioni e precauzioni

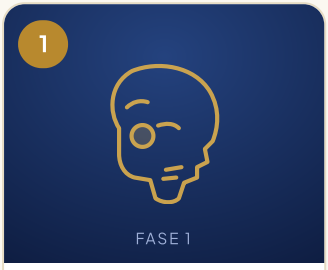
- ! Dolore acuto in rapido aumento
- ! Lussazione recente o blocco in apertura non risolto
- ! Chirurgia recente senza indicazioni del chirurgo
- ! Esercizio che riproduce un click doloroso: modificarlo

Posizionamento

Paziente: seduto davanti a uno specchio, schiena appoggiata.

Fisioterapista: di fronte al paziente per insegnare e correggere.

Esecuzione passo dopo passo



Posizione

Punta della lingua al palato dietro gli incisivi.



Deglutizione

Deglutisci un sorso d'acqua mantenendo la lingua.



Labbra

Labbra rilassate, senza contrazione del mento.



Ripetizione

Ripeti con piccoli sorsi.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Ripetizioni	10
Serie	3 al giorno
Supporto	specchio

Criteri di rivalutazione

APERTURA MASSIMA
____ mm
senza dolore e massima, con calibro

DOLORE (NRS 0 A 10)
____ / 10
a riposo e in funzione

TRAIETTORIA
Retta / Deviata
osservata allo specchio

Punti chiave

- ✓ Collabora con il logopedista se necessario
- ✓ Movimento lento
- ✓ Feedback allo specchio

Errori da evitare

- ! Contrarre il mento
- ! Spingere la lingua sui denti
- ! Sorsi troppo grandi

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Deglutizione corretta	Deglutire piccoli sorsi con lingua al palato	10 ripetizioni, 3 volte al giorno

! **Nota clinica.** In caso di deglutizione atipica strutturata, coinvolgi il logopedista.

Bibliografia essenziale

1. Armijo-Olivo S. et al. Effectiveness of manual therapy and therapeutic exercise for temporomandibular disorders: systematic review and meta-analysis. Phys Ther. 2016;96(1):9–25.
2. List T., Jensen R.H. Temporomandibular disorders: old ideas and new concepts. Cephalalgia. 2017;37(7):692–704.

PROTOCOLLO 68

Apertura progressiva con abbassalingua

Aumentare gradualmente il range con un metodo misurabile

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	Ipomobilità	5 a 10 minuti	Ogni giorno a domicilio

Indicazioni

- ✓ Ipomobilità
- ✓ Trisma in fase di recupero
- ✓ Necessità di un obiettivo misurabile

Controindicazioni e precauzioni

- ! Dolore acuto in rapido aumento
- ! Lussazione recente o blocco in apertura non risolto
- ! Chirurgia recente senza indicazioni del chirurgo
- ! Esercizio che riproduce un click doloroso: modificarlo

Posizionamento

Paziente: seduto davanti a uno specchio, schiena appoggiata.

Fisioterapista: di fronte al paziente per insegnare e correggere.

Esecuzione passo dopo passo



Misura iniziale

Conta quanti abbassalingua sovrapposti entrano tra gli incisivi senza dolore.



Mantenimento

Mantieni l'apertura per il tempo indicato.



Progressione

Aggiungi un abbassalingua quando è facile.



Registrazione

Annota il numero ogni giorno.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Tenuta	da 30 secondi a 5 minuti
Frequenza	3 volte al giorno
Progressione	+1 abbassalingua quando tollerato

Criteri di rivalutazione

APERTURA MASSIMA	DOLORE (NRS 0 A 10)	TRAIETTORIA
____ mm	____ / 10	Retta / Deviata
senza dolore e massima, con calibro	a riposo e in funzione	osservata allo specchio

Punti chiave

- ✓ Metodo semplice e motivante
- ✓ Progressione lenta
- ✓ Registra i progressi

Errori da evitare

- ! Aggiungere troppi abbassalingua
- ! Tenere con dolore
- ! Saltare le registrazioni

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Pila di abbassalingua	Mantenere l'apertura con il numero raggiunto	3 volte al giorno

! **Nota clinica.** La misura con gli abbassalingua offre al paziente un feedback concreto dei progressi.

Bibliografia essenziale

1. Armijo-Olivo S. et al. Effectiveness of manual therapy and therapeutic exercise for temporomandibular disorders: systematic review and meta-analysis. Phys Ther. 2016;96(1):9–25.
2. List T., Jensen R.H. Temporomandibular disorders: old ideas and new concepts. Cephalalgia. 2017;37(7):692–704.

PROTOCOLLO 69

Programma domiciliare progressivo in 3 fasi

Organizzare gli esercizi dalla fase acuta al mantenimento

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	Mialgia, artralgia, disturbi del controllo	10 minuti	A ogni cambio di fase

Indicazioni

- ✓ Pianificazione del lavoro a casa
- ✓ Dimissione graduale
- ✓ Prevenzione delle recidive

Controindicazioni e precauzioni

- ! Dolore acuto in rapido aumento
- ! Lussazione recente o blocco in apertura non risolto
- ! Chirurgia recente senza indicazioni del chirurgo
- ! Esercizio che riproduce un click doloroso: modificarlo

Posizionamento

Paziente: seduto davanti a uno specchio, schiena appoggiata.

Fisioterapista: di fronte al paziente per insegnare e correggere.

Esecuzione passo dopo passo



Fase 1

Autogestione, posizione di riposo, aperture lente.



Fase 2

Controllo motorio, coordinazione, isometrie lievi.



Fase 3

Resistenza progressiva e integrazione cervicale.



Mantenimento

Programma breve da continuare dopo la dimissione.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Fase 1	1 a 2 settimane
Fase 2	2 a 4 settimane
Fase 3	dalla 4ª settimana

Criteri di rivalutazione

APERTURA MASSIMA	DOLORE (NRS 0 A 10)	TRAIETTORIA
____ mm	____ / 10	Retta / Deviata
senza dolore e massima, con calibro	a riposo e in funzione	osservata allo specchio

Punti chiave

- ✓ Passa alla fase successiva in base ai criteri, non al calendario
- ✓ Scheda scritta per ogni fase
- ✓ Verifica l'aderenza

Errori da evitare

- ! Troppi esercizi insieme
- ! Saltare le fasi
- ! Nessun programma di mantenimento

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Programma di mantenimento	3 esercizi scelti insieme al paziente	5 minuti al giorno

! **Nota clinica.** Un programma per fasi chiaro migliora l'aderenza e riduce le ricadute.

Bibliografia essenziale

1. Armijo-Olivo S. et al. Effectiveness of manual therapy and therapeutic exercise for temporomandibular disorders: systematic review and meta-analysis. Phys Ther. 2016;96(1):9–25.
2. List T., Jensen R.H. Temporomandibular disorders: old ideas and new concepts. Cephalalgia. 2017;37(7):692–704.

PROTOCOLLO 70

Test di flessione cranio-cervicale

Valutare il controllo dei flessori profondi del collo

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	DTM con componente cervicale	10 minuti	Valutazione iniziale

Indicazioni

- ✓ Dolore cervicale associato
- ✓ Cefalea
- ✓ Postura con capo in avanti

Controindicazioni e precauzioni

- ! Segni di insufficienza vascolare (vertigini, diplopia, disartria, disfagia)
- ! Instabilità cervicale sospetta (traumi, artrite reumatoide)
- ! Sintomi neurologici agli arti superiori
- ! Trauma cervicale recente non valutato dal medico

Posizionamento

Paziente: supino, capo in posizione neutra.

Fisioterapista: alla testa del lettino.

Esecuzione passo dopo passo



Posizione

Supino, ginocchia flesse, biofeedback a pressione sotto il collo gonfiato a 20 mmHg.



Movimento

Annuisci lentamente senza sollevare il capo.



Livelli

Raggiungi e mantieni 22, 24, 26, 28 e 30 mmHg.



Valutazione

Registra il livello mantenuto 10 secondi senza compensi.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Tenuta	10 secondi per livello
Livelli	da 22 a 30 mmHg
Compensi	superficiali, retrazione, apnea

Criteri di rivalutazione

DOLORE CERVICALE (NRS)
____ / 10
a riposo e in movimento

MOBILITÀ
____°
rotazione o flessione

SINTOMI MANDIBOLARI
Migliorati / Invariati
dopo il trattamento

Punti chiave

- ✓ Osserva lo SCM: deve restare rilassato
- ✓ Movimento piccolo e lento
- ✓ Registra il livello raggiunto

Errori da evitare

- ! Sollevare il capo
- ! Spingere con la lingua o i denti
- ! Trattenere il respiro

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Annuire lento	Piccolo cenno di sì da supino mantenuto 10 secondi	10 ripetizioni, 1 volta al giorno

! **Nota clinica.** Il test diventa anche esercizio: si allena al livello raggiunto con buona qualità.

Bibliografia essenziale

1. La Touche R. et al. The effects of manual therapy and exercise directed at the cervical spine on pain and pressure pain sensitivity in patients with myofascial temporomandibular disorders. J Oral Rehabil. 2009;36(9):644–652.
2. Jull G.A., O'Leary S.P., Falla D.L. Clinical assessment of the deep cervical flexor muscles: the craniocervical flexion test. J Manipulative Physiol Ther. 2008;31(7):525–533.

PROTOCOLLO 71

Allenamento dei flessori profondi del collo

Migliorare il controllo cervicale con progressione del test cranio-cervicale

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	DTM con componente cervicale	8 a 10 minuti	2 sedute a settimana

Indicazioni

- ✓ Deficit al test di flessione cranio-cervicale
- ✓ Cefalea cervicogenica
- ✓ Dolore cervicale associato ai DTM

Controindicazioni e precauzioni

- ! Segni di insufficienza vascolare (vertigini, diplopia, disartria, disfagia)
- ! Instabilità cervicale sospetta (traumi, artrite reumatoide)
- ! Sintomi neurologici agli arti superiori
- ! Trauma cervicale recente non valutato dal medico

Posizionamento

Paziente: supino, capo in posizione neutra.

Fisioterapista: alla testa del lettino.

Esecuzione passo dopo passo

1



FASE 1

Livello di partenza

Inizia dal livello mantenuto senza compensi.

2



FASE 2

Tenuta

Mantieni 10 secondi respirando normalmente.

3



FASE 3

Ripetizioni

Ripeti fino a 10 volte con buona qualità.

4



FASE 4

Progressione

Sali di 2 mmHg quando completi 10 x 10 secondi.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Tenuta	10 secondi
Ripetizioni	10
Frequenza	1 volta al giorno

Criteri di rivalutazione

DOLORE CERVICALE (NRS)
____ / 10
a riposo e in movimento

MOBILITÀ
____°
rotazione o flessione

SINTOMI MANDIBOLARI
Migliorati / Invariati
dopo il trattamento

Punti chiave

- ✓ Qualità prima della quantità
- ✓ Lingua rilassata al palato
- ✓ Progressione lenta

Errori da evitare

- ! Usare i muscoli superficiali
- ! Saltare i livelli
- ! Allenarsi con dolore

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Flessione cranio-cervicale	Cenno di sì da supino con asciugamano sotto il collo	10 x 10 secondi, 1 volta al giorno

! **Nota clinica.** L'allenamento dei flessori profondi riduce il dolore cervicale e la cefalea associata.

Bibliografia essenziale

1. La Touche R. et al. The effects of manual therapy and exercise directed at the cervical spine on pain and pressure pain sensitivity in patients with myofascial temporomandibular disorders. J Oral Rehabil. 2009;36(9):644–652.
2. Jull G.A., O'Leary S.P., Falla D.L. Clinical assessment of the deep cervical flexor muscles: the craniocervical flexion test. J Manipulative Physiol Ther. 2008;31(7):525–533.

PROTOCOLLO 72

Mobilizzazione occipito-atlantoidea (Co-C1)

Migliorare la mobilità della giunzione cranio-cervicale

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	DTM con componente cervicale	8 a 10 minuti	2 sedute a settimana

Indicazioni

- ✓ Rigidità cervicale alta
- ✓ Postura con capo in avanti
- ✓ Cefalea occipitale

Controindicazioni e precauzioni

- ! Segni di insufficienza vascolare (vertigini, diplopia, disartria, disfagia)
- ! Instabilità cervicale sospetta (traumi, artrite reumatoide)
- ! Sintomi neurologici agli arti superiori
- ! Trauma cervicale recente non valutato dal medico

Posizionamento

Paziente: supino, capo in posizione neutra.

Fisioterapista: alla testa del lettino.

Esecuzione passo dopo passo

1



FASE 1

Presa

Mani sotto l'occipite, dita sulle masse laterali di C1.

2



FASE 2

Trazione

Leggera trazione craniale.

3



FASE 3

Movimento

Piccoli movimenti di flessione dell'occipite su C1.

4



FASE 4

Rivaluta

Controlla mobilità e sintomi.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Grado	II e III
Tempo	3 serie da 30 secondi
Pausa	30 secondi

Criteri di rivalutazione

DOLORE CERVICALE (NRS)
____ / 10
a riposo e in movimento

MOBILITÀ
____°
rotazione o flessione

SINTOMI MANDIBOLARI
Migliorati / Invariati
dopo il trattamento

Punti chiave

- ✓ Screening vascolare preliminare
- ✓ Movimenti piccoli e controllati
- ✓ Comunicazione costante

Errori da evitare

- ! Rotazioni ampie
- ! Forza eccessiva
- ! Ignorare vertigini o nausea

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Retrazione del mento	Scivolare il mento indietro mantenendo lo sguardo orizzontale	10 ripetizioni, 3 volte al giorno

! **Nota clinica.** La mobilità cranio-cervicale influenza la posizione di riposo della mandibola.

Bibliografia essenziale

1. La Touche R. et al. The effects of manual therapy and exercise directed at the cervical spine on pain and pressure pain sensitivity in patients with myofascial temporomandibular disorders. J Oral Rehabil. 2009;36(9):644–652.
2. Jull G.A., O'Leary S.P., Falla D.L. Clinical assessment of the deep cervical flexor muscles: the craniocervical flexion test. J Manipulative Physiol Ther. 2008;31(7):525–533.

PROTOCOLLO 73

Mobilizzazione atlanto-assiale (C1-C2)

Recuperare la rotazione cervicale alta

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	DTM con componente cervicale	8 a 10 minuti	2 sedute a settimana

Indicazioni

- ✓ Test flessione-rotazione positivo
- ✓ Cefalea cervicogenica
- ✓ Rotazione cervicale ridotta

Controindicazioni e precauzioni

- ! Segni di insufficienza vascolare (vertigini, diplopia, disartria, disfagia)
- ! Instabilità cervicale sospetta (traumi, artrite reumatoide)
- ! Sintomi neurologici agli arti superiori
- ! Trauma cervicale recente non valutato dal medico

Posizionamento

Paziente: supino, capo in posizione neutra.

Fisioterapista: alla testa del lettino.

Esecuzione passo dopo passo

1



FASE 1

Posizione

Supino, collo in flessione completa.

2



FASE 2

Presa

Mani ai lati del capo.

3



FASE 3

Rotazione

Ruota lentamente verso il lato limitato fino alla resistenza.

4



FASE 4

Oscillazioni

Oscillazioni di piccola ampiezza a fine corsa.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Grado	II e III
Tempo	3 serie da 30 secondi
Pausa	30 secondi

Criteri di rivalutazione

DOLORE CERVICALE (NRS)
____ / 10
a riposo e in movimento

MOBILITÀ
____°
rotazione o flessione

SINTOMI MANDIBOLARI
Migliorati / Invariati
dopo il trattamento

Punti chiave

- ✓ Controlla il test flessione-rotazione dopo la tecnica
- ✓ Movimenti lenti
- ✓ Screening vascolare

Errori da evitare

- ! Rotazione forzata
- ! Trascurare sintomi neurologici
- ! Velocità elevata

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Autorotazione in flessione	Rotazione attiva con mento verso il petto	10 per lato, 2 volte al giorno

! **Nota clinica.** Il miglioramento della rotazione C1–C2 si associa spesso alla riduzione della cefalea.

Bibliografia essenziale

1. La Touche R. et al. The effects of manual therapy and exercise directed at the cervical spine on pain and pressure pain sensitivity in patients with myofascial temporomandibular disorders. J Oral Rehabil. 2009;36(9):644–652.
2. Jull G.A., O'Leary S.P., Falla D.L. Clinical assessment of the deep cervical flexor muscles: the craniocervical flexion test. J Manipulative Physiol Ther. 2008;31(7):525–533.

PROTOCOLLO 74

Retrazione cervicale e allungamento assiale

Correggere la postura con capo in avanti

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	DTM con componente cervicale	8 a 10 minuti	2 sedute a settimana

Indicazioni

- ✓ Postura anteriorizzata del capo
- ✓ Dolore cervicale
- ✓ Tensione dei masticatori

Controindicazioni e precauzioni

- ! Segni di insufficienza vascolare (vertigini, diplopia, disartria, disfagia)
- ! Instabilità cervicale sospetta (traumi, artrite reumatoide)
- ! Sintomi neurologici agli arti superiori
- ! Trauma cervicale recente non valutato dal medico

Posizionamento

Paziente: seduto, schiena appoggiata.

Fisioterapista: di lato al paziente.

Esecuzione passo dopo passo



Posizione

Seduto con schiena appoggiata.



Retrazione

Scivola il mento indietro mantenendo lo sguardo orizzontale.



Allungamento

Immagina di crescere verso l'alto.



Mantenimento

Mantieni 5 secondi e rilascia.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Ripetizioni	10
Mantenimento	5 secondi
Frequenza	3 volte al giorno

Criteri di rivalutazione

DOLORE CERVICALE (NRS)

____ / 10

a riposo e in movimento

MOBILITÀ

____°

rotazione o flessione

SINTOMI MANDIBOLARI

Migliorati / Invariati

dopo il trattamento

Punti chiave

- ✓ Movimento piccolo e preciso
- ✓ Mandibola rilassata
- ✓ Collega a momenti della giornata

Errori da evitare

- ! Flettere il capo in basso
- ! Contrarre le spalle
- ! Movimenti bruschi

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Retrazione del mento	Mento indietro con sguardo orizzontale	10 ripetizioni, 3 volte al giorno

! **Nota clinica.** La postura del capo influenza la posizione mandibolare e il carico muscolare.

Bibliografia essenziale

1. La Touche R. et al. The effects of manual therapy and exercise directed at the cervical spine on pain and pressure pain sensitivity in patients with myofascial temporomandibular disorders. J Oral Rehabil. 2009;36(9):644–652.
2. Jull G.A., O'Leary S.P., Falla D.L. Clinical assessment of the deep cervical flexor muscles: the craniocervical flexion test. J Manipulative Physiol Ther. 2008;31(7):525–533.

PROTOCOLLO 75

Rinforzo dei muscoli scapolari

Migliorare la postura del cingolo scapolare

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	DTM con componente cervicale	8 a 10 minuti	2 sedute a settimana

Indicazioni

- ✓ Spalle anteriorizzate
- ✓ Dolore cervicale e trapezio superiore
- ✓ Lavoro prolungato al computer

Controindicazioni e precauzioni

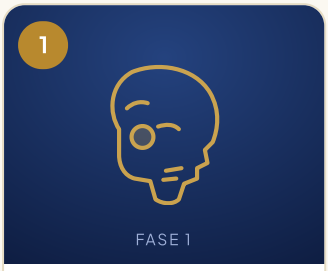
- ! Segni di insufficienza vascolare (vertigini, diplopia, disartria, disfagia)
- ! Instabilità cervicale sospetta (traumi, artrite reumatoide)
- ! Sintomi neurologici agli arti superiori
- ! Trauma cervicale recente non valutato dal medico

Posizionamento

Paziente: in piedi o seduto.

Fisioterapista: di fronte al paziente con un elastico.

Esecuzione passo dopo passo



Retrazione

Avvicina le scapole senza sollevare le spalle.



Depressione

Abbassa le scapole verso le tasche posteriori.



Elastico

Rematore con elastico leggero.



Postura

Mantieni il capo allineato.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Ripetizioni	12 a 15
Serie	2
Frequenza	3 volte a settimana

Criteri di rivalutazione

DOLORE CERVICALE (NRS)
____ / 10
a riposo e in movimento

MOBILITÀ
____ °
rotazione o flessione

SINTOMI MANDIBOLARI
Migliorati / Invariati
dopo il trattamento

Punti chiave

- ✓ Controllo prima della forza
- ✓ Spalle basse
- ✓ Respirazione regolare

Errori da evitare

- ! Sollevare le spalle
- ! Iperestendere il collo
- ! Carichi eccessivi

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Rematore con elastico	Tirare l'elastico avvicinando le scapole	2 x 15, 3 volte a settimana

! **Nota clinica.** Un cingolo scapolare stabile riduce il sovraccarico del trapezio superiore.

Bibliografia essenziale

1. La Touche R. et al. The effects of manual therapy and exercise directed at the cervical spine on pain and pressure pain sensitivity in patients with myofascial temporomandibular disorders. J Oral Rehabil. 2009;36(9):644–652.
2. Jull G.A., O'Leary S.P., Falla D.L. Clinical assessment of the deep cervical flexor muscles: the craniocervical flexion test. J Manipulative Physiol Ther. 2008;31(7):525–533.

PROTOCOLLO 76

Correzione posturale al lavoro

Ridurre il carico cervicale e mandibolare nelle attività quotidiane

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	DTM con componente cervicale	8 a 10 minuti	2 sedute a settimana

Indicazioni

- ✓ Lavoro al computer prolungato
- ✓ Uso intenso dello smartphone
- ✓ Dolore che aumenta nella giornata

Controindicazioni e precauzioni

- ! Segni di insufficienza vascolare (vertigini, diplopia, disartria, disfagia)
- ! Instabilità cervicale sospetta (traumi, artrite reumatoide)
- ! Sintomi neurologici agli arti superiori
- ! Trauma cervicale recente non valutato dal medico

Posizionamento

Paziente: seduto nella postura di lavoro abituale.

Fisioterapista: di fronte al paziente.

Esecuzione passo dopo passo

1



FASE 1

Analisi

Valuta la postazione con foto o descrizione.

2



FASE 2

Schermo

Bordo superiore all'altezza degli occhi.

3



FASE 3

Pause

Pause attive ogni 45 minuti.

4



FASE 4

Smartphone

Portare il telefono all'altezza degli occhi.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Pause	ogni 45 minuti
Durata pausa	1 o 2 minuti
Verifica	dopo 2 settimane

Criteri di rivalutazione

LIMITAZIONE FUNZIONALE	DOLORE (NRS)	ADERENZA
____ / 10	____ / 10	____ %
masticare, parlare, sbadigliare	peggiore della settimana	esercizi svolti a casa

Punti chiave

- ✓ Modifiche piccole e sostenibili
- ✓ Personalizza alla postazione reale
- ✓ Collega alle pause gli esercizi

Errori da evitare

- ! Indicazioni generiche
- ! Ignorare l'uso dello smartphone
- ! Postura rigida per ore

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Pausa attiva	Retrazione del mento, rotazioni lente e posizione di riposo mandibolare	ogni 45 minuti

! **Nota clinica.** L'ergonomia riduce i fattori di mantenimento quotidiani del dolore.

Bibliografia essenziale

1. La Touche R. et al. The effects of manual therapy and exercise directed at the cervical spine on pain and pressure pain sensitivity in patients with myofascial temporomandibular disorders. J Oral Rehabil. 2009;36(9):644–652.
2. Jull G.A., O'Leary S.P., Falla D.L. Clinical assessment of the deep cervical flexor muscles: the craniocervical flexion test. J Manipulative Physiol Ther. 2008;31(7):525–533.

PROTOCOLLO 77

Rilascio e mobilità cervicale globale

Ridurre la tensione cervicale prima del lavoro mandibolare

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	DTM con componente cervicale	5 minuti	Ogni seduta

Indicazioni

- ✓ Tensione cervicale diffusa
- ✓ Dolore muscolare cervicale
- ✓ Preparazione alla terapia mandibolare

Controindicazioni e precauzioni

- ! Segni di insufficienza vascolare (vertigini, diplopia, disartria, disfagia)
- ! Instabilità cervicale sospetta (traumi, artrite reumatoide)
- ! Sintomi neurologici agli arti superiori
- ! Trauma cervicale recente non valutato dal medico

Posizionamento

Paziente: supino, capo in posizione neutra.

Fisioterapista: alla testa del lettino.

Esecuzione passo dopo passo



Trazione

Lieve trazione cervicale manuale.



Rotazioni

Rotazioni passive lente nel range libero.



Inclinazioni

Inclinazioni laterali dolci.



Rilascio

Termina con il rilascio suboccipitale.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Durata	5 minuti
Ritmo	lento
Intensità	confortevole

Criteri di rivalutazione

DOLORE CERVICALE (NRS)
____ / 10
a riposo e in movimento

MOBILITÀ
____ °
rotazione o flessione

SINTOMI MANDIBOLARI
Migliorati / Invariati
dopo il trattamento

Punti chiave

- ✓ Prepara bene il terreno al lavoro locale
- ✓ Movimenti lenti
- ✓ Osserva il rilassamento

Errori da evitare

- ! Movimenti ampi e rapidi
- ! Ignorare vertigini
- ! Trazioni forti

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Mobilità attiva	Rotazioni e inclinazioni lente del capo	5 per direzione, 2 volte al giorno

! **Nota clinica.** Ridurre la tensione cervicale facilita il trattamento dei masticatori.

Bibliografia essenziale

1. La Touche R. et al. The effects of manual therapy and exercise directed at the cervical spine on pain and pressure pain sensitivity in patients with myofascial temporomandibular disorders. J Oral Rehabil. 2009;36(9):644–652.
2. Jull G.A., O'Leary S.P., Falla D.L. Clinical assessment of the deep cervical flexor muscles: the craniocervical flexion test. J Manipulative Physiol Ther. 2008;31(7):525–533.

PROTOCOLLO 78

Esercizi oculomotori

Migliorare il controllo occhio collo nei pazienti con vertigini o instabilità

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	DTM con vertigini o disturbi visivi	8 a 10 minuti	2 sedute a settimana

Indicazioni

- ✓ Vertigini cervicogeniche
- ✓ Difficoltà di fissazione
- ✓ Dolore cervicale con sintomi visivi

Controindicazioni e precauzioni

- ! Segni di insufficienza vascolare (vertigini, diplopia, disartria, disfagia)
- ! Instabilità cervicale sospetta (traumi, artrite reumatoide)
- ! Sintomi neurologici agli arti superiori
- ! Trauma cervicale recente non valutato dal medico

Posizionamento

Paziente: seduto.

Fisioterapista: di fronte al paziente.

Esecuzione passo dopo passo

1



FASE 1

Fissazione

Fissa un bersaglio mentre muovi lentamente il capo.

2



FASE 2

Inseguimento

Segui con gli occhi un dito che si muove, capo fermo.

3



FASE 3

Saccadi

Sposta lo sguardo tra due bersagli.

4



FASE 4

Progressione

Aumenta velocità e ampiezza gradualmente.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Durata	1 minuto per esercizio
Serie	2
Frequenza	2 volte al giorno

Criteri di rivalutazione

DOLORE CERVICALE (NRS)
____ / 10
a riposo e in movimento

MOBILITÀ
____ °
rotazione o flessione

SINTOMI MANDIBOLARI
Migliorati / Invariati
dopo il trattamento

Punti chiave

- ✓ Sintomi lievi e transitori sono accettabili
- ✓ Progressione lenta
- ✓ Ambiente sicuro

Errori da evitare

- ! Esercizi con vertigini intense
- ! Velocità eccessiva
- ! Esecuzione in piedi senza appoggio all'inizio

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Fissazione con movimento del capo	Fissare un bersaglio ruotando lentamente il capo	1 minuto, 2 volte al giorno

! **Nota clinica.** In presenza di vertigini, escludi sempre cause vestibolari centrali o periferiche con il medico.

Bibliografia essenziale

1. La Touche R. et al. The effects of manual therapy and exercise directed at the cervical spine on pain and pressure pain sensitivity in patients with myofascial temporomandibular disorders. J Oral Rehabil. 2009;36(9):644–652.
2. Jull G.A., O'Leary S.P., Falla D.L. Clinical assessment of the deep cervical flexor muscles: the craniocervical flexion test. J Manipulative Physiol Ther. 2008;31(7):525–533.

PROTOCOLLO 79

Stabilità dello sguardo e equilibrio

Integrare controllo posturale e visivo

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	DTM con instabilità	8 a 10 minuti	2 sedute a settimana

Indicazioni

- ✓ Instabilità soggettiva
- ✓ Vertigini associate a dolore cervicale
- ✓ Fase avanzata del recupero

Controindicazioni e precauzioni

- ! Segni di insufficienza vascolare (vertigini, diplopia, disartria, disfagia)
- ! Instabilità cervicale sospetta (traumi, artrite reumatoide)
- ! Sintomi neurologici agli arti superiori
- ! Trauma cervicale recente non valutato dal medico

Posizionamento

Paziente: in piedi, vicino a un appoggio.

Fisioterapista: accanto al paziente per sicurezza.

Esecuzione passo dopo passo



Base stabile

In piedi, piedi uniti, occhi aperti.



Occhi chiusi

Ripeti a occhi chiusi.



Base ridotta

Posizione in tandem.



Movimento del capo

Aggiungi rotazioni lente del capo.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Durata	30 secondi per posizione
Ripetizioni	3
Frequenza	1 volta al giorno

Criteri di rivalutazione

DOLORE CERVICALE (NRS)
____ / 10
a riposo e in movimento

MOBILITÀ
____ °
rotazione o flessione

SINTOMI MANDIBOLARI
Migliorati / Invariati
dopo il trattamento

Punti chiave

- ✓ Sicurezza prima di tutto
- ✓ Vicino a un appoggio
- ✓ Progressione graduale

Errori da evitare

- ! Esercizi senza supporto vicino
- ! Progressione troppo rapida
- ! Ignorare cadute o quasi cadute

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Equilibrio in tandem	Piede davanti all'altro vicino a un muro	3 x 30 secondi

! **Nota clinica.** Il controllo posturale integrato completa il trattamento dei pazienti con vertigini cervicogeniche.

Bibliografia essenziale

1. La Touche R. et al. The effects of manual therapy and exercise directed at the cervical spine on pain and pressure pain sensitivity in patients with myofascial temporomandibular disorders. J Oral Rehabil. 2009;36(9):644–652.
2. Jull G.A., O'Leary S.P., Falla D.L. Clinical assessment of the deep cervical flexor muscles: the craniocervical flexion test. J Manipulative Physiol Ther. 2008;31(7):525–533.

PROTOCOLLO 80

Trattamento della cefalea cervicogenica associata

Ridurre la cefalea originata dal rachide cervicale alto

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	Cefalea cervicogenica e DTM	8 a 10 minuti	2 sedute a settimana

Indicazioni

- ✓ Cefalea unilaterale che parte dal collo
- ✓ Rigidità C1–C2
- ✓ Dolore aggravato dai movimenti del collo

Controindicazioni e precauzioni

- ! Segni di insufficienza vascolare (vertigini, diplopia, disartria, disfagia)
- ! Instabilità cervicale sospetta (traumi, artrite reumatoide)
- ! Sintomi neurologici agli arti superiori
- ! Trauma cervicale recente non valutato dal medico

Posizionamento

Paziente: supino, capo in posizione neutra.

Fisioterapista: alla testa del lettino.

Esecuzione passo dopo passo

1



FASE 1

Valutazione

Test flessione-rotazione e palpazione cervicale alta.

2



FASE 2

Terapia manuale

Mobilizzazione C0–C1 e C1–C2.

3



FASE 3

Esercizio

Flessori profondi e muscoli scapolari.

4



FASE 4

Educazione

Postura e gestione delle attività.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Sedute	6 a 8
Frequenza	2 a settimana
Esercizio	quotidiano

Criteri di rivalutazione

DOLORE CERVICALE (NRS)
____ / 10
a riposo e in movimento

MOBILITÀ
____ °
rotazione o flessione

SINTOMI MANDIBOLARI
Migliorati / Invariati
dopo il trattamento

Punti chiave

- ✓ Combinazione di terapia manuale ed esercizio
- ✓ Monitora frequenza e intensità della cefalea
- ✓ Diario della cefalea

Errori da evitare

- ! Trattare solo la mandibola
- ! Ignorare i segnali di allarme della cefalea
- ! Assenza di esercizio attivo

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Diario della cefalea	Annotare frequenza, durata e intensità	ogni giorno

! **Nota clinica.** Cefalea con caratteristiche nuove o progressive richiede sempre una valutazione medica.

Bibliografia essenziale

1. La Touche R. et al. The effects of manual therapy and exercise directed at the cervical spine on pain and pressure pain sensitivity in patients with myofascial temporomandibular disorders. J Oral Rehabil. 2009;36(9):644–652.
2. Jull G.A., O'Leary S.P., Falla D.L. Clinical assessment of the deep cervical flexor muscles: the craniocervical flexion test. J Manipulative Physiol Ther. 2008;31(7):525–533.

PROTOCOLLO 81

Integrazione mandibola e collo nel movimento

Coordinare apertura mandibolare e postura cervicale

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	DTM con componente cervicale	8 a 10 minuti	2 sedute a settimana

Indicazioni

- ✓ Apertura con estensione compensatoria del capo
- ✓ Scarso controllo combinato
- ✓ Fase avanzata

Controindicazioni e precauzioni

- ! Segni di insufficienza vascolare (vertigini, diplopia, disartria, disfagia)
- ! Instabilità cervicale sospetta (traumi, artrite reumatoide)
- ! Sintomi neurologici agli arti superiori
- ! Trauma cervicale recente non valutato dal medico

Posizionamento

Paziente: seduto, specchio laterale.

Fisioterapista: di lato al paziente.

Esecuzione passo dopo passo

1



FASE 1

Osservazione

Osserva se il capo si estende durante l'apertura.

2



FASE 2

Correzione

Mantieni il capo neutro con una lieve retrazione.

3



FASE 3

Apertura

Apri lentamente senza estendere il collo.

4



FASE 4

Automatizzazione

Ripeti in attività come parlare e masticare.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Ripetizioni	10
Serie	2 al giorno
Supporto	specchio laterale

Criteri di rivalutazione

DOLORE CERVICALE (NRS)

____ / 10

a riposo e in movimento

MOBILITÀ

____°

rotazione o flessione

SINTOMI MANDIBOLARI

Migliorati / Invariati

dopo il trattamento

Punti chiave

- ✓ Feedback visivo laterale
- ✓ Movimenti lenti
- ✓ Integrazione nella vita quotidiana

Errori da evitare

- ! Estendere il capo per aprire
- ! Velocità elevata
- ! Tensione delle spalle

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Apertura con capo neutro	Apertura lenta con mento leggermente retratto	10 ripetizioni, 2 volte al giorno

! **Nota clinica.** Il controllo combinato riduce i compensi cervicali nei movimenti mandibolari.

Bibliografia essenziale

1. La Touche R. et al. The effects of manual therapy and exercise directed at the cervical spine on pain and pressure pain sensitivity in patients with myofascial temporomandibular disorders. J Oral Rehabil. 2009;36(9):644–652.
2. Jull G.A., O'Leary S.P., Falla D.L. Clinical assessment of the deep cervical flexor muscles: the craniocervical flexion test. J Manipulative Physiol Ther. 2008;31(7):525–533.

PROTOCOLLO 82

Respirazione e postura cervicale

Ridurre l'uso dei muscoli accessori respiratori

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	DTM con componente cervicale	8 a 10 minuti	2 sedute a settimana

Indicazioni

- ✓ Respirazione toracica alta
- ✓ Tensione di scaleni e SCM
- ✓ Stress

Controindicazioni e precauzioni

- ! Segni di insufficienza vascolare (vertigini, diplopia, disartria, disfagia)
- ! Instabilità cervicale sospetta (traumi, artrite reumatoide)
- ! Sintomi neurologici agli arti superiori
- ! Trauma cervicale recente non valutato dal medico

Posizionamento

Paziente: supino o seduto.

Fisioterapista: accanto al paziente.

Esecuzione passo dopo passo

1



FASE 1

Osservazione

Valuta il movimento di torace e addome.

2



FASE 2

Diaframma

Mani sull'addome, inspirazione nasale.

3



FASE 3

Spalle

Mantieni le spalle rilassate.

4



FASE 4

Integrazione

Combina con la posizione di riposo mandibolare.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Durata	5 minuti
Ritmo	4 secondi in, 6 secondi out
Frequenza	2 volte al giorno

Criteri di rivalutazione

DOLORE CERVICALE (NRS)
____ / 10
a riposo e in movimento

MOBILITÀ
____°
rotazione o flessione

SINTOMI MANDIBOLARI
Migliorati / Invariati
dopo il trattamento

Punti chiave

- ✓ Spalle ferme durante l'inspirazione
- ✓ Respirazione nasale
- ✓ Mandibola rilassata

Errori da evitare

- ! Respirare con le spalle
- ! Respirazione forzata
- ! Bocca aperta

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Respirazione diaframmatica	Respirazione nasale lenta con mani sull'addome	5 minuti, 2 volte al giorno

! **Nota clinica.** Una respirazione efficiente riduce il sovraccarico dei muscoli cervicali accessori.

Bibliografia essenziale

1. La Touche R. et al. The effects of manual therapy and exercise directed at the cervical spine on pain and pressure pain sensitivity in patients with myofascial temporomandibular disorders. J Oral Rehabil. 2009;36(9):644–652.
2. Jull G.A., O'Leary S.P., Falla D.L. Clinical assessment of the deep cervical flexor muscles: the craniocervical flexion test. J Manipulative Physiol Ther. 2008;31(7):525–533.

PROTOCOLLO 83

Valutazione e gestione dei DTM dopo colpo di frusta

Gestire i sintomi mandibolari nei pazienti con trauma cervicale

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta	DTM post traumatico	8 a 10 minuti	2 sedute a settimana

Indicazioni

- ✓ Dolore mandibolare dopo incidente
- ✓ Dolore cervicale post traumatico
- ✓ Cefalea e vertigini associate

Controindicazioni e precauzioni

- ! Segni di insufficienza vascolare (vertigini, diplopia, disartria, disfagia)
- ! Instabilità cervicale sospetta (traumi, artrite reumatoide)
- ! Sintomi neurologici agli arti superiori
- ! Trauma cervicale recente non valutato dal medico

Posizionamento

Paziente: supino, capo in posizione neutra.

Fisioterapista: alla testa del lettino.

Esecuzione passo dopo passo



Sicurezza
Verifica che il medico abbia escluso fratture e instabilità.



Valutazione
Esame DC/TMD e cervicale completo.



Gestione
Educazione, esercizio graduale e terapia manuale delicata.



Monitoraggio
Fattori psicosociali e recupero funzionale.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Fase iniziale	gestione del dolore e movimento
Progressione	esercizio graduale
Rivalutazione	ogni 4 sedute

Criteri di rivalutazione

DOLORE CERVICALE (NRS)
____ / 10
a riposo e in movimento

MOBILITÀ
____°
rotazione o flessione

SINTOMI MANDIBOLARI
Migliorati / Invariati
dopo il trattamento

Punti chiave

- ✓ Approccio graduale e rassicurante
- ✓ Integra collo e mandibola
- ✓ Attenzione ai fattori psicosociali

Errori da evitare

- ! Trattamento intensivo precoce
- ! Ignorare i segni di allarme
- ! Trascurare il carico emotivo del trauma

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Movimento graduale	Mobilità cervicale e aperture lente nel range confortevole	2 volte al giorno

! **Nota clinica.** I DTM dopo trauma cervicale richiedono un approccio integrato e la collaborazione con il medico.

Bibliografia essenziale

1. La Touche R. et al. The effects of manual therapy and exercise directed at the cervical spine on pain and pressure pain sensitivity in patients with myofascial temporomandibular disorders. J Oral Rehabil. 2009;36(9):644–652.
2. Jull G.A., O'Leary S.P., Falla D.L. Clinical assessment of the deep cervical flexor muscles: the craniocervical flexion test. J Manipulative Physiol Ther. 2008;31(7):525–533.

PROTOCOLLO 84

Bruxismo da veglia

Ridurre serramento e digrignamento diurni con un approccio comportamentale

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	Bruxismo da veglia, mialgia	20 a 30 minuti	1 o 2 sedute a settimana

Indicazioni

- ✓ Serramento riferito o osservato
- ✓ Mialgia che aumenta nella giornata
- ✓ Usura o ipertrofia del massetere

Controindicazioni e precauzioni

- ! Red flags non escluse dal medico
- ! Peggioramento rapido e non spiegato dei sintomi
- ! Condizioni sistemiche non controllate
- ! Assenza di consenso informato del paziente

Posizionamento

Paziente: seduto o supino secondo la fase.

Fisioterapista: di fronte al paziente.

Esecuzione passo dopo passo



Valutazione
Questionario, osservazione e monitoraggio con promemoria.



Educazione
Spiega il ruolo del carico muscolare nel dolore.



Consapevolezza
Promemoria frequenti e posizione di riposo.



Trattamento
Terapia miofasciale ed esercizi di rilassamento.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Monitoraggio	promemoria ogni 30 a 60 minuti
Durata	4 a 6 settimane
Rivalutazione	ogni 2 sedute

Criteri di rivalutazione

LIMITAZIONE FUNZIONALE
____ / 10
masticare, parlare, sbadigliare

DOLORE (NRS)
____ / 10
peggiore della settimana

ADERENZA
____ %
esercizi svolti a casa

Punti chiave

- ✓ Il bruxismo è un comportamento, non una malattia
- ✓ La consapevolezza è l'intervento principale
- ✓ Collabora con l'odontoiatra

Errori da evitare

- ! Prescrivere solo il bite per il bruxismo diurno
- ! Colpevolizzare il paziente
- ! Ignorare i fattori di stress

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Controllo con promemoria	A ogni avviso: labbra chiuse, denti separati, lingua al palato	ogni 30 a 60 minuti

! **Nota clinica.** Il consenso internazionale distingue bruxismo da veglia e da sonno: richiedono strategie diverse.

Bibliografia essenziale

1. Lobbezoo F. et al. International consensus on the assessment of bruxism: report of a work in progress. J Oral Rehabil. 2018;45(11):837–844.
2. Michiels S. et al. Diagnostic criteria for somatosensory tinnitus: a Delphi process and face-to-face meeting to establish consensus. Trends Hear. 2018;22:2331216518796403.

PROTOCOLLO 85

Bruxismo nel sonno

Gestire il dolore associato al bruxismo notturno in collaborazione con l'odontoiatra

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	Bruxismo nel sonno	20 a 30 minuti	1 o 2 sedute a settimana

Indicazioni

- ✓ Dolore mandibolare al risveglio
- ✓ Segnalazione del partner di digrignamento
- ✓ Usura dentale osservata dall'odontoiatra

Controindicazioni e precauzioni

- ! Red flags non escluse dal medico
- ! Peggioramento rapido e non spiegato dei sintomi
- ! Condizioni sistemiche non controllate
- ! Assenza di consenso informato del paziente

Posizionamento

Paziente: seduto o supino secondo la fase.

Fisioterapista: di fronte al paziente.

Esecuzione passo dopo passo



Valutazione
Anamnesi del sonno, partner, segni dentali.



Collaborazione
Invio all'odontoiatra per valutare una placca occlusale.



Fattori
Sonno, apnee sospette, alcol, caffeina, farmaci.



Trattamento
Esercizi mattutini e terapia miofasciale.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Routine mattutina	5 minuti di esercizi
Igiene del sonno	quotidiana
Rivalutazione	ogni 4 sedute

Criteri di rivalutazione

LIMITAZIONE FUNZIONALE
____ / 10
masticare, parlare, sbadigliare

DOLORE (NRS)
____ / 10
peggiore della settimana

ADERENZA
____ %
esercizi svolti a casa

Punti chiave

- ✓ Il fisioterapista gestisce il dolore, l'odontoiatra il dispositivo
- ✓ Sospetta le apnee nel sonno
- ✓ Routine mattutina di scarico

Errori da evitare

- ! Promettere l'eliminazione del bruxismo
- ! Ignorare russamento e sonnolenza diurna
- ! Trascurare i farmaci

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Routine del risveglio	Calore, automassaggio e aperture lente	5 minuti ogni mattina

! **Nota clinica.** Russamento e sonnolenza diurna suggeriscono un invio per valutare apnee nel sonno.

Bibliografia essenziale

1. Lobbezoo F. et al. International consensus on the assessment of bruxism: report of a work in progress. J Oral Rehabil. 2018;45(11):837–844.
2. Michiels S. et al. Diagnostic criteria for somatosensory tinnitus: a Delphi process and face-to-face meeting to establish consensus. Trends Hear. 2018;22:2331216518796403.

PROTOCOLLO 86

Acufene somatosensoriale associato ai DTM

Ridurre l'acufene modulato da mandibola e collo

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	Acufene somatosensoriale	20 a 30 minuti	1 o 2 sedute a settimana

Indicazioni

- ✓ Acufene che varia con i movimenti mandibolari o cervicali
- ✓ DTM o dolore cervicale associati
- ✓ Esclusione di patologie otologiche

Controindicazioni e precauzioni

- ! Acufene pulsante
- ! Calo uditivo improvviso
- ! Vertigini acute o sintomi neurologici
- ! Assenza di valutazione ORL

Posizionamento

Paziente: seduto o supino secondo la fase.

Fisioterapista: di fronte al paziente.

Esecuzione passo dopo passo

1



FASE 1

Prerequisito

Valutazione otorinolaringoiatrica e audiologica già eseguita.

2



FASE 2

Modulazione

Verifica se manovre mandibolari o cervicali modificano l'acufene.

3



FASE 3

Trattamento

Terapia manuale e miofasciale su ATM e collo.

4



FASE 4

Esercizio

Programma domiciliare mandibolare e cervicale.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Sedute	6 a 10
Monitoraggio	intensità e disturbo dell'acufene
Rivalutazione	ogni 4 sedute

Criteri di rivalutazione

LIMITAZIONE FUNZIONALE
____ / 10
masticare, parlare, sbadigliare

DOLORE (NRS)
____ / 10
peggiore della settimana

ADERENZA
____ %
esercizi svolti a casa

Punti chiave

- ✓ Lavora solo dopo la valutazione ORL
- ✓ Misura il disturbo con una scala
- ✓ Aspettative realistiche

Errori da evitare

- ! Trattare senza valutazione audiologica
- ! Promettere la scomparsa dell'acufene
- ! Ignorare acufene pulsante o improvviso

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Esercizi di modulazione	Esercizi mandibolari e cervicali che riducono l'acufene	2 volte al giorno

! **Nota clinica.** L'acufene pulsante, unilaterale improvviso o con calo uditivo richiede sempre una valutazione medica urgente.

Bibliografia essenziale

1. Lobbezoo F. et al. International consensus on the assessment of bruxism: report of a work in progress. J Oral Rehabil. 2018;45(11):837–844.
2. Michiels S. et al. Diagnostic criteria for somatosensory tinnitus: a Delphi process and face-to-face meeting to establish consensus. Trends Hear. 2018;22:2331216518796403.

PROTOCOLLO 87

Cefalea di tipo tensivo associata ai DTM

Gestire la cefalea in presenza di dolore muscolare masticatorio

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	Cefalea tensiva e mialgia	20 a 30 minuti	1 o 2 sedute a settimana

Indicazioni

- ✓ Cefalea frontotemporale a fascia
- ✓ Dolorabilità di temporale e muscoli cervicali
- ✓ Associazione con stress e parafunzioni

Controindicazioni e precauzioni

- ! Red flags non escluse dal medico
- ! Peggioramento rapido e non spiegato dei sintomi
- ! Condizioni sistemiche non controllate
- ! Assenza di consenso informato del paziente

Posizionamento

Paziente: seduto o supino secondo la fase.

Fisioterapista: di fronte al paziente.

Esecuzione passo dopo passo



Classificazione
Escludi le red flags della cefalea e registra le caratteristiche.



Trattamento
Terapia miofasciale di temporale, massetere e suboccipitali.



Esercizio
Flessori profondi e postura.



Autogestione
Diario, sonno e gestione dello stress.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Sedute	6 a 8
Diario	frequenza e intensità della cefalea
Obiettivo	riduzione di almeno il 50 % dei giorni con cefalea

Criteri di rivalutazione

LIMITAZIONE FUNZIONALE
____ / 10
masticare, parlare, sbadigliare

DOLORE (NRS)
____ / 10
peggiore della settimana

ADERENZA
____ %
esercizi svolti a casa

Punti chiave

- ✓ Il diario guida le decisioni
- ✓ Integra mandibola e collo
- ✓ Collabora con il medico se c'è abuso di farmaci

Errori da evitare

- ! Ignorare cefalee nuove o progressive
- ! Trascurare l'uso eccessivo di analgesici
- ! Trattare solo il collo

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Diario della cefalea	Registrare giorni, intensità e farmaci	ogni giorno

! **Nota clinica.** Una cefalea nuova, improvvisa o progressiva va inviata subito al medico.

Bibliografia essenziale

1. Lobbezoo F. et al. International consensus on the assessment of bruxism: report of a work in progress. J Oral Rehabil. 2018;45(11):837–844.
2. Michiels S. et al. Diagnostic criteria for somatosensory tinnitus: a Delphi process and face-to-face meeting to establish consensus. Trends Hear. 2018;22:2331216518796403.

PROTOCOLLO 88

Desensibilizzazione nel dolore persistente

Ridurre la sensibilità del sistema nervoso nei quadri cronici

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	Dolore persistente, sensibilizzazione	20 a 30 minuti	1 o 2 sedute a settimana

Indicazioni

- ✓ Dolore da oltre 3 mesi
- ✓ Dolore diffuso o sproporzionato
- ✓ Elevata sensibilità al tatto

Controindicazioni e precauzioni

- ! Red flags non escluse dal medico
- ! Peggioramento rapido e non spiegato dei sintomi
- ! Condizioni sistemiche non controllate
- ! Assenza di consenso informato del paziente

Posizionamento

Paziente: seduto o supino secondo la fase.

Fisioterapista: di fronte al paziente.

Esecuzione passo dopo passo



Educazione

Spiega il ruolo del sistema nervoso nel dolore persistente.



Stimoli graduati

Tocco leggero e pressioni progressive ben tollerate.



Movimento

Movimenti mandibolari nel range sicuro, aumentando gradualmente.



Contesto

Sonno, stress, attività fisica generale.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Intensità	sempre tollerabile
Progressione	settimanale
Attività fisica	30 minuti, 5 giorni a settimana

Criteri di rivalutazione

LIMITAZIONE FUNZIONALE
____ / 10
masticare, parlare, sbadigliare

DOLORE (NRS)
____ / 10
peggiore della settimana

ADERENZA
____ %
esercizi svolti a casa

Punti chiave

- ✓ Piccoli successi costruiscono fiducia
- ✓ Linguaggio rassicurante
- ✓ Integra attività fisica generale

Errori da evitare

- ! Tecniche dolorose
- ! Focalizzarsi solo sul tessuto
- ! Promettere risultati rapidi

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Attività fisica generale	Camminata a ritmo moderato	30 minuti, 5 giorni a settimana

! **Nota clinica.** Nel dolore persistente l'obiettivo principale è la funzione: il dolore segue nel tempo.

Bibliografia essenziale

1. Lobbezoo F. et al. International consensus on the assessment of bruxism: report of a work in progress. J Oral Rehabil. 2018;45(11):837–844.
2. Michiels S. et al. Diagnostic criteria for somatosensory tinnitus: a Delphi process and face-to-face meeting to establish consensus. Trends Hear. 2018;22:2331216518796403.

PROTOCOLLO 89

Esposizione graduale al movimento mandibolare

Ridurre la paura e l'evitamento di masticazione e apertura

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	Kinesiofobia, evitamento	20 a 30 minuti	1 o 2 sedute a settimana

Indicazioni

- ✓ Evitamento di cibi o attività
- ✓ Paura del movimento mandibolare
- ✓ Dolore persistente

Controindicazioni e precauzioni

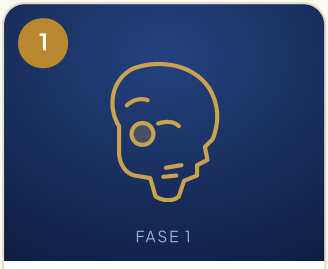
- ! Red flags non escluse dal medico
- ! Peggioramento rapido e non spiegato dei sintomi
- ! Condizioni sistemiche non controllate
- ! Assenza di consenso informato del paziente

Posizionamento

Paziente: seduto o supino secondo la fase.

Fisioterapista: di fronte al paziente.

Esecuzione passo dopo passo



Gerarchia
Elenca con il paziente le attività temute, dalla più facile alla più difficile.



Primo passo
Inizia dall'attività meno temuta.



Ripetizione
Ripeti finché l'ansia si riduce.



Progressione
Passa all'attività successiva.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Gerarchia	5 a 10 attività
Frequenza	esposizione quotidiana
Revisione	ogni seduta

Criteri di rivalutazione

LIMITAZIONE FUNZIONALE	DOLORE (NRS)	ADERENZA
____ / 10	____ / 10	____ %
masticare, parlare, sbadigliare	peggiore della settimana	esercizi svolti a casa

Punti chiave

- ✓ Il paziente sceglie il ritmo
- ✓ Celebra i progressi
- ✓ Collega alle attività significative

Errori da evitare

- ! Saltare i passi
- ! Esporre senza preparazione
- ! Ignorare la paura

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Esposizione quotidiana	Eseguire l'attività del livello raggiunto	ogni giorno

! **Nota clinica.** Esempio di gerarchia: pane morbido, mela a fette, panino, mela intera.

Bibliografia essenziale

1. Lobbezoo F. et al. International consensus on the assessment of bruxism: report of a work in progress. J Oral Rehabil. 2018;45(11):837–844.
2. Michiels S. et al. Diagnostic criteria for somatosensory tinnitus: a Delphi process and face-to-face meeting to establish consensus. Trends Hear. 2018;22:2331216518796403.

PROTOCOLLO 90

Gestione dello stress nel paziente con DTM

Ridurre l'impatto dello stress sul dolore e sulle parafunzioni

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	Dolore e stress	20 a 30 minuti	1 o 2 sedute a settimana

Indicazioni

- ✓ Stress elevato riferito
- ✓ Peggioramento del dolore nei periodi stressanti
- ✓ Serramento in situazioni di tensione

Controindicazioni e precauzioni

- ! Red flags non escluse dal medico
- ! Peggioramento rapido e non spiegato dei sintomi
- ! Condizioni sistemiche non controllate
- ! Assenza di consenso informato del paziente

Posizionamento

Paziente: seduto o supino secondo la fase.

Fisioterapista: di fronte al paziente.

Esecuzione passo dopo passo



Riconoscimento
Collega stress, serramento e dolore con il diario.



Strategie
Respirazione lenta e rilassamento muscolare progressivo.



Attività
Attività fisica e pause programmate.



Invio
Proponi lo psicologo quando lo stress è elevato.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Rilassamento	10 minuti al giorno
Diario	1 settimana
Rivalutazione	ogni 4 sedute

Criteri di rivalutazione

LIMITAZIONE FUNZIONALE
____ / 10
masticare, parlare, sbadigliare

DOLORE (NRS)
____ / 10
peggiore della settimana

ADERENZA
____ %
esercizi svolti a casa

Punti chiave

- ✓ Approccio non giudicante
- ✓ Strategie pratiche e brevi
- ✓ Collaborazione con lo psicologo

Errori da evitare

- ! Minimizzare lo stress riferito
- ! Diagnosi psicologiche improprie
- ! Strategie troppo complesse

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Rilassamento progressivo	Contrarre e rilassare i gruppi muscolari dal volto ai piedi	10 minuti al giorno

! **Nota clinica.** Il fisioterapista riconosce lo stress come fattore di rischio e coordina l'invio quando serve.

Bibliografia essenziale

1. Lobbezoo F. et al. International consensus on the assessment of bruxism: report of a work in progress. J Oral Rehabil. 2018;45(11):837–844.
2. Michiels S. et al. Diagnostic criteria for somatosensory tinnitus: a Delphi process and face-to-face meeting to establish consensus. Trends Hear. 2018;22:2331216518796403.

PROTOCOLLO 91

Ipermobilità e lussazione ricorrente dell'ATM

Migliorare il controllo dell'apertura e prevenire le lussazioni

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	Ipermobilità, sublussazione	20 a 30 minuti	1 o 2 sedute a settimana

Indicazioni

- ✓ Apertura eccessiva con scatto
- ✓ Episodi di bocca bloccata aperta
- ✓ Ipermobilità generalizzata

Controindicazioni e precauzioni

- ! Lussazione in atto non ridotta
- ! Frattura sospetta
- ! Dolore acuto intenso
- ! Tecniche di mobilizzazione in traslazione

Posizionamento

Paziente: seduto o supino secondo la fase.

Fisioterapista: di fronte al paziente.

Esecuzione passo dopo passo



Educazione
Evita aperture massimali, sbadiglia con la lingua al palato.



Controllo
Apertura con lingua al palato e isometrie lievi.



Stabilizzazione
Esercizi di controllo motorio progressivi.



Gestione degli episodi
Spiega cosa fare in caso di blocco e quando andare al pronto soccorso.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Esercizi	10 ripetizioni, 3 volte al giorno
Durata	6 a 8 settimane
Rivalutazione	ogni 4 sedute

Criteri di rivalutazione

LIMITAZIONE FUNZIONALE
____ / 10
masticare, parlare, sbadigliare

DOLORE (NRS)
____ / 10
peggiore della settimana

ADERENZA
____ %
esercizi svolti a casa

Punti chiave

- ✓ Il controllo motorio è il cardine del trattamento
- ✓ Mai mobilizzazioni in traslazione
- ✓ Collabora con l'odontoiatra

Errori da evitare

- ! Mobilizzare un'articolazione ipermobile
- ! Esercizi di allungamento in apertura
- ! Ignorare episodi di lussazione

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Sbadiglio controllato	Lingua al palato e mano sotto il mento durante lo sbadiglio	a ogni sbadiglio

! **Nota clinica.** In caso di lussazione che non si riduce, il paziente deve rivolgersi al pronto soccorso.

Bibliografia essenziale

1. Lobbezoo F. et al. International consensus on the assessment of bruxism: report of a work in progress. J Oral Rehabil. 2018;45(11):837–844.
2. Michiels S. et al. Diagnostic criteria for somatosensory tinnitus: a Delphi process and face-to-face meeting to establish consensus. Trends Hear. 2018;22:2331216518796403.

PROTOCOLLO 92

Artrosi dell'ATM (malattia degenerativa)

Gestire dolore e funzione nella degenerazione articolare

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	Malattia degenerativa articolare	20 a 30 minuti	1 o 2 sedute a settimana

Indicazioni

- ✓ Crepitio grossolano
- ✓ Dolore articolare in masticazione
- ✓ Età avanzata o storia di DTM di lunga durata

Controindicazioni e precauzioni

- ! Trauma recente, sospetta frattura o lussazione
- ! Infezione o infiammazione articolare acuta
- ! Chirurgia dell'ATM recente senza nulla osta
- ! Ipermobilità o lussazioni ricorrenti: procedere con cautela

Posizionamento

Paziente: seduto o supino secondo la fase.

Fisioterapista: di fronte al paziente.

Esecuzione passo dopo passo



Educazione
Spiega la natura spesso autolimitante dei sintomi.



Gestione del carico
Dieta adattata e masticazione bilaterale.



Terapia manuale
Distrazione delicata per il dolore.



Esercizio
Mobilità e controllo motorio senza dolore.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Terapia manuale	grado I e II
Esercizio	quotidiano
Rivalutazione	ogni 4 sedute

Criteri di rivalutazione

APERTURA MASSIMA
____ mm
senza dolore e massima, con calibro

DOLORE (NRS 0 A 10)
____ / 10
a riposo e in funzione

TRAIETTORIA
Retta / Deviata
osservata allo specchio

Punti chiave

- ✓ I sintomi tendono a migliorare nel tempo
- ✓ Gestione del carico, non immobilità
- ✓ Collabora con l'odontoiatra e il medico

Errori da evitare

- ! Comunicare un messaggio di usura irreversibile
- ! Mobilizzazioni aggressive
- ! Dieta eccessivamente restrittiva a lungo

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Mobilità quotidiana	Aperture e lateralità lente nel range confortevole	10 ripetizioni, 2 volte al giorno

! **Nota clinica.** Molti pazienti con artrosi dell'ATM migliorano con trattamento conservativo nel medio periodo.

Bibliografia essenziale

1. Lobbezoo F. et al. International consensus on the assessment of bruxism: report of a work in progress. J Oral Rehabil. 2018;45(11):837–844.
2. Michiels S. et al. Diagnostic criteria for somatosensory tinnitus: a Delphi process and face-to-face meeting to establish consensus. Trends Hear. 2018;22:2331216518796403.

PROTOCOLLO 93

ATM nelle artriti infiammatorie

Supportare funzione e dolore in collaborazione con il reumatologo

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	Artrite infiammatoria	20 a 30 minuti	1 o 2 sedute a settimana

Indicazioni

- ✓ Artrite reumatoide, psoriasica o idiopatica giovanile
- ✓ Rigidità mattutina articolare
- ✓ Dolore bilaterale fluttuante

Controindicazioni e precauzioni

- ! Trauma recente, sospetta frattura o lussazione
- ! Infezione o infiammazione articolare acuta
- ! Chirurgia dell'ATM recente senza nulla osta
- ! Ipermobilità o lussazioni ricorrenti: procedere con cautela
- ! Instabilità cervicale nelle artriti infiammatorie

Posizionamento

Paziente: seduto o supino secondo la fase.

Fisioterapista: di fronte al paziente.

Esecuzione passo dopo passo



Collaborazione
Verifica la terapia e la fase della malattia con il reumatologo.



Fase attiva
Gestione del dolore e mobilità dolce.



Fase quiescente
Esercizio per mobilità e funzione.



Monitoraggio
Cambiamenti di occlusione e apertura.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Fase attiva	solo tecniche delicate
Esercizio	quotidiano e leggero
Comunicazione	con il reumatologo

Criteri di rivalutazione

APERTURA MASSIMA
____ mm
senza dolore e massima, con calibro

DOLORE (NRS 0 A 10)
____ / 10
a riposo e in funzione

TRAIETTORIA
Retta / Deviata
osservata allo specchio

Punti chiave

- ✓ Adatta il trattamento alla fase della malattia
- ✓ Monitora l'occlusione
- ✓ Coinvolgi il medico

Errori da evitare

- ! Mobilizzazioni intense nella fase attiva
- ! Ignorare cambi di occlusione
- ! Trattare senza diagnosi medica

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Mobilità leggera	Aperture lente al mattino dopo il calore	10 ripetizioni ogni mattina

! **Nota clinica.** Nelle artriti infiammatorie il cervicale alto può essere instabile: evita tecniche cervicali ad alta velocità.

Bibliografia essenziale

1. Lobbezoo F. et al. International consensus on the assessment of bruxism: report of a work in progress. J Oral Rehabil. 2018;45(11):837–844.
2. Michiels S. et al. Diagnostic criteria for somatosensory tinnitus: a Delphi process and face-to-face meeting to establish consensus. Trends Hear. 2018;22:2331216518796403.

PROTOCOLLO 94

Trisma dopo trattamenti oncologici del distretto testa collo

Recuperare l'apertura in collaborazione con l'équipe oncologica

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	Trisma post oncologico	20 a 30 minuti	1 o 2 sedute a settimana

Indicazioni

- ✓ Riduzione dell'apertura dopo radioterapia o chirurgia
- ✓ Difficoltà nell'igiene orale e nell'alimentazione
- ✓ Paziente inviato dall'équipe oncologica

Controindicazioni e precauzioni

- ! Assenza di autorizzazione dell'équipe oncologica
- ! Lesioni dei tessuti irradiati
- ! Infezioni del cavo orale
- ! Segni di recidiva

Posizionamento

Paziente: seduto o supino secondo la fase.

Fisioterapista: di fronte al paziente.

Esecuzione passo dopo passo

1



FASE 1

Autorizzazione

Accordo con l'équipe oncologica su tempi e limiti.

2



FASE 2

Esercizio frequente

Aperture attive e allungamenti brevi più volte al giorno.

3



FASE 3

Dispositivi

Uso di dispositivi di apertura se prescritti.

4



FASE 4

Monitoraggio

Misura dell'apertura ogni settimana.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Esercizio	5 volte al giorno
Allungamento	30 secondi, 5 ripetizioni
Misura	settimanale

Criteri di rivalutazione

APERTURA MASSIMA
____ mm
senza dolore e massima, con calibro

DOLORE (NRS 0 A 10)
____ / 10
a riposo e in funzione

TRAIETTORIA
Retta / Deviata
osservata allo specchio

Punti chiave

- ✓ La costanza quotidiana è determinante
- ✓ Collaborazione continua con l'équipe
- ✓ Attenzione ai tessuti irradiati

Errori da evitare

- ! Forzare tessuti irradiati
- ! Trattare senza autorizzazione
- ! Ignorare segni di recidiva o infezione

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Allungamento frequente	Apertura assistita con abbassalingua	5 x 30 secondi, 5 volte al giorno

! **Nota clinica.** Nuovi sintomi, tumefazioni o peggioramento rapido vanno segnalati subito all'équipe oncologica.

Bibliografia essenziale

1. Lobbezoo F. et al. International consensus on the assessment of bruxism: report of a work in progress. J Oral Rehabil. 2018;45(11):837–844.
2. Michiels S. et al. Diagnostic criteria for somatosensory tinnitus: a Delphi process and face-to-face meeting to establish consensus. Trends Hear. 2018;22:2331216518796403.

PROTOCOLLO 95

DTM in età adolescenziale

Adattare valutazione e trattamento ai pazienti adolescenti

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	DTM negli adolescenti	20 a 30 minuti	1 o 2 sedute a settimana

Indicazioni

- ✓ Dolore mandibolare in adolescente
- ✓ Parafunzioni legate a studio e smartphone
- ✓ Trattamento ortodontico in corso o recente

Controindicazioni e precauzioni

- ! Red flags non escluse dal medico
- ! Peggioramento rapido e non spiegato dei sintomi
- ! Condizioni sistemiche non controllate
- ! Assenza di consenso informato del paziente

Posizionamento

Paziente: seduto o supino secondo la fase.

Fisioterapista: di fronte al paziente.

Esecuzione passo dopo passo



Consenso
Coinvolgi i genitori e ottieni il consenso di entrambi.



Valutazione
Esame DC/TMD semplificato e fattori di vita.



Educazione
Linguaggio semplice, strumenti visivi, obiettivi motivanti.



Programma
Esercizi brevi e promemoria digitali.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Sedute	4 a 6
Esercizi	massimo 3, 5 minuti al giorno
Coinvolgimento	famiglia e ortodontista

Criteri di rivalutazione

LIMITAZIONE FUNZIONALE
____ / 10
masticare, parlare, sbadigliare

DOLORE (NRS)
____ / 10
peggiore della settimana

ADERENZA
____ %
esercizi svolti a casa

Punti chiave

- ✓ Coinvolgi la famiglia
- ✓ Programmi brevi e motivanti
- ✓ Collabora con l'ortodontista

Errori da evitare

- ! Programmi lunghi e complessi
- ! Trascurare stress scolastico e sonno
- ! Trattare senza il consenso dei genitori

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Sfida dei promemoria	Controllo della posizione di riposo con un'app di promemoria	ogni ora durante lo studio

! **Nota clinica.** Negli adolescenti i DTM sono spesso lievi e rispondono bene a educazione ed esercizio.

Bibliografia essenziale

1. Lobbezoo F. et al. International consensus on the assessment of bruxism: report of a work in progress. J Oral Rehabil. 2018;45(11):837–844.
2. Michiels S. et al. Diagnostic criteria for somatosensory tinnitus: a Delphi process and face-to-face meeting to establish consensus. Trends Hear. 2018;22:2331216518796403.

PROTOCOLLO 96

DTM durante il trattamento ortodontico

Gestire i sintomi mandibolari in collaborazione con l'ortodontista

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	DTM e ortodonzia	20 a 30 minuti	1 o 2 sedute a settimana

Indicazioni

- ✓ Dolore mandibolare durante il trattamento ortodontico
- ✓ Click comparso durante la terapia
- ✓ Invio da parte dell'ortodontista

Controindicazioni e precauzioni

- ! Red flags non escluse dal medico
- ! Peggioramento rapido e non spiegato dei sintomi
- ! Condizioni sistemiche non controllate
- ! Assenza di consenso informato del paziente

Posizionamento

Paziente: seduto o supino secondo la fase.

Fisioterapista: di fronte al paziente.

Esecuzione passo dopo passo



Comunicazione
Confronto con l'ortodontista sulla fase del trattamento.



Valutazione
Esame DC/TMD e misure di base.



Gestione
Autogestione, terapia miofasciale ed esercizio.



Monitoraggio
Aggiornamento periodico all'ortodontista.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Sedute	4 a 6
Aggiornamento	ogni 4 sedute
Esercizio	quotidiano

Criteri di rivalutazione

LIMITAZIONE FUNZIONALE
____ / 10
masticare, parlare, sbadigliare

DOLORE (NRS)
____ / 10
peggiore della settimana

ADERENZA
____ %
esercizi svolti a casa

Punti chiave

- ✓ Il fisioterapista non modifica il piano ortodontico
- ✓ Comunicazione regolare
- ✓ Rassicura il paziente

Errori da evitare

- ! Attribuire il problema all'ortodonzia senza dati
- ! Interrompere il dialogo con il collega
- ! Ignorare il dolore ai denti

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Rilassamento quotidiano	Posizione di riposo ed esercizi di apertura controllata	2 volte al giorno

! **Nota clinica.** La collaborazione tra fisioterapista e ortodontista migliora il comfort e l'aderenza del paziente.

Bibliografia essenziale

1. Lobbezoo F. et al. International consensus on the assessment of bruxism: report of a work in progress. J Oral Rehabil. 2018;45(11):837–844.
2. Michiels S. et al. Diagnostic criteria for somatosensory tinnitus: a Delphi process and face-to-face meeting to establish consensus. Trends Hear. 2018;22:2331216518796403.

PROTOCOLLO 97

Riconoscere il dolore orofacciale neuropatico

Identificare i segni che orientano verso un dolore non muscoloscheletrico

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	Diagnosi differenziale	10 a 15 minuti	Valutazione

Indicazioni

- ✓ Dolore bruciante, a scossa o elettrico
- ✓ Dolore spontaneo non legato alla funzione
- ✓ Mancata risposta al trattamento

Controindicazioni e precauzioni

- ! Red flags non escluse dal medico
- ! Peggioramento rapido e non spiegato dei sintomi
- ! Condizioni sistemiche non controllate
- ! Assenza di consenso informato del paziente

Posizionamento

Paziente: seduto o supino secondo la fase.

Fisioterapista: di fronte al paziente.

Esecuzione passo dopo passo



Descrittori

Chiedi bruciore, scosse, formicolio, punti trigger cutanei.



Esame

Valuta la sensibilità del volto e i nervi cranici.



Relazione con la funzione

Il dolore neuropatico non segue la funzione mandibolare.



Invio

Invia al neurologo o all'algologo.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Tempo	10 minuti
Strumento	checklist dei descrittori
Decisione	invio specialistico

Criteri di rivalutazione

LIMITAZIONE FUNZIONALE
____ / 10
masticare, parlare, sbadigliare

DOLORE (NRS)
____ / 10
peggiore della settimana

ADERENZA
____ %
esercizi svolti a casa

Punti chiave

- ✓ Ascolta le parole del paziente
- ✓ Il dolore a scossa scatenato dal tocco suggerisce una nevralgia
- ✓ Documenta e invia

Errori da evitare

- ! Trattare a lungo senza risultati
- ! Attribuire tutto ai DTM
- ! Ritardare l'invio

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Diario dei descrittori	Annotare tipo di dolore, durata e fattori scatenanti	per 1 settimana

! **Nota clinica.** Nevralgia trigeminale e dolore neuropatico post traumatico richiedono una gestione medica specialistica.

Bibliografia essenziale

1. Lobbezoo F. et al. International consensus on the assessment of bruxism: report of a work in progress. J Oral Rehabil. 2018;45(11):837–844.
2. Michiels S. et al. Diagnostic criteria for somatosensory tinnitus: a Delphi process and face-to-face meeting to establish consensus. Trends Hear. 2018;22:2331216518796403.

PROTOCOLLO 98

Gestione della riacutizzazione

Pianificare cosa fare quando il dolore ritorna

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	Riacutizzazione dei sintomi	20 a 30 minuti	1 o 2 sedute a settimana

Indicazioni

- ✓ Ritorno del dolore dopo un periodo di benessere
- ✓ Periodi di stress o cure dentali
- ✓ Paziente vicino alla dimissione

Controindicazioni e precauzioni

- ! Red flags non escluse dal medico
- ! Peggioramento rapido e non spiegato dei sintomi
- ! Condizioni sistemiche non controllate
- ! Assenza di consenso informato del paziente

Posizionamento

Paziente: seduto o supino secondo la fase.

Fisioterapista: di fronte al paziente.

Esecuzione passo dopo passo



Riconoscimento
Identifica i segnali precoci con il paziente.



Piano
Scrivi un piano di 72 ore: dieta morbida, calore o freddo, esercizi dolci.



Monitoraggio
Se dopo 1 o 2 settimane non migliora, contatta il fisioterapista.



Revisione
Analizza i fattori scatenanti.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Piano	72 ore
Contatto	dopo 1 o 2 settimane senza miglioramento
Strumento	scheda scritta

Criteri di rivalutazione

LIMITAZIONE FUNZIONALE	DOLORE (NRS)	ADERENZA
____ / 10	____ / 10	____ %
masticare, parlare, sbadigliare	peggiore della settimana	esercizi svolti a casa

Punti chiave

- ✓ Le riacutizzazioni sono normali e gestibili
- ✓ Il paziente diventa autonomo
- ✓ Piano scritto e personalizzato

Errori da evitare

- ! Interpretare la riacutizzazione come fallimento
- ! Riposo assoluto prolungato
- ! Abbandonare gli esercizi

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Piano di riacutizzazione	Seguire le 72 ore del piano personale	quando i sintomi tornano

! **Nota clinica.** Un piano di riacutizzazione riduce l'ansia e i ritorni non necessari in studio.

Bibliografia essenziale

1. Lobbezoo F. et al. International consensus on the assessment of bruxism: report of a work in progress. J Oral Rehabil. 2018;45(11):837–844.
2. Michiels S. et al. Diagnostic criteria for somatosensory tinnitus: a Delphi process and face-to-face meeting to establish consensus. Trends Hear. 2018;22:2331216518796403.

PROTOCOLLO 99

Collaborazione per la placca occlusale

Integrare il dispositivo prescritto dall'odontoiatra con il trattamento fisioterapico

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	DTM con placca occlusale	20 a 30 minuti	1 o 2 sedute a settimana

Indicazioni

- ✓ Paziente con placca occlusale prescritta
- ✓ Dolore persistente nonostante il dispositivo
- ✓ Bruxismo nel sonno

Controindicazioni e precauzioni

- ! Red flags non escluse dal medico
- ! Peggioramento rapido e non spiegato dei sintomi
- ! Condizioni sistemiche non controllate
- ! Assenza di consenso informato del paziente

Posizionamento

Paziente: seduto o supino secondo la fase.

Fisioterapista: di fronte al paziente.

Esecuzione passo dopo passo



Informazione
Chiedi tipo di dispositivo, orari di utilizzo e controlli previsti.



Verifica
Controlla aderenza e sintomi al risveglio.



Integrazione
Esercizi e terapia manuale complementari.



Comunicazione
Segnala all'odontoiatra fastidi o cambiamenti del morso.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Controllo	a ogni seduta
Comunicazione	ogni 4 sedute
Esercizio	quotidiano

Criteri di rivalutazione

LIMITAZIONE FUNZIONALE
____ / 10
masticare, parlare, sbadigliare

DOLORE (NRS)
____ / 10
peggiore della settimana

ADERENZA
____ %
esercizi svolti a casa

Punti chiave

- ✓ La placca è competenza dell'odontoiatra
- ✓ Il trattamento è complementare
- ✓ Monitora cambiamenti occlusali

Errori da evitare

- ! Consigliare modifiche al dispositivo
- ! Ignorare un nuovo fastidio occlusale
- ! Considerare la placca come unica terapia

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Routine del mattino	Esercizi di rilassamento dopo aver tolto la placca	ogni mattina

! **Nota clinica.** Un approccio integrato tra dispositivo, esercizio ed educazione offre i risultati migliori.

Bibliografia essenziale

1. Lobbezoo F. et al. International consensus on the assessment of bruxism: report of a work in progress. J Oral Rehabil. 2018;45(11):837–844.
2. Michiels S. et al. Diagnostic criteria for somatosensory tinnitus: a Delphi process and face-to-face meeting to establish consensus. Trends Hear. 2018;22:2331216518796403.

PROTOCOLLO 100

DTM nei musicisti e nei professionisti della voce

Gestire il carico mandibolare nelle attività professionali specifiche

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	DTM da sovraccarico professionale	20 a 30 minuti	1 o 2 sedute a settimana

Indicazioni

- ✓ Strumentisti a fiato, violinisti, cantanti, insegnanti
- ✓ Dolore legato alle ore di attività
- ✓ Postura mantenuta a lungo

Controindicazioni e precauzioni

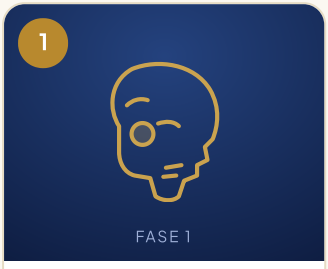
- ! Red flags non escluse dal medico
- ! Peggioramento rapido e non spiegato dei sintomi
- ! Condizioni sistemiche non controllate
- ! Assenza di consenso informato del paziente

Posizionamento

Paziente: seduto o supino secondo la fase.

Fisioterapista: di fronte al paziente.

Esecuzione passo dopo passo



Analisi
Osserva la postura e l'attività professionale reale.



Carico
Pianifica pause e gradualità delle sessioni.



Trattamento
Terapia miofasciale e cervicale mirata.



Esercizio
Riscaldamento e defaticamento mandibolare.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Pause	ogni 25 a 30 minuti di attività
Riscaldamento	5 minuti
Rivalutazione	ogni 4 sedute

Criteri di rivalutazione

LIMITAZIONE FUNZIONALE
____ / 10
masticare, parlare, sbadigliare

DOLORE (NRS)
____ / 10
peggiore della settimana

ADERENZA
____ %
esercizi svolti a casa

Punti chiave

- ✓ Rispetta le esigenze professionali
- ✓ Coinvolgi l'insegnante dello strumento o del canto
- ✓ Programmi brevi pre e post attività

Errori da evitare

- ! Consigliare di smettere l'attività
- ! Ignorare la postura dello strumento
- ! Trascurare il collo e le spalle

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Riscaldamento mandibolare	Aperture, lateralità lente e respirazione prima dell'attività	5 minuti prima di suonare o parlare

! **Nota clinica.** La gestione del carico permette di continuare l'attività professionale riducendo il dolore.

Bibliografia essenziale

1. Lobbezoo F. et al. International consensus on the assessment of bruxism: report of a work in progress. J Oral Rehabil. 2018;45(11):837–844.
2. Michiels S. et al. Diagnostic criteria for somatosensory tinnitus: a Delphi process and face-to-face meeting to establish consensus. Trends Hear. 2018;22:2331216518796403.

PROTOCOLLO 101

Dimissione e prevenzione delle recidive

Concludere il percorso rendendo il paziente autonomo

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	Tutti i quadri	20 minuti	Ultima seduta

Indicazioni

- ✓ Obiettivi raggiunti
- ✓ Dolore stabile e gestibile
- ✓ Programma domiciliare consolidato

Controindicazioni e precauzioni

- ! Red flags non escluse dal medico
- ! Peggioramento rapido e non spiegato dei sintomi
- ! Condizioni sistemiche non controllate
- ! Assenza di consenso informato del paziente

Posizionamento

Paziente: seduto o supino secondo la fase.

Fisioterapista: di fronte al paziente.

Esecuzione passo dopo passo

1



FASE 1

Rivalutazione finale

Confronta le misure con quelle iniziali.

2



FASE 2

Programma di mantenimento

3 esercizi essenziali da continuare.

3



FASE 3

Piano di riacutizzazione

Consegna la scheda scritta.

4



FASE 4

Follow-up

Programma un controllo a 1 o 3 mesi.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Mantenimento	5 minuti al giorno
Controllo	a 1 o 3 mesi
Documentazione	relazione finale

Criteri di rivalutazione

LIMITAZIONE FUNZIONALE
____ / 10
masticare, parlare, sbadigliare

DOLORE (NRS)
____ / 10
peggiore della settimana

ADERENZA
____ %
esercizi svolti a casa

Punti chiave

- ✓ Celebra i progressi con il paziente
- ✓ Lascia strumenti concreti
- ✓ Comunica l'esito ai colleghi coinvolti

Errori da evitare

- ! Dimissione senza programma
- ! Assenza di follow-up
- ! Non documentare i risultati

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Programma di mantenimento	I 3 esercizi scelti insieme	5 minuti al giorno

! **Nota clinica.** Una dimissione ben strutturata riduce le recidive e rafforza la fiducia del paziente.

Bibliografia essenziale

1. Lobbezoo F. et al. International consensus on the assessment of bruxism: report of a work in progress. J Oral Rehabil. 2018;45(11):837–844.
2. Michiels S. et al. Diagnostic criteria for somatosensory tinnitus: a Delphi process and face-to-face meeting to establish consensus. Trends Hear. 2018;22:2331216518796403.